

Handicap, autonomie et travail social

Module de formation — Bachelor en Travail social, 2^e année

Pierre Brasseur

1 janvier 2026

1 Handicap, autonomie et travail social

Module Bachelor Travail social · 2ème année · HETS Genève / HES-SO

Arc narratif

Ce module part d'une tension productive : **comment les sociétés ont-elles pensé, traité et organisé la vie des personnes handicapées** ? Et comment ces transformations — loin d'être achevées — redéfinissent-elles chaque jour le rôle du·de la travailleur·euse social·e ?

Il ne s'agit pas d'apporter des réponses définitives, mais de fournir des **cadres** — théoriques, juridiques, empiriques — pour agir avec réflexivité dans un champ en mutation.

Structure du module

Objectifs généraux

Le fil narrateur : Maria

Approche pédagogique

Chaque séance articule **trois temps** :

Temps	Durée	Format
Apport conceptuel	~60 min	Cours magistral interactif
Ancrage droit & pratique	~60 min	Analyse de dispositifs, lecture
Activité	~60 min	Débat, jeu de rôle, étude de cas

Les vignettes ne sont pas des cas à *résoudre* — ce sont des situations à *analyser*. Elles sont délibérément incomplètes : leur fonction est de susciter des questions, pas de fournir des réponses.

Évaluation

Dossier d'analyse de situation (12 000–15 000 signes) — remis en fin de module et restitué oralement à la séance 12.

L'étudiant·e :

- choisit une situation issue de son stage ou de son expérience
- l'analyse à l'aide d'au moins **trois cadres théoriques** du module
- identifie les **tensions de posture** à l'œuvre
- propose des pistes d'intervention réflexive

La restitution orale donne lieu à une discussion collective.

Première partie

Partie I — Fondements

2 Séance 1 — Qu'est-ce que le handicap ?

Enjeux, chiffres, définitions

[Diapositives de la séance](#) [Version PDF du cours](#)

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, l'étudiant-e est capable de :

- Distinguer les trois niveaux de la Classification internationale du fonctionnement (CIF) de l'OMS
- Restituer la définition légale du handicap selon la LHand suisse (art. 2 al. 1)
- Identifier au moins deux biais de méthode dans les statistiques du handicap
- Définir le validisme (*ableism*) et son lien avec la production sociale du handicap
- Amorcer une réflexion sur la nature construite des catégories de classement

2.1 Introduction

Qu'est-ce qu'un handicap ? La question paraît simple. Elle ne l'est pas. Derrière les chiffres officiels, les définitions légales et les catégories médicales se cachent des choix — des choix sur ce qui compte, sur qui est visible, sur ce qu'une société juge « normal » ou « déviant ». Ce module commence ici : non pas avec une définition à retenir, mais avec l'invitation à regarder de près ce que produisent les pratiques de classement.

Cette séance introductive a un double objectif. D'abord, fournir les outils conceptuels de base — la triade OMS, la définition légale suisse, les ordres de grandeur statistiques. Ensuite, dès la première heure, introduire le geste intellectuel qui traversera tout le module : **déconstruire l'évidence**. Le handicap n'est pas une donnée naturelle inscrite dans les corps. Il est produit, délimité et parfois effacé par des pratiques sociales, juridiques et médicales.

Un même corps peut être handicapé ou non selon l'époque, le pays, la classe sociale et l'environnement technique disponible. La myopie est un handicap pour un pilote de chasse, pas pour un comptable équipé de lunettes. Une surdité profonde est vécue comme une identité culturelle par

2 Séance 1 — Qu'est-ce que le handicap ?

une partie de la communauté sourde, non comme un manque à combler. Ces exemples ne sont pas anecdotiques : ils montrent que la catégorie « handicap » est relationnelle, contextuelle, et donc politique.

2.2 La CIF : trois niveaux pour penser le handicap

La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), adoptée par l'OMS en 2001, est l'outil de référence international. Elle propose une lecture à trois niveaux articulés :

La déficience désigne toute perte ou anomalie d'une structure ou d'une fonction corporelle (physiologique ou psychologique). Elle se situe au niveau de l'organe ou du système. Exemple : une lésion médullaire, une dépression sévère, une perte auditive.

La limitation d'activité renvoie aux difficultés qu'une personne peut rencontrer dans l'exécution de certaines activités — marcher, lire, communiquer. Elle se situe au niveau de la personne.

La restriction de participation décrit les problèmes qu'une personne peut rencontrer dans des situations de vie réelle — emploi, vie associative, scolarité, relations sociales. Elle se situe à l'interface entre la personne et son environnement.

Ce troisième niveau est décisif : il reconnaît que le désavantage vécu par une personne n'est pas seulement fonction de sa déficience, mais aussi des obstacles ou des facilitateurs que l'environnement produit. Une personne en fauteuil roulant dans une ville entièrement accessible connaît moins de restrictions de participation qu'une même personne dans une ville sans rampes ni transports adaptés. L'environnement fait partie de l'équation.

La CIF représente un progrès par rapport à la classification de 1980 (CIDIH), qui limitait le regard à la chaîne déficience-incapacité-désavantage, sans intégrer le rôle des contextes. Elle n'est pas pour autant sans critique — nous y reviendrons à la séance 5 avec la lecture de Rob Imrie (2004), qui montre que la CIF maintient une normativité médicale sous ses habits biopsychosociaux.

2.2.1 Les trois générations de définitions

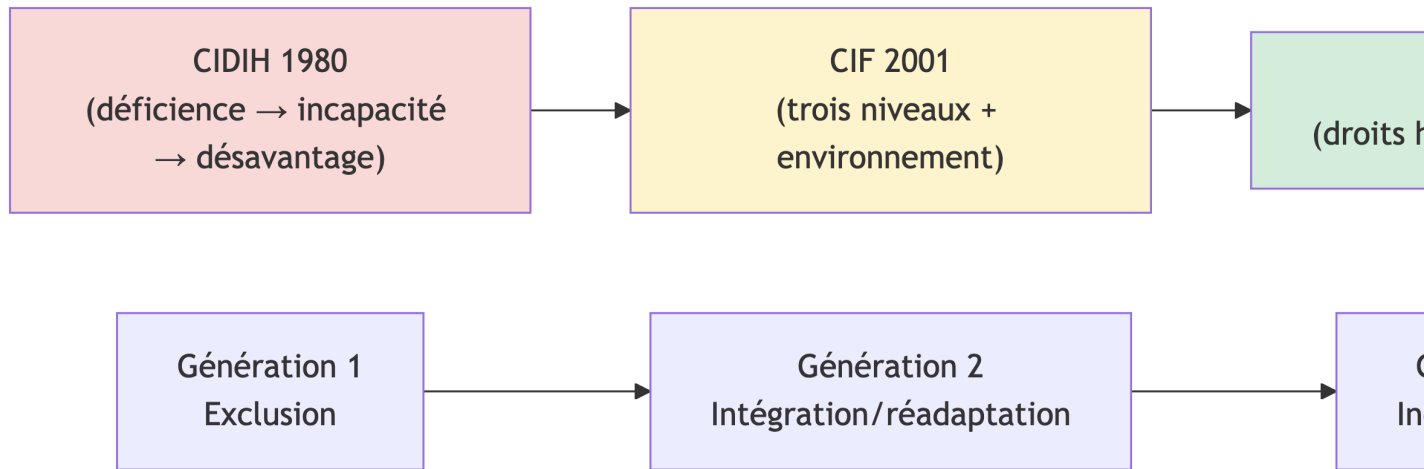
L'histoire des définitions du handicap peut se lire comme trois générations successives de réponses collectives :

Première génération — l'exclusion : le handicap justifie la mise à l'écart. La personne handicapée est inemployable, dangereuse ou objet de pitié. La réponse est l'asile, l'institution fermée (voir séance 2).

Deuxième génération — l'intégration : la personne handicapée peut rejoindre la société ordinaire à condition d'être « normalisée » — rééduquée, appareillée, adaptée. La réponse est la réadaptation. L'objectif implicite reste la conformité à la norme valide.

Troisième génération — l'inclusion : c'est la société qui doit se transformer pour accueillir la diversité des corps et des fonctionnements. La réponse est l'accessibilité universelle, les droits

et l'autodétermination. La CIF et la CDPH s'inscrivent dans cette troisième génération — même si les pratiques réelles n'ont pas toujours rattrapé les textes.



2.3 La définition légale suisse : la LHand 2004

En droit suisse, la Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand, RS 151.3), entrée en vigueur en 2004, donne la définition de référence. L'article 2 alinéa 1 stipule :

! Définition légale — LHand art. 2 al. 1

Est considérée comme personne handicapée toute personne qui souffre d'une **déficience durable**, résultant d'une **atteinte à la santé physique, mentale ou psychique**, et dont cette déficience rend difficile ou impossible **l'accomplissement des activités de la vie courante**, la participation à la vie sociale, la prise en charge des soins personnels, la formation, le travail ou les loisirs.

Plusieurs éléments méritent attention. Le critère de durée (« durable ») exclut les atteintes temporaires. La tripartition physique/mentale/psychique correspond aux grandes catégories cliniques mais ne coïncide pas exactement avec les niveaux de la CIF. La formule « rend difficile ou impossible » introduit une gradation : le handicap n'est pas une catégorie binaire. Enfin, la liste des domaines (vie courante, vie sociale, soins, formation, travail, loisirs) ancre la définition dans la participation — ce qui rapproche la LHand de la logique CIF.

Cette définition est **fonctionnelle** : elle ne détermine pas qui « est » handicapé dans un sens ontologique, mais qui peut bénéficier des protections légales. C'est une définition à visée juridique, pas médicale. Elle doit être distinguée des définitions opérationnelles utilisées par les assurances (AI, APG, assurance-maladie), qui appliquent des critères souvent plus restrictifs, liés à la capacité de travail résiduelle plutôt qu'à la participation sociale.

2.4 Les statistiques du handicap en Suisse : qui compte, qui est invisible ?

L'Office fédéral de la statistique (OFS) publie régulièrement des données sur l'égalité des personnes handicapées. Selon l'enquête suisse sur la santé (ESS), environ **22 % de la population résidant en Suisse** déclare souffrir d'une limitation durable dans ses activités au sens de la LHand (OFS, 2021). Ce chiffre est souvent cité dans les médias avec un commentaire sur le « nombre de Suisses handicapés ».

Ce chiffre mérite un regard critique. Il repose sur une enquête auprès des **ménages privés** — ce qui exclut d'emblée les personnes vivant en institution (environ 150 000 personnes selon l'OFS), en EMS, en structures résidentielles pour personnes handicapées. Or, ce sont précisément les personnes aux situations les plus sévères qui résident le plus souvent hors des ménages privés. Le 22 % est donc structurellement sous-estimé pour les formes les plus intenses de handicap. **Les personnes les plus dépendantes sont invisibles dans les statistiques.**

Un second biais tient à l'**autodéclaration** : la personne décide elle-même si elle se reconnaît dans la définition proposée. Des effets de stigmatisme peuvent conduire à la sous-déclaration ; des variations de compréhension du questionnaire peuvent produire de faux positifs ou de faux négatifs. La déclaration est aussi influencée par le contexte national : des études comparatives montrent que les taux varient significativement selon les pays, non en raison de différences réelles de prévalence, mais de différences dans les questionnaires et les cultures de la déclaration (Ville et al., 2014).

Enfin, les statistiques agrègent des situations extrêmement hétérogènes : une personne mal-entendante appareillée qui travaille à temps plein et une personne polyhandicapée en grande dépendance sont toutes deux « handicapées » au sens statistique. Cette homogénéisation masque des inégalités internes au groupe — entre les handicaps visibles et invisibles, entre les déficiences cognitives et physiques, entre les formes acquises et congénitales.

2.5 La production sociale du handicap

Ville, Fillion et Ravaud (2014) proposent le concept de **production sociale du handicap** pour désigner le processus par lequel des corps, des fonctionnements et des comportements sont catégorisés, évalués et traités différemment selon les sociétés et les époques. Le handicap n'est pas inscrit dans les corps comme une vérité naturelle : il est produit par des pratiques de classement.

Cela ne signifie pas que la douleur, la fatigue ou les limitations fonctionnelles sont imaginaires — nous y reviendrons à la séance 3 avec la critique de Shakespeare et de Hughes & Paterson. Cela signifie que le **statut social** attaché à ces réalités corporelles — qui est aidé, qui est exclu, qui est protégé, qui est invisible — résulte de choix collectifs, modifiables.

2.5.1 Le validisme : un système de normes

Le concept de **validisme** (*ableism* en anglais) désigne le système de croyances et de pratiques qui valorise certains corps, certains fonctionnements et certaines capacités, et qui dévalorise, marginalise ou efface les autres. C'est l'équivalent, dans le champ du handicap, du sexisme ou du racisme : une norme érigée en universelle qui produit des hiérarchies et des exclusions.

Le validisme n'est pas toujours intentionnel. Il se manifeste dans les représentations culturelles (les personnes handicapées comme objets de pitié, d'inspiration ou d'héroïsme), dans les environnements conçus pour un corps-standard, dans les politiques d'activation qui présupposent qu'une « bonne vie » est une vie productive. Pour le travail social, identifier le validisme dans ses propres pratiques — dans les objectifs qu'on fixe, les questions qu'on pose, les succès qu'on valorise — est une dimension essentielle de la réflexivité professionnelle (voir séance 4).

Vignette — Déconstruire un chiffre

Un article de presse titre : « Près d'un Suisse sur cinq est handicapé — les coûts explosent ». En lisant l'article, on découvre que le chiffre provient de l'ESS 2021 et désigne toute personne déclarant une limitation durable. L'article ne mentionne ni les biais de méthode, ni l'exclusion des personnes en institution, ni les disparités internes. Les personnes concernées ne sont pas citées.

Question de travail : Comment ce titre construit-il une représentation du handicap ? Repérez (1) le choix du registre économique (« les coûts »), (2) l'absence de voix des personnes concernées, (3) ce que ce cadrage implique pour les politiques publiques. Quelles autres façons de présenter les mêmes données auraient produit un autre sens ?

2.6 Tensions pour la pratique professionnelle

Tension à tenir

Le travailleur ou la travailleuse sociale opère avec des catégories administratives (AI, LHand, OPAS) qui décident de l'accès aux prestations. Ces catégories ne coïncident pas toujours avec l'expérience vécue des personnes. Tenir cette tension, c'est utiliser les catégories disponibles sans les réifier — sans oublier ce qu'elles laissent de côté. C'est aussi résister au validisme implicite des outils d'évaluation qui mesurent des manques plutôt que des potentiels.

À retenir

- La CIF (OMS, 2001) articule trois niveaux : déficience (corps), limitation d'activité (personne), restriction de participation (société + environnement). C'est le troisième

- niveau qui est décisif pour le travail social.
- La LHand suisse propose une définition fonctionnelle et juridique du handicap, ancrée dans la participation à la vie courante, sociale et professionnelle.
- 22 % de la population suisse déclare un handicap, mais ce chiffre exclut les 150 000 personnes en institution — les plus invisibles dans les données.
- Le validisme est le système de normes qui valorise certains corps et dévalorise les autres ; le travail social en est traversé comme toute institution sociale.
- Le handicap est une catégorie produite socialement : même corps, statut différent selon l'époque, le pays, la classe sociale et l'environnement.

2.7 Concepts-clés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Déficiences	Perte ou anomalie d'une structure ou fonction corporelle	OMS, CIF 2001	Ne pas confondre le niveau du corps avec celui de la participation
Limitation d'activité	Difficulté dans l'exécution de tâches	OMS, CIF 2001	Évaluer dans des conditions réelles, pas en cabinet
Restriction de participation	Problème dans des situations de vie réelle	OMS, CIF 2001	Cible prioritaire de l'intervention sociale
Handicap (LHand)	Déficiences durables rendant difficile la vie courante	LHand art. 2 al. 1, 2004	Critère d'accès aux droits et prestations suisses
Production sociale du handicap	Le handicap est construit par des pratiques de classement	Ville, Fillion & Ravaud, 2014	Questionner les catégories administratives qu'on utilise

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Validisme (<i>ableism</i>)	Système de normes valorisant certains corps et dévalorisent les autres	Littérature disability studies	Identifier ses propres présupposés sur la « vie normale »
Trois générations de définitions	Exclusion → intégration → inclusion	Ravaud & Stiker, 2000	Situer son dispositif dans quelle génération de réponse

Questions de réflexion

1. Un·e collègue vous dit : « On a 22 % de handicapés en Suisse, c'est énorme. » Comment lui répondez-vous en mobilisant les biais de méthode que vous venez d'étudier ?
2. Pensez à un dispositif que vous connaissez (stage, bénévolat, observation). À quelle génération de définitions du handicap correspond-il — exclusion, intégration ou inclusion ? Qu'est-ce qui vous permet de le situer ?
3. Le validisme peut s'exprimer dans le travail social par des objectifs implicitement normalisateurs (« l'aider à travailler », « l'aider à être autonome »). Quels exemples concrets d'objectifs validistes avez-vous rencontrés ou pouvez-vous imaginer ?
4. Si la myopie n'est généralement pas un « handicap » en Suisse aujourd'hui, dans quelles conditions pourrait-elle le devenir ? Qu'est-ce que ce raisonnement révèle sur la nature de la catégorie ?

Activité pédagogique

Brainstorming — « Ce qu'évoque le mot handicap » · Collectif · 20 min

2.7.1 Consignes

1. En **silence** (3 min) : chaque étudiant·e écrit sur un Post-it les 3 premiers mots qui lui viennent à l'esprit à l'évocation du mot « handicap ».
2. Les Post-its sont placés au tableau. Un·e volontaire les lit à voix haute.
3. Le groupe les **catégorise** collectivement en colonnes : représentations médicales / morales / juridiques / émotionnelles / autres.
4. **Discussion** (10 min) : quelles représentations dominent ? Lesquelles sont absentes ? Y a-t-il des mots surprenants ?

2 Séance 1 — Qu'est-ce que le handicap ?

2.7.2 Débriefing

- Combien de mots évoquent les **droits ou la citoyenneté** versus les **soins ou la pitié** ?
- Est-ce que le mot « risque » est apparu ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
- Quels mots n'ont *pas* été écrits — et que dit leur absence ?
- Ce premier relevé servira de **point de comparaison à la séance 12** — il sera relu à la fin du module pour mesurer l'évolution du regard des étudiant-e-s.

2.7.3 Variante en ligne

Si la séance se tient à distance : utiliser [Mentimeter](#) (nuage de mots) ou [Wooclap](#). Projeter le nuage en direct, annoter collectivement les catégories dans un document partagé.

Pour aller plus loin

2.7.1 Lectures obligatoires

- Ville, I., Fillion, E. & Ravaud, J.-F. (2014). *Introduction à la sociologie du handicap. Histoire, politiques et expérience*. De Boeck. Introduction, pp. 1-30.
- Office fédéral de la statistique (2021). *Égalité pour les personnes handicapées — Résultats de l'enquête suisse sur la santé*. OFS, Neuchâtel.

2.7.2 Lectures complémentaires

- Ravaud, J.-F. & Stiker, H.-J. (2000). Les modèles de l'inclusion et de l'exclusion sociale mis à l'épreuve du handicap. *Handicap — Revue de sciences humaines et sociales*, 86, 1-18.
- Organisation mondiale de la santé (2001). *Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF)*. OMS, Genève. (Présentation générale.)
- Campbell, F. K. (2009). *Contours of Ableism. The Production of Disability and Aabledness*. Palgrave Macmillan. Chap. 1.

2.7.3 Ressources en ligne

- [OFS — Handicap et égalité](#) — données suisses actualisées
- [OMS — CIF en ligne](#) — version officielle et navigateur CIF
- [Disability Studies Quarterly](#) — revue académique en accès libre

3 Séance 2 — Histoire longue de la prise en charge

De l'asile à l'institution

[Diapositives de la séance](#) [Version PDF du cours](#)

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, l'étudiant-e est capable de :

- Décrire les six caractéristiques d'une institution totale au sens de Goffman et la notion de carrière morale
- Articuler la lecture foucaldienne du biopouvoir avec la question du handicap
- Situer la réadaptation comme horizon normatif dans l'analyse de Stiker, en lien avec les mutilés de guerre
- Identifier le rôle des internements administratifs suisses dans l'histoire nationale du handicap
- Relier l'histoire institutionnelle aux enjeux actuels de désinstitutionnalisation

3.1 Introduction

Pour comprendre ce que le travail social fait aujourd'hui, il faut savoir ce qu'il a fait hier. L'histoire longue de la prise en charge des personnes handicapées n'est pas une suite de progrès linéaires. C'est une histoire d'enfermements, de bonnes intentions, de classifications et de normalisations qui ont produit des souffrances réelles — documentées, tardives à reconnaître, et dont les effets se lisent encore dans les dispositifs actuels.

Cette séance ne se veut pas accusatoire : elle vise à comprendre les logiques qui ont rendu les pratiques passées possibles, légitimes, voire bienveillantes aux yeux de leurs acteurs. Car c'est précisément cette leçon qui importe pour le présent : les logiques de protection peuvent produire des effets d'exclusion, et ce sans mauvaise volonté. L'histoire institutionnelle est un **analyseur**

de nos pratiques présentes — et nous y reviendrons à la séance 6, quand nous examinerons la désinstitutionnalisation.

3.2 L'institution totale : Goffman et la mortification du moi

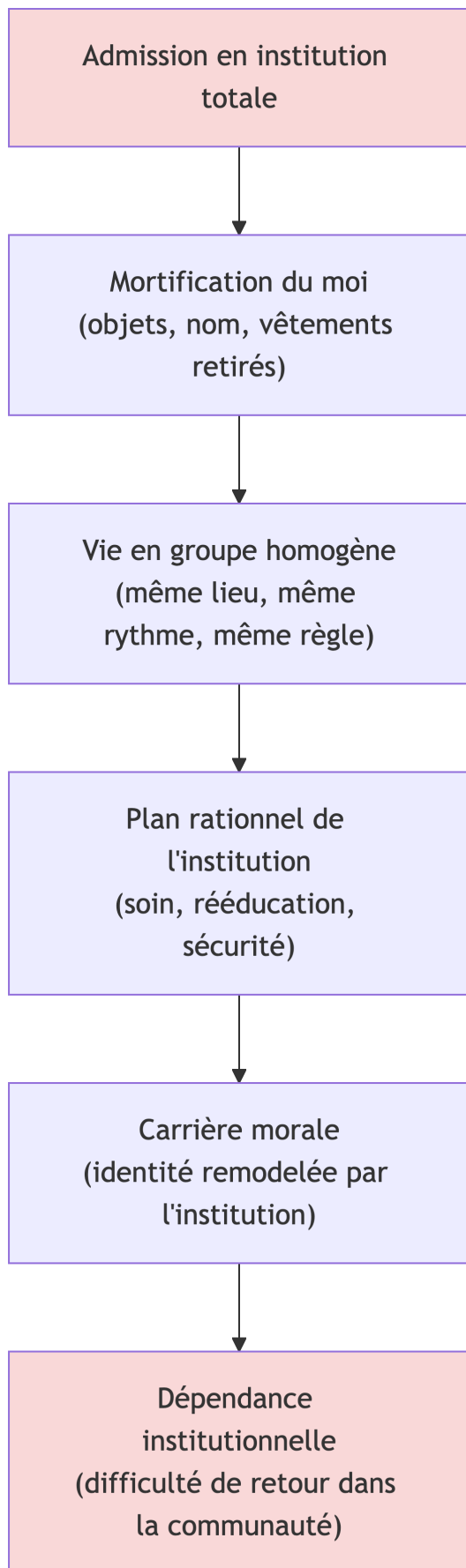
En 1961, Erving Goffman publie *Asylums*, une enquête ethnographique menée dans un hôpital psychiatrique fédéral américain. Il y forge le concept d'**institution totale** : une organisation qui prend en charge tous les aspects de la vie de ses membres — sommeil, alimentation, travail, loisirs — dans un même lieu clos, selon un système autoritaire unique.

Goffman identifie **six caractéristiques** qui définissent l'institution totale :

1. **La rupture avec le monde extérieur** : murs, horaires, permissions, correspondances contrôlées. La personne est séparée de sa vie antérieure.
2. **La vie en groupe homogène** : toutes les activités s'effectuent au même endroit et en même temps, avec le même groupe de personnes traitées pareillement.
3. **L'autorité unique** : un personnel distinct gère le groupe selon un règlement uniforme, sans que les individus participent aux décisions.
4. **Le plan rationnel** : chaque activité est planifiée selon les objectifs officiels de l'institution (soin, rééducation, sécurité).
5. **La mortification du moi** : dès l'admission, la personne est dépossédée de ses marqueurs identitaires — nom remplacé par un numéro, vêtements confisqués, objets personnels retirés, relations extérieures limitées. Elle est soumise à des épreuves de dégradation symbolique.
6. **La carrière morale** : l'institution ne se contente pas de gérer des corps ; elle façonne une identité. Le processus d'admission inaugure un parcours de redéfinition de soi imposée par le regard institutionnel — ce que la personne est, ce qu'elle peut espérer être, comment elle doit se comporter pour obtenir des privilèges ou éviter des sanctions.

La notion de **carrière morale** est particulièrement décisive pour le travail social. Elle montre que l'institution ne produit pas seulement des contraintes physiques — elle produit des sujets. Une personne qui vit vingt ans en institution n'en sort pas indemne : ses désirs, ses peurs, ses compétences sociales et son rapport à elle-même ont été façonnés par le milieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles la désinstitutionnalisation (séance 6) est si complexe — et ne peut pas se limiter à la seule fermeture des murs.

Goffman ne parle pas du handicap au sens strict — il parle des asiles psychiatriques. Mais ses analyses ont été mobilisées par les chercheur·euse·s et les militant·e·s du handicap pour penser les institutions spécialisées : foyers, homes, centres de réadaptation. La logique est la même : la prise en charge totale protège et exclut simultanément.



3.3 Foucault : biopouvoir et normalisation

Michel Foucault, dans *Surveiller et punir* (1975) et dans ses cours au Collège de France, développe une analyse des pratiques de gestion des corps déviants qui s'applique directement à l'histoire du handicap. Le **biopouvoir** désigne l'ensemble des mécanismes par lesquels le pouvoir moderne s'exerce sur la vie biologique des populations — non plus en faisant mourir, mais en « faisant vivre » selon des normes.

L'enfermement — clinique, éducatif, carcéral — est dans cette lecture une technique de **normalisation** : on met à l'écart ceux qui s'écartent de la norme, on tente de les ramener à un fonctionnement jugé acceptable, on produit de la norme en désignant ce qui en est exclu. La catégorie du handicap est ainsi doublement dépendante du pouvoir : elle est produite par des savoirs médicaux (le diagnostic) et maintenue par des institutions (l'internement, la protection).

La **discipline** foucauldienne — cet ensemble de techniques de surveillance, d'examen, de classement et de normalisation — se manifeste dans l'institution totale avec une clarté particulière : le planning quotidien, l'évaluation continue des comportements, la graduation des privilèges en fonction de la conformité. L'institution ne punit pas au sens pénal : elle normalise. Et normaliser, c'est toujours désigner un écart.

Cette lecture ne dit pas que l'enfermement était une erreur simple et délibérée. Elle dit qu'il était le produit d'un **régime de vérité** — un ensemble de savoirs et d'institutions qui le rendaient non seulement possible mais nécessaire. Les médecins, les travailleurs sociaux, les familles qui ont soutenu l'internement n'étaient pas cyniques : ils croyaient agir bien, dans le cadre d'un savoir légitime. C'est précisément pourquoi cette leçon historique est dérangeante pour le présent.

3.4 Stiker : la réadaptation comme horizon normatif

Henri-Jacques Stiker, dans *Corps infirmes et sociétés* (1982, réédité en 2013), propose une histoire longue des représentations du handicap en Occident. Il identifie une rupture décisive au début du XXe siècle : l'émergence de la **réadaptation** comme paradigme dominant.

Cette rupture est liée aux mutilés de la Première Guerre mondiale. Pour la première fois, des hommes jeunes, valides, bien intégrés socialement, reviennent du front avec des corps abîmés. La société ne peut pas les marginaliser — ce sont des héros. Elle invente donc une réponse inédite : les **rééduquer**, les **réinsérer**, les **réadapter** à une vie productive. Les prothèses, les ateliers de rééducation, les pensions d'invalidité sont créés pour eux. Le mutilé de guerre devient le modèle à partir duquel on pense tout le handicap : un écart par rapport à une norme, un manque à combler, une différence à corriger.

Stiker montre que ce paradigme, apparemment progressiste — il combat la marginalisation, il vise l'inclusion — porte en lui une **violence normative** : l'horizon reste la conformité à la norme valide. La réadaptation ne reconnaît pas la différence ; elle la supprime ou l'atténue. Elle ne reconnaît pas la personne comme elle est ; elle la projette vers ce qu'elle devrait être. Comme Stiker l'a écrit : « La réadaptation prétend effacer, rendre pareil, faire que les personnes ne se

distinguent plus. Elle est une immense entreprise d'assimilation, de disparition des différences » (Stiker, 2013, p. 179).

L'intérêt de cette analyse pour le présent est considérable. Les dispositifs actuels d'insertion professionnelle, d'activation, d'emploi accompagné — combien d'entre eux reproduisent implicitement l'horizon de la réadaptation ? Jusqu'où l'objectif est-il « que la personne puisse mener la vie qu'elle a raison de valoriser » (Sen) plutôt que « que la personne puisse travailler comme les autres » ?

3.5 Les internements administratifs en Suisse

La Suisse a une histoire nationale spécifique qu'il serait inexact de minimiser. Jusqu'en 1981, le Code civil helvétique autorisait ce qu'on appelait alors les **mesures tutélaires** permettant l'internement de personnes jugées incapables de se gérer elles-mêmes — sans jugement pénal, sans procédure contradictoire véritable.

La **Commission indépendante d'experts** (CIE), mandatée par le Conseil fédéral et dont les travaux ont abouti au rapport de 2019 (*Les placements à des fins d'assistance*, dir. Germann & Odier), a documenté l'ampleur du phénomène. Entre 1930 et 1981, on estime à **environ 60 000** le nombre de personnes internées sans jugement à des fins dites d'assistance — souvent pour des motifs comme le vagabondage, la mendicité, l'alcoolisme, ou simplement la pauvreté. Parmi elles, des personnes avec des déficiences intellectuelles ou des troubles psychiques, mais aussi des personnes dites « asociales », des femmes enceintes hors mariage, des jeunes en situation de précarité.

Le rapport CIE documente les mécanismes de ce que les expert-e-s appellent le **déni institutionnel** : non seulement les pratiques étaient légales, mais elles étaient défendues par les professionnel-le-s qui les appliquaient au nom du bien des personnes internées. La logique de protection était sincère — et c'est précisément cela qui en fait un analyseur pour le présent.

3.5.1 La révision du droit de la protection : 2013

En 2013, le droit suisse de la protection de l'adulte a été profondément réformé (art. 426-439 CC). La nouvelle loi instaure des **garanties procédurales** pour les placements à des fins d'assistance (PAFA) : délai maximal de 96 heures avant contrôle judiciaire, droit à un représentant légal, obligation de réévaluation périodique. Ces garanties sont réelles — mais leur application varie selon les cantons, et des tensions entre protection et autodétermination demeurent dans la pratique quotidienne (voir séance 7).

Vignette — « Pour son bien »

Dans les témoignages recueillis par la CIE (2019), plusieurs personnes internées rapportent que les fonctionnaires tutélaires leur ont dit qu'ils agissaient « pour leur bien ». Une femme

internée à 17 ans dans un établissement agricole pour avoir été qualifiée de « vagabonde » témoigne : « On m’a dit que c’était pour me protéger. Mais personne ne m’a demandé ce que je voulais. »

Question de travail : Repérez dans ce récit (1) la logique de protection sincère, (2) l’effacement de la parole de la personne concernée, (3) le rôle du diagnostic social dans la justification de l’internement. Que s’est-il passé entre le « vouloir du bien » de l’agent et l’expérience de la personne ? Quel mécanisme décrit Goffman dans ce type de situation ?

3.6 Tensions pour la pratique professionnelle

Tension à tenir

La bienveillance professionnelle ne constitue pas en elle-même une garantie éthique. Les praticien-ne-s qui ont internés des personnes « pour leur bien » étaient, pour la plupart, sincèrement convaincus d’agir justement. La question éthique n’est pas « est-ce que j’ai de bonnes intentions ? » mais « quels effets produit mon intervention sur la personne concernée, et comment le sais-je ? ». L’histoire institutionnelle invite à une posture de **doute méthodique** : les dispositifs que j’utilise aujourd’hui, quels effets produisent-ils que je ne vois pas ?

À retenir

- L’institution totale (Goffman, 1961) se caractérise par six traits : rupture avec l’extérieur, vie collective homogène, autorité unique, plan rationnel, mortification du moi, et façonnage d’une carrière morale.
- La carrière morale montre que l’institution ne gère pas seulement des corps — elle produit des identités. La désinstitutionnalisation doit en tenir compte.
- Le biopouvoir (Foucault) désigne le pouvoir qui s’exerce sur la vie des populations par la norme et la discipline ; l’institution spécialisée en est une expression.
- La réadaptation (Stiker) est née avec les mutilés de 1914-1918 : horizon progressiste en apparence, mais normativité implicite de retour à la norme valide.
- 60 000 personnes ont été internées administrativement en Suisse entre 1930 et 1981 sans jugement pénal, au nom de leur « bien ».

3.7 Concepts-clés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Institution totale	Organisation prenant en charge toute la vie dans un espace clos	Goffman, <i>Asiles</i> , 1961	Identifier les traits institutionnels dans les dispositifs actuels
Mortification du moi	Dépossession des marqueurs identitaires à l'admission	Goffman, 1961	Préserver l'identité et les liens lors des transitions
Carrière morale	Redéfinition de l'identité imposée par l'institution	Goffman, 1961	Accompagner la reconstruction identitaire post-institution
Biopouvoir	Pouvoir moderne s'exerçant sur la vie des populations par la norme	Foucault, 1975	Interroger la normativité implicite de nos évaluations
Réadaptation	Paradigme visant le retour à la norme valide ; horizon normatif	Stiker, 1982/2013	Distinguer « retour à la norme » et « vie choisie »
Interne-ments administratifs	Enfermements sans jugement pénal, légaux en Suisse jusqu'en 1981	CIE / Germann & Odier, 2019	La bienveillance institutionnelle n'est pas une garantie éthique

Questions de réflexion

1. Un foyer résidentiel actuel pour personnes avec déficience intellectuelle partage-t-il certains traits de l'institution totale goffmanienne ? Lesquels sont présents ? Lesquels sont absents ou atténués ? Qu'est-ce qui a changé, et pourquoi ?
2. La réadaptation comme paradigme est-elle encore présente dans les dispositifs contem-

3 Séance 2 — Histoire longue de la prise en charge

porains de réinsertion professionnelle pour les personnes handicapées en Suisse ? Avec quels arguments pourriez-vous le soutenir ?

3. Les internements administratifs suisses ont été légaux et défendus par des professionnel-le-s sincères. Que signifie cette histoire pour votre propre pratique future ? Comment éviter de reproduire une logique similaire ?
4. Quel rôle joue l'histoire institutionnelle dans les résistances actuelles à la désinstitutionnalisation (voir séance 6) ? En quoi la carrière morale des personnes institutionnalisées complique-t-elle la sortie de l'institution ?

Activité pédagogique

Frise chronologique collective · groupe (plénière) · 30 min

3.7.1 Consignes

1. Une frise vierge est tracée au tableau, de 1850 à aujourd'hui.
2. Des cartes (jalons) sont distribuées aux étudiant-e-s : asile psychiatrique (XIXe s.), maison de travail (XIXe s.), mutilés de guerre/réadaptation (1918), institution spécialisée (années 1930-1970), mesures tutélaires suisses (1930-1981), désinstitutionnalisation (années 1960-1970, USA), CIF (2001), LHand (2004), CDPH (2006/2014), révision PAFA (2013), habitat inclusif (2010-), observations finales ONU/Suisse (2022).
3. Les étudiant-e-s placent les jalons en justifiant leur choix (3 min de préparation, 10 min de placement).
4. Discussion collective : y a-t-il un progrès linéaire ? Quelles continuités observe-t-on malgré les ruptures ? Quels jalons auraient pu être placés différemment ?

3.7.2 Débriefing

- Les pratiques d'institutionnalisation ont-elles vraiment disparu, ou se sont-elles transformées ?
- Que pensez-vous du fait que la Suisse a attendu 2014 pour ratifier la CDPH, soit 8 ans après son adoption ?
- Quel jalon vous a le plus surpris-e ?

3.7.3 Variante en ligne

Pour une séance à distance ou hybride, plusieurs adaptations permettent de reproduire la dynamique de la frise :

- Utiliser **Mentimeter** ou **Wooclap** pour une ligne du temps interactive : les étudiant-e-s placent les jalons par glisser-déposer, et les désaccords de positionnement apparaissent en temps réel.

- Utiliser **Padlet** (colonne chronologique) pour une activité collaborative asynchrone : chaque étudiant-e dépose un jalon avec une justification textuelle avant la séance, puis la discussion en séance synchrone porte sur les choix divergents.
- Pour le débriefing, un sondage Wooclap (question ouverte) peut recueillir « quel jalon vous a le plus surpris-e ? » avant la discussion collective.

Pour aller plus loin

3.7.1 Lectures obligatoires

- Stiker, H.-J. (2013 [1982]). *Corps infirmes et sociétés. Essais d'anthropologie historique* (3e éd.). Dunod (chap. 6 : « La réadaptation »).
- Commission indépendante d'experts (2019). *Les placements à des fins d'assistance. Rapport final*. Berne : CIE (Résumé exécutif, pp. 1-20).

3.7.2 Lectures complémentaires

- Goffman, E. (1961). *Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux* (trad. fr. 1968). Minuit (Introduction et chap. 1).
- Foucault, M. (1975). *Surveiller et punir. Naissance de la prison*. Gallimard (III, 3 : « Le Panoptisme »).
- Germann, U. & Odier, L. (dir.) (2019). *Les placements à des fins d'assistance en Suisse — Histoire, mémoire et héritage*. Seismo (introduction générale).

3.7.3 Ressources en ligne

- Commission indépendante d'experts (CIE) — [Résumé du rapport final sur les placements à des fins d'assistance \(PDF\)](#) — rapport officiel en accès libre sur le site de la CIE.
- INSOS Suisse — [Dossier « Désinstitutionnalisation »](#) — ressources et positions de la fédération des institutions sociales suisses.
- Disability History Museum — [Digital Archive](#) — archives en ligne sur l'histoire internationale des institutions pour personnes handicapées (en anglais).

4 Séance 3 — Les modèles du handicap I

Du médical au social

[Diapositives de la séance](#) [Version PDF du cours](#)

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, l'étudiant-e est capable de :

- Exposer les postulats du modèle médical du handicap et ses conséquences pour la pratique
- Restituer la distinction *impairment* / *disability* et son enjeu politique
- Expliquer le modèle social à partir d'Oliver et de la parabole de Finkelstein
- Présenter la critique féministe (Morris, Thomas) et la critique du réalisme critique (Shakespeare)
- Articuler la complémentarité entre modèle social et modèle des droits humains (voir séance 5)

4.1 Introduction

La séance précédente nous a montré que les pratiques de prise en charge du handicap ont des histoires — qu'elles sont produites par des logiques qu'on peut identifier et interroger. Cette séance introduit l'outil intellectuel principal pour mener cet examen : les **modèles du handicap**. Un modèle n'est pas une description du réel ; c'est un cadre d'interprétation qui sélectionne ce qui compte, désigne les causes, distribue les responsabilités et prescrit les réponses.

Nous en examinerons deux aujourd'hui — le modèle médical et le modèle social — en les mettant en tension. La séance 5 complétera cette cartographie avec les modèles des droits humains et des capacités. Les modèles ne sont pas des étapes successives d'un progrès linéaire : ils coexistent dans les pratiques, parfois dans la même institution, parfois dans le même professionnel.

4.2 Le modèle médical : le handicap dans le corps

Le **modèle médical** — parfois appelé modèle individuel — est le cadre dominant dans les sociétés occidentales jusqu'aux années 1970. Il positionne le handicap comme un attribut de la personne : une déviance par rapport à une norme de fonctionnement physique ou mental, résultant d'une pathologie, d'une blessure ou d'un déficit congénital.

Dans ce cadre, la réponse logique est médicale : **diagnostiquer, traiter, compenser, réadapter**. L'expertise appartient au médecin, à l'ergothérapeute, au rééducateur. La personne handicapée est la patiente — en attente de soins, de rééducation, de prothèses. La guérison ou la normalisation fonctionnelle est l'horizon implicite.

Ce modèle a des vertus indéniables : il a permis des avancées médicales, des techniques d'appareillage, des dispositifs de rééducation qui améliorent réellement la qualité de vie. Sa limite n'est pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il ne voit pas : si le handicap est dans le corps, alors la société est hors de cause. Les obstacles architecturaux, les représentations discriminantes, les lois inadaptées — tout cela ne relève pas du problème, ou seulement de manière accessoire.

Dans la pratique du travail social, le modèle médical se manifeste chaque fois qu'un professionnel focalise son évaluation sur ce que la personne *ne peut pas faire* plutôt que sur ce qui l'empêche de le faire. Il se manifeste aussi dans les formulaires d'évaluation centrés sur les diagnostics, dans les objectifs de rééducation implicitement normalisateurs, dans la langue même : « en situation de handicap » versus « patient », « usager » versus « citoyen ».

4.3 La rupture : l'UPIAS et la distinction *impairment* / *disability*

En 1976, un groupe de personnes handicapées au Royaume-Uni — l'**Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS)** — publie un document intitulé *Fundamental Principles of Disability*. Ce texte est une rupture. Il propose une redéfinition radicale :

« Disability is something imposed on top of our impairments, by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in society. » (UPIAS, 1976)

La distinction est centrale :

- **Impairment** (déficience) : la perte ou l'anomalie d'un membre, d'un organe ou d'une fonction corporelle. Réalité physique.
- **Disability** (handicap social) : le désavantage ou la restriction d'activité **imposée** par une organisation sociale qui ne tient pas compte des personnes ayant des déficiences. Construction sociale.

Ce n'est pas la cécité qui empêche quelqu'un d'accéder à l'information — c'est l'absence de documents en braille ou en version audio. Ce n'est pas l'usage d'un fauteuil roulant qui empêche quelqu'un d'entrer dans un bâtiment — c'est la marche qui mène à la porte. Le problème n'est pas dans la personne : il est dans l'organisation sociale. Et l'organisation sociale est modifiable.

Cette redéfinition n'est pas seulement intellectuelle : elle est politique. Elle déplace la responsabilité de la personne vers la société, et légitime un mouvement de droits civiques plutôt qu'une demande de charité ou de soins.

4.4 Michael Oliver et le modèle social

Michael Oliver (1990, *The Politics of Disablement* ; 1996, *Understanding Disability*) systématise cette intuition en un véritable programme de recherche. Le **modèle social du handicap** repose sur une affirmation simple mais radicale : le handicap est une forme d'oppression sociale, au même titre que le sexisme ou le racisme. La société handicape les personnes à déficiences en ne s'organisant pas pour leur permettre de participer pleinement.

Les implications pour le travail social sont considérables. Si le handicap est dans la société, alors :

- La solution n'est pas individuelle (soigner la personne) mais collective (transformer l'environnement)
- L'expert n'est plus au centre — la personne concernée et le mouvement politique le sont
- L'objectif n'est pas la normalisation mais l'accessibilité universelle et les droits civiques

Oliver s'inspire du mouvement des droits civiques américain et des mouvements féministes. Il insiste sur la **recherche émancipatrice** — une recherche produite *avec* les personnes handicapées, non *sur* elles. Cette posture épistémique a des implications directes pour le travail social : qui définit les besoins ? Qui évalue les résultats ? Qui sait ce que la personne veut vraiment ?

4.5 La parabole de Finkelstein

Vic Finkelstein, chercheur sud-africain en situation de handicap, propose en 1980 une parabole devenue célèbre pour illustrer le modèle social. Imaginons, dit-il, un village où tous les habitants se déplacent en fauteuil roulant. Les maisons, les rues, les magasins sont conçus pour des personnes de petite taille assises. Les personnes valides arrivent dans ce village : elles se cognent aux portes basses, se baissent douloureusement, ne peuvent pas lire les enseignes à la bonne hauteur. Elles souffrent de maux de dos. Les médecins du village les diagnostiquent comme « déficientes » et leur prescrivent des casques de protection et des courbettes thérapeutiques.

La leçon est claire : ce qui apparaît comme un problème individuel est une inadéquation entre un corps et un environnement conçu pour une norme corporelle donnée. Changer de point de vue, c'est voir que le problème n'est pas dans le corps — il est dans le design du monde. Et le design est modifiable.

Cette parabole a une limite — elle simplifie. Elle suppose que toutes les désavantages sont environnementaux et que la déficience elle-même n'a pas d'incidence propre. C'est précisément ce que les critiques du modèle social vont pointer.

4.6 Tableau comparatif : modèle médical et modèle social

Dimension	Modèle médical	Modèle social
Définition du handicap	Déficiência de la personne (déficit)	Restriction imposée par la société (oppression)
Cause	Pathologie, blessure, déficiencia congénitale	Environnement inadapté, barrières sociales
Solution	Traitement, réadaptation, compensation	Accessibilité universelle, droits civiques
Rôle du professionnel	Expert qui sait, diagnostique, prescrit	Facilitateur, acteur de transformation sociale
Rôle de la personne	Patient·e passif·ve, bénéficiaire	Acteur·trice politique de sa propre libération
Exemple	Prothèse pour compenser l'absence d'un membre	Rampe d'accès pour permettre la participation

4.7 Les critiques du modèle social

Le modèle social a représenté une avancée politique et théorique majeure. Il a aussi suscité des critiques importantes, au sein même des *disability studies*.

4.7.1 La critique du corps absent : Hughes et Paterson

Hughes et Paterson (1997) pointent le « corps absent » du modèle social. En focalisant sur les structures sociales, Oliver et ses successeurs ont évacué l'expérience corporelle — la douleur, la fatigue, les transformations du corps vécu. La déficiencia n'est pas seulement une désignation sociale : c'est aussi une expérience incarnée, parfois difficile, qui mérite d'être prise en compte sans honte.

Cette critique a des résonances profondes pour la pratique. Un·e travailleur·euse social·e qui se focalise uniquement sur les barrières environnementales peut passer à côté de la souffrance physique réelle de la personne, de sa fatigue chronique, de la gestion quotidienne de la douleur. Reconnaître les barrières sociales ne dispense pas d'écouter le corps.

4.7.2 La critique féministe : Morris et Thomas

Jenny Morris (1991, *Pride Against Prejudice*) et **Carol Thomas (1999, *Female Forms*)** ont critiqué le modèle social pour son insuffisante attention à l'expérience vécue, en particulier celle des femmes. Thomas distingue l'*impairment effects* (les effets directs de la déficiencia sur l'activité) de la *disability* (les restrictions imposées par la société). Cette distinction permet de reconnaître simultanément les deux dimensions sans réduire l'une à l'autre.

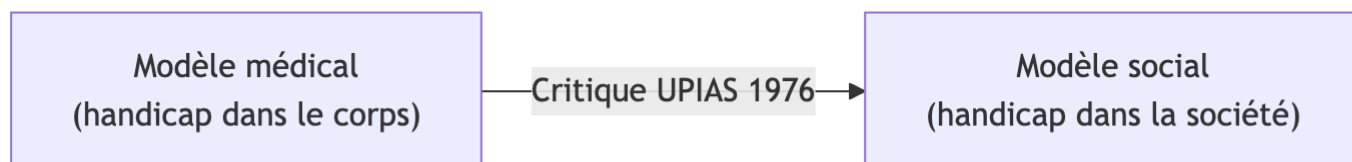
Pour Morris, le modèle social risque de nier l'expérience personnelle au nom d'une analyse structurelle. « We do face physical and psychological differences which can be painful and distressing [...] To deny this is to deny our own experience » (Morris, 1991). La politique du handicap doit tenir ensemble la transformation sociale et la reconnaissance de l'expérience vécue.

4.7.3 Le réalisme critique : Shakespeare

Tom Shakespeare (2006), lui-même en situation de handicap, propose un **réalisme critique** : le modèle social a eu raison d'insister sur les barrières sociales, mais il aurait tort de nier que la déficience elle-même contribue au désavantage vécu. Les deux dimensions — corporelle et sociale — interagissent. Nier l'une ou l'autre tronque l'analyse. Shakespeare plaide pour un **modèle interactionniste** qui tienne les deux.

Shakespeare ne rejette pas le modèle social ; il le complexifie. Sa position est inconfortable pour les militants du handicap, car elle risque d'être récupérée pour justifier des politiques médicales. Mais elle est intellectuellement honnête — et elle correspond à l'expérience clinique : la douleur d'une fibromyalgie ou la fatigue d'une sclérose en plaques ne disparaissent pas avec l'accessibilité universelle.

Ces critiques ne liquident pas le modèle social — elles l'affinent. Pour le travail social, elles rappellent que reconnaître les barrières sociales ne dispense pas de reconnaître l'expérience corporelle de la personne accompagnée.



i Vignette — Un dispositif d'insertion : modèle médical ou social ?

Un service cantonal propose un programme de « réinsertion professionnelle » pour des personnes avec des limitations physiques. Le programme inclut une évaluation médicale

des capacités restantes, un bilan professionnel, et une formation vers des métiers « compatibles avec le handicap ». Les participant·e·s sont évalué·e·s sur leurs progrès par rapport à des objectifs fixés par l'équipe.

Question de travail : (1) Quels éléments de ce dispositif relèvent du modèle médical ? (2) Y a-t-il des éléments relevant du modèle social ? (3) Qu'est-ce que la critique féministe (expérience vécue) ajouterait ? (4) Que faudrait-il modifier pour que le dispositif soit cohérent avec le modèle interactionniste de Shakespeare ? Avec l'approche par les capacités (séance 5) ?

4.8 Tensions pour la pratique professionnelle

⚠ Tension à tenir

Le modèle social est politiquement puissant mais peut conduire à nier les besoins individuels réels de certaines personnes en matière de soins ou d'assistance médicale. Le modèle médical répond à des besoins réels mais risque de réduire la personne à ses déficiences. Dans la pratique, le·la travailleur·euse social·e doit articuler les deux registres sans abandonner ni le souci du corps ni la transformation des environnements. La critique féministe rappelle que l'expérience vécue — y compris la douleur — est une source de savoir légitime, pas un obstacle à l'analyse politique.

! À retenir

- Le modèle médical situe le problème dans le corps de la personne ; le modèle social le situe dans l'organisation de la société.
- La distinction *impairment* / *disability* (UPIAS, 1976) est la rupture fondatrice du modèle social.
- Oliver (1990) radicalise cette rupture en définissant le handicap comme une forme d'oppression sociale comparable au sexisme ou au racisme.
- Shakespeare (2006) et les féministes (Morris, Thomas) nuancent : la déficience a des effets réels, l'expérience vécue compte, les deux dimensions doivent être tenues ensemble.
- Aucun modèle seul ne suffit à guider la pratique : ils sont des outils analytiques complémentaires.

4.9 Concepts-clés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Modèle médical	Handicap comme attribut individuel à soigner/com-penser	Usage courant ; critique par Oliver, 1990	Questionner le centrage sur le déficit dans les évaluations
Impair-ment	Déficience corporelle – réalité physique	UPIAS, 1976	Ne pas nier l'expérience corporelle
Disability	Désavantage socialement produit – construction sociale	UPIAS, 1976	Agir sur les barrières environnementales
Modèle social	Handicap comme oppression sociale ; solution collective	Oliver, 1990, 1996	Penser l'intervention au niveau des structures
Réalisme critique	Le handicap résulte de l'interaction entre déficience et barrières	Shakespeare, 2006	Tenir les deux registres simultanément
Impair-ment effects	Effets directs de la déficience sur l'activité (distinct des barrières sociales)	Thomas, 1999	Reconnaître la souffrance sans la médicaliser

Questions de réflexion

1. Dans votre stage ou votre expérience professionnelle, avez-vous observé des pratiques relevant clairement du modèle médical ? Du modèle social ? Y a-t-il des moments où les deux coexistent dans la même interaction ?

2. La critique féministe insiste sur l'expérience vécue, y compris la douleur et la fatigue. En quoi cette dimension peut-elle être difficile à intégrer dans une posture de défense des droits ? Comment les tenir ensemble ?
3. Si le handicap est une forme d'oppression comparable au sexisme, quelles seraient les implications pour la formation des travailleur·euse·s sociaux·ales ? Pour l'organisation des services ?
4. La parabole de Finkelstein est séduisante mais simplificatrice. Quel cas concret ne peut pas être entièrement expliqué par les barrières environnementales ? Que révèle ce cas sur les limites du modèle social pur ?

Activité pédagogique

Exercice Finkelstein — Le bâtiment inversé · groupes de 4 · 25 min

4.9.1 Consignes

1. Chaque groupe imagine qu'il doit concevoir un bâtiment public dans lequel la norme corporelle est l'usage d'un fauteuil roulant électrique. Toutes les personnes « valides » (qui marchent debout) sont des visiteurs atypiques.
2. Le groupe liste les adaptations nécessaires pour les personnes valides : hauteur des portes, largeur des couloirs, type de surfaces, signalétiques, sanitaires (10 min).
3. Chaque groupe présente ses adaptations en plénière (2 min par groupe).
4. Discussion collective : qu'est-ce qui a été le plus difficile à imaginer ? Quels choix de design « normaux » avez-vous dû déconstruire ?

4.9.2 Débriefing

- Qu'est-ce que cet exercice révèle sur les choix implicites qui sous-tendent nos environnements ordinaires ?
- Qui décide de ces choix ? Qui en est absent·e au moment de la conception ?
- En quoi cet exercice illustre-t-il la notion d'oppression structurelle d'Oliver — sans mauvaise volonté, par simple absence de perspective ?

4.9.3 Variante en ligne

Pour une séance à distance ou hybride :

- Utiliser **Padlet** en mode tableau : chaque groupe crée une colonne « bâtiment inversé » et liste ses adaptations par cartes, ce qui permet une mise en commun visuelle rapide avant la discussion plénière.
- Le travail de groupe peut se faire dans des salles de sous-groupe Zoom ou Teams, avec un Padlet partagé pour consigner les résultats.

- Pour stimuler la discussion, un **Mentimeter** (nuage de mots) peut recueillir en temps réel les réponses à « quel choix de design vous a été le plus difficile à déconstruire ? » avant la mise en commun.

Pour aller plus loin

4.9.1 Lectures obligatoires

- Oliver, M. (1996). *Understanding Disability. From Theory to Practice*. Macmillan (chap. 2 : « The Social Model in Context »).
- UPIAS (1976). *Fundamental Principles of Disability*. Union of the Physically Impaired Against Segregation, Londres (pp. 3-7).

4.9.2 Lectures complémentaires

- Shakespeare, T. (2006). *Disability Rights and Wrongs*. Routledge (chap. 2 : « The Social Model of Disability »).
- Hughes, B. & Paterson, K. (1997). The social model of disability and the disappearing body. *Disability & Society*, 12(3), 325-340.
- Finkelstein, V. (1980). *Attitudes and Disabled People*. World Rehabilitation Fund, New York.
- Morris, J. (1991). *Pride Against Prejudice. Transforming Attitudes to Disability*. Women's Press (chap. 1 et 2).

4.9.3 Ressources en ligne

- UPIAS (1976). *Fundamental Principles of Disability* — [texte intégral en accès libre](#) — archive du Disability Studies Archive (Université de Leeds).
- Centre for Disability Studies, Université de Leeds — [Disability Studies Archive](#) — bibliothèque numérique en accès libre réunissant les textes fondateurs des *disability studies* (Oliver, Finkelstein, Morris, Shakespeare).
- WHO — [World Report on Disability \(2011\)](#) — rapport mondial en accès libre qui articule les modèles médical et social dans une perspective de politiques publiques.

Deuxième partie

Partie II — Transformations du champ

5 Séance 4 — Du protégé au sujet de droits

Transformations du champ et posture professionnelle — Séance charnière (4/12)

[Diapositives de la séance](#) [Version PDF du cours](#)

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, l'étudiant-e est capable de :

- Relier les quatre modèles du handicap à des conséquences concrètes pour la posture professionnelle
- Nommer les quatre grandes transformations du champ suisse et genevois
- Formuler les trois tensions de posture qui structurent l'ensemble du module
- Mobiliser le concept d'exclusion épistémique (Tabin et al., 2024 ; Fricker, 2007) dans une situation concrète
- Analyser une situation à la lumière de la réflexivité professionnelle

5.1 Introduction

Cette séance est la charnière du module. Les trois premières séances ont posé les bases : qu'est-ce que le handicap, comment a-t-il été traité historiquement, quels modèles théoriques permettent de l'analyser ? Aujourd'hui, nous passons du registre de l'analyse au registre de la **transformation** — et de la **posture**.

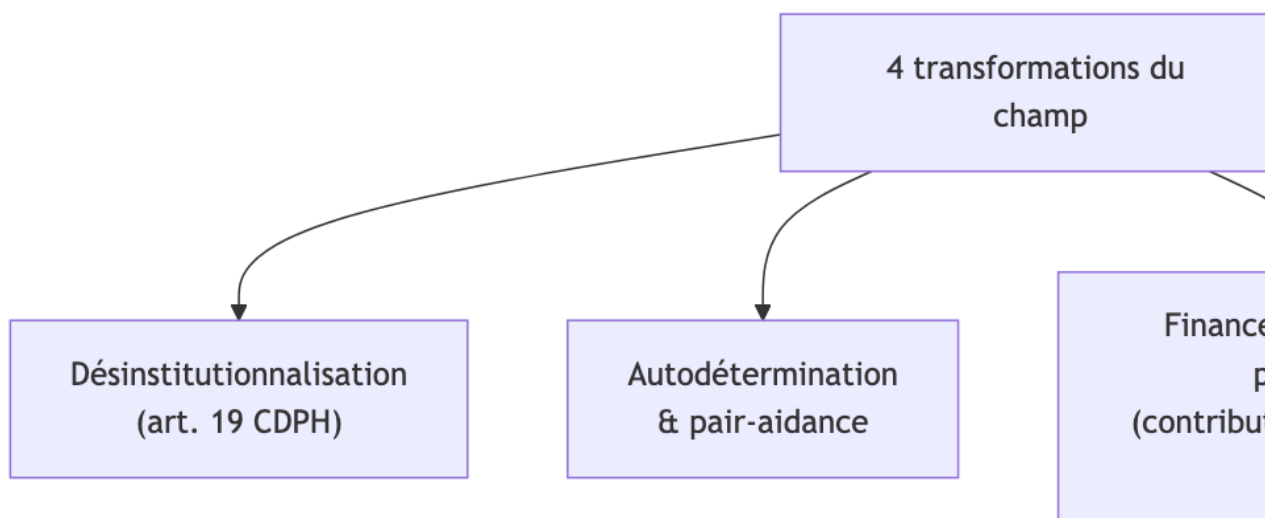
Car ce n'est pas seulement le droit ou les politiques publiques qui se transforment. C'est aussi le rôle du·de la travailleur·euse social·e. Comprendre ces transformations n'est pas une curiosité intellectuelle : c'est la condition pour agir de manière réflexive dans un champ en mouvement. La réflexivité professionnelle — cette capacité à interroger ses propres présupposés, à voir sa pratique de l'extérieur — est précisément ce que Donald Schön (1983) appelait le *praticien réflexif* : non pas un technicien qui applique des procédures, mais un professionnel qui pense *dans* et *sur* l'action.

5.2 Quatre modèles, quatre postures

Avant d'entrer dans les transformations, rappelons la cartographie des modèles, que les séances 3 et 5 développent en détail. Chaque modèle implique une position différente pour le-la professionnel-le :

- **Modèle médical** : le-la professionnel-le est l'expert-e qui sait, diagnostique et prescrit. La personne est patiente.
- **Modèle social** : le-la professionnel-le est un acteur parmi d'autres dans la transformation des structures. La personne est actrice de sa propre libération.
- **Modèle des droits humains** (séance 5) : le-la professionnel-le est garant-e de l'effectivité des droits. La personne est sujet de droits.
- **Modèle des capacités** (séance 5) : le-la professionnel-le est facilitateur-trice de capacités. La personne est actrice de ses propres choix.

Ces quatre positions ne sont pas des étapes successives : elles coexistent dans la pratique. Le défi est de savoir dans quel registre on opère — et pourquoi. La séance 12 reviendra sur cette question à partir des situations analysées tout au long du module.



5.3 Quatre transformations du champ suisse et genevois

5.3.1 1. La désinstitutionnalisation

Le mouvement de désinstitutionnalisation s'est amorcé dans les pays anglophones dans les années 1960-1970, et en Suisse plus progressivement depuis les années 1980-1990. Il désigne le passage d'une organisation des soins et de l'accompagnement centrée sur les grandes institutions résidentielles vers des formes de vie dans la « communauté » — appartements accompagnés, collocations, domicile avec assistance.

Ce mouvement a des fondements juridiques forts : l'article 19 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH, 2006, ratifiée par la Suisse en 2014) garantit le droit de vivre dans la société avec des choix égaux. En 2022, le Comité de l'ONU a adressé à la Suisse des observations finales sévères, soulignant le maintien d'un taux d'institutionnalisation élevé et l'absence de stratégie nationale de désinstitutionnalisation. La désinstitutionnalisation sera approfondie à la séance 6.

5.3.2 2. L'autodétermination et la pair-aidance

Wehmeyer (1999) définit l'autodétermination comme le fait d'agir comme l'agent causal premier de sa propre vie — faire des choix sans influence externe induite. Ce principe, d'abord développé dans le champ de la déficience intellectuelle, s'est étendu à l'ensemble du champ du handicap et informe aujourd'hui les référentiels professionnels.

L'autodétermination ne se réduit pas à une capacité individuelle : Cudré-Mauroux, Piérart & Vaucher (2020) la définissent comme un **construit relationnel et contextuel**. Ce n'est pas quelque chose que la personne possède ou non : c'est quelque chose que le contexte (les relations, les dispositifs, les cultures institutionnelles) produit ou empêche. Un·e professionnel·le peut soutenir ou bloquer l'autodétermination par ses attitudes, ses décisions et le cadre qu'il ou elle propose.

Parallèlement, la **pair-aidance** reconnaît le **savoir expérientiel** des personnes concernées comme une ressource légitime — parfois professionnalisée. La personne qui a vécu une situation devient une ressource pour ceux qui la vivent. Ce déplacement reconfigure la hiérarchie du savoir dans la relation d'accompagnement. Nous y reviendrons à la séance 7.

5.3.3 3. Le financement orienté personne

La **contribution d'assistance** de l'assurance-invalidité (AI), introduite en 2012, représente un basculement conceptuel : on ne finance plus l'institution (financement de l'objet) mais la personne elle-même (financement du sujet). La personne reçoit une allocation horaire — environ 35 CHF/h, davantage si des qualifications spécifiques sont requises — et devient l'**employeuse** de ses assistant·e·s.

Cette réforme est portée par la logique de l'autodétermination. Elle comporte aussi des effets ambivalents, que la séance 8 analysera en détail : la charge de gestion administrative peut peser lourdement sur des personnes dont la santé est déjà sollicitée. Elle requiert aussi des compétences (gérer un employé, planifier, négocier) qui ne sont pas données à chacun, et que les dispositifs de soutien doivent accompagner.

5.3.4 4. L'école inclusive

L'accord intercantonal sur la pédagogie spécialisée (2007, en vigueur 2011) pose le principe de la priorité aux solutions intégratives sur les solutions séparatives. Genève a traduit ce principe

dans sa Loi sur l'instruction publique (LIP) et dans sa politique d'« École inclusive ». L'article 24 de la CDPH garantit le droit à une éducation inclusive sans discrimination. La séance 9 abordera les écarts entre la proclamation du principe et sa mise en œuvre effective — car l'école inclusive genevoise reste marquée par des dispositifs intermédiaires nombreux, des classes de soutien, des accompagnements différenciés qui s'éloignent parfois du modèle inclusif strict.

! Actualité — Initiative « Pour l'inclusion » (2026)

Le 25 février 2026, le Conseil fédéral a publié son message sur un contre-projet indirect à l'initiative populaire « Pour l'inclusion ». Cette initiative demande l'inscription dans la Constitution fédérale du droit à une vie inclusive et autodéterminée pour les personnes handicapées. Le contre-projet indirect, soumis au Parlement, représente un moment de débat politique majeur sur la désinstitutionnalisation et les droits des personnes handicapées en Suisse.

5.4 Les trois tensions de posture professionnelle

Les transformations décrites ci-dessus ne suppriment pas les tensions — elles les déplacent et en créent de nouvelles. Trois tensions structurent l'ensemble du module. Elles ne se résolvent pas : elles se tiennent, de façon réflexive.

5.4.1 Tension 1 : Autonomie vs protection — la dignité du risque

Robert Perske (1972) introduit la notion de **dignité du risque** (*dignity of risk*) : les personnes handicapées ont le droit de prendre des risques — y compris des risques que les professionnels jugent excessifs. Refuser ce droit au nom de la protection, c'est refuser une part de l'humanité commune. La protection est légitime ; elle devient problématique quand elle prive la personne du droit à l'expérience, à l'erreur, et à la croissance.

Cette tension prend des formes très concrètes dans la pratique quotidienne. Une personne avec des troubles mnésiques qui souhaite vivre seule : l'équipe craint qu'elle oublie de fermer le gaz, de prendre ses médicaments, de manger. Que faire ? Une personne avec une déficience intellectuelle légère qui veut traverser seule une grande avenue passante : l'éducateur la voit hésiter et s'inquiète. À quel moment la protection devient-elle paternalisme ? Il n'y a pas de réponse-protocole. Il y a une délibération, avec la personne, qui tient ensemble son droit à la prise de risque et les responsabilités professionnelles réelles.

5.4.2 Tension 2 : Expertise professionnelle vs savoir expérientiel

Tabin, Piecek, Probst & Perrin (2024) documentent ce qu'ils nomment l'**exclusion épistémique** dans le système de l'AI suisse : la parole de la personne concernée n'est pas reconnue comme une source de savoir légitime par les professionnel·le·s et l'administration. Le diagnostic médical

prévaut sur le récit vécu. Cette tension traverse tous les domaines du handicap : qui sait vraiment ce dont la personne a besoin ?

Cette notion rejoint le concept de **justice épistémique** développé par Miranda Fricker (2007). Fricker distingue deux formes d'injustice épistémique : l'**injustice testimoniale** (le témoignage d'une personne est discrédité en raison de son appartenance à un groupe minoritaire) et l'**injustice herméneutique** (le groupe ne dispose pas des ressources conceptuelles pour interpréter et communiquer sa propre expérience). Dans le champ du handicap, les deux formes opèrent : le récit de la personne handicapée est souvent jugé moins fiable que le rapport médical, et les personnes manquent parfois des mots et des cadres pour nommer leur expérience dans des termes que les institutions reconnaissent.

Pour le·la travailleur·euse social·e, cela implique une posture active : ne pas seulement écouter, mais **créer les conditions pour que la parole de la personne soit entendue et prise au sérieux** — y compris dans les moments d'évaluation, de commission, de rapport.

5.4.3 Tension 3 : Logique gestionnaire vs relation d'accompagnement

Joan Tronto (1993) et Yann Le Bossé (2003) ont théorisé, chacun de leur côté, les effets de la rationalisation sur le travail de soin et d'accompagnement. Les dispositifs gestionnaires — plans d'accompagnement individualisés, indicateurs de performance, financement à la prestation — peuvent entrer en contradiction avec le temps long de la relation et le rythme de la personne accompagnée.

En Suisse, cela se manifeste concrètement dans l'usage de l'outil PLAISIR (Planification informatisée des soins infirmiers requis) pour calibrer les prestations d'accompagnement. Cet instrument, fondé sur une évaluation standardisée des actes, capte mal les dimensions relationnelles du travail — la disponibilité dans l'imprévu, le temps de l'écoute, la présence dans la crise. Le financement à la prestation crée une pression vers la standardisation qui peut vider le travail social de sa substance relationnelle.

La réflexivité professionnelle (Schön, 1983 ; Bourdieu, 1987) est précisément la capacité à identifier ces tensions sans les nier — et à agir dans leurs interstices. Le praticien réflexif ne subit pas les logiques institutionnelles : il les pense, les négocie, et identifie les marges de manœuvre.

5.5 L'assistance sexuelle comme analyseur

Un sujet marginalisé peut servir d'**analyseur** des tensions d'un champ — c'est-à-dire que son caractère extrême révèle des dynamiques autrement invisibles. C'est la fonction que joue l'assistance sexuelle dans ce module (développée à la séance 10). Reconnaître un désir sexuel comme un besoin légitime d'une personne handicapée, c'est pousser l'autodétermination jusqu'au corps, percuter les normes professionnelles, et mettre à l'épreuve le concept de **compassionate stigma** — ce processus par lequel la bienveillance protectrice maintient la personne en objet de sollicitude plutôt qu'en sujet désirant (Brasseur, 2024).

L'assistance sexuelle révèle aussi, de manière particulièrement nette, l'exclusion épistémique : les besoins sexuels des personnes handicapées sont souvent définis par les professionnels (inexistants, inadaptés, dangereux) plutôt que par les personnes elles-mêmes. Et la logique gestionnaire est ici totalement inadaptée : on ne peut pas standardiser le soutien à la vie affective et sexuelle.

i Vignette — Maria, 34 ans

Maria a 34 ans. Tétraplégie depuis un accident de voiture à 28 ans. Elle vit dans un établissement pour personnes handicapées (EPH) depuis six ans. L'établissement est bien géré, propre, avec une équipe bienveillante. Maria a des soins de qualité.

Depuis un an, elle bénéficie d'une contribution d'assistance AI et envisage de quitter l'institution pour vivre en appartement avec deux assistant·e·s. Elle a visité un appartement adapté en ville, rencontré une personne qui vit de façon autonome avec tétraplégie, et est accompagnée par une conseillère en vie autonome.

L'équipe de l'EPH est inquiète : elle ne sait pas cuisiner seule, elle a des épisodes de dysrèflexie autonome qui peuvent être dangereux, elle n'a pas de réseau familial proche. La cheffe d'équipe dit : « Nous l'aimons beaucoup. Nous ne pouvons pas la laisser partir dans une situation non sécurisée. »

Maria dit : « Je sais que c'est risqué. J'ai le droit de prendre ce risque. Et j'ai le droit de ne pas être aimée — j'ai le droit d'être respectée. »

Question de travail : Dans ce cas, identifiez (1) la tension autonomie/protection, (2) un signe possible d'exclusion épistémique, (3) un élément de logique gestionnaire. Quelle posture adopteriez-vous en tant que travailleur·euse social·e référent·e de Maria ?

5.6 Tensions pour la pratique professionnelle

⚠ Tension à tenir

Face à Maria, quelle est la posture juste ? Si vous insistez pour qu'elle reste, vous la protégez — et vous limitez son autodétermination. Si vous l'accompagnez dans le projet, vous respectez ses droits — et vous prenez une responsabilité professionnelle en cas d'accident. Cette tension ne se résout pas par un protocole. Elle se tient, de façon réflexive, avec la personne concernée. La réflexivité n'est pas une invitation à l'inaction : c'est une invitation à décider en conscience, avec la personne, plutôt qu'à sa place.

! À retenir

- Les quatre transformations du champ (désinstitutionnalisation, autodétermination, financement orienté personne, école inclusive) déplacent le rôle du·de la travailleur·euse social·e : de protecteur vers facilitateur, d'expert vers garant des

droits.

- La dignité du risque (Perske) : les personnes handicapées ont le droit de prendre des risques ; la protection n’est pas neutre — elle peut priver de liberté.
- L’exclusion épistémique (Tabin et al. ; Fricker) : la parole de la personne handicapée est systématiquement minorée face au savoir médical et professionnel. La corriger est une responsabilité active du TS.
- La logique gestionnaire (PLAISIR, financement à la prestation) menace la substance relationnelle du travail social ; la résistance passe par la réflexivité.
- Le compassionate stigma (Brasseur, 2024) désigne le processus par lequel la bienveillance maintient la personne en objet — non en sujet.

5.7 Concepts-clés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Désinstitutionnalisation	Passage des grandes institutions à des formes de vie dans la communauté	Art. 19 CDPH ; ONU 2022	Accompagner les transitions sans reproduire la logique institutionnelle
Autodétermination	Agir comme agent causal premier de sa propre vie	Wehmeyer, 1999	L’évaluer comme construit relationnel, pas comme trait fixe
Contribution d’assistance	Allocation AI permettant à la personne d’employer ses assistant·e·s	AI Suisse, 2012	Soutenir les compétences de gestion sans alourdir la charge
Dignité du risque	Droit de la personne handicapée à prendre des risques	Perske, 1972	Distinguer risque légitime et danger réel

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Exclusion épistémique	Non-reconnaissance de la parole de la personne comme savoir légitime	Tabin et al., 2024 ; Fricker, 2007	Créer activement les conditions d'une parole entendue
Compassionate stigma	Disqualification implicite par excès de bienveillance protectrice	Brasseur, 2024	Surveiller ses propres attitudes de « sur-protection »
Réflexivité professionnelle	Capacité à interroger ses propres présupposés dans l'action	Schön, 1983 ; Bourdieu	Disposition centrale du praticien·ne du champ

Questions de réflexion

1. Pensez à une situation que vous avez observée (stage, bénévolat) où une décision professionnelle a été prise « pour le bien » d'une personne sans que celle-ci soit réellement consultée. Quel modèle cela illustre-t-il ? Qu'aurait impliqué une posture d'autodétermination ?
2. L'exclusion épistémique opère aussi dans la formation : les personnes handicapées sont rarement invitées à enseigner sur leur propre expérience. Qu'est-ce que cela révèle ? Comment y remédier ?
3. La logique gestionnaire (plans d'accompagnement standardisés, indicateurs de résultats) est présentée comme un outil d'équité et de transparence. Quelles sont ses vertus réelles ? Quelles sont ses limites dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap complexe ?
4. Maria dit : « J'ai le droit de ne pas être aimée — j'ai le droit d'être respectée. » Qu'est-ce que cette distinction entre amour et respect révèle sur les tensions du champ ? En quoi le compassionate stigma est-il particulièrement actif dans les métiers du soin et du travail social ?

Activité pédagogique

Think-pair-share — La situation de Maria · individuel → binôme → plénière · 20 min

5.7.1 Consignes

1. Individuellement (5 min) : écrivez la posture que vous adopteriez face à Maria et votre justification en deux ou trois phrases.
2. En binôme (5 min) : partagez vos postures. Identifiez un point d'accord et un point de divergence.
3. En plénière (10 min) : recensement des postures au tableau en deux colonnes (« rester » / « accompagner le projet »). Discussion : quelles tensions apparaissent ? Sur quels arguments les deux postures s'appuient-elles ?

5.7.2 Débriefing

- Combien de personnes ont spontanément mobilisé l'argument du risque pour Maria ? Combien ont mobilisé l'argument du droit ?
- Y a-t-il une différence selon que l'on imagine Maria comme une inconnue ou comme quelqu'un qu'on connaît depuis 6 ans ? Qu'est-ce que cela révèle sur les effets de la relation au long cours ?
- Note : conserver ces réponses écrites ; elles seront relues à la séance 12 pour mesurer l'évolution de la posture.

5.7.3 Variante en ligne

Pour une séance à distance ou hybride :

- La phase individuelle peut se faire via un formulaire **Wooclap** (réponse ouverte) avant la séance synchrone, ce qui permet à l'enseignant·e de visualiser la distribution des postures avant la discussion.
- Les binômes se forment dans des salles de sous-groupe Zoom ou Teams (5 min).
- En plénière, un **Mentimeter** (question « Pour ou contre accompagner le projet de Maria ? ») visualise la distribution en temps réel et sert de point de départ à la discussion.
- La consigne de conserver les réponses écrites pour la séance 12 peut être réalisée via un **Padlet** personnel auquel chaque étudiant·e a accès tout au long du module.

Pour aller plus loin

5.7.1 Lectures obligatoires

- Cudré-Mauroux, A., Piérart, G. & Vaucher, C. (2020). L'autodétermination des personnes en situation de handicap : un construit relationnel et contextuel. *Alter*, 14(2), 79-94.

- Tabin, J.-P., Piecek, M., Probst, I. & Perrin, C. (2024). L'exclusion épistémique dans l'assurance-invalidité suisse. *Revue suisse de travail social*, 33, 12-31.

5.7.2 Lectures complémentaires

- Wehmeyer, M. L. (1999). Self-determination, student involvement, and leadership development. In S. H. de Fur & J. R. Patton (Eds.), *Transition and School-Based Services* (pp. 37-58). PRO-ED.
- Perske, R. (1972). The dignity of risk and the mentally retarded. *Mental Retardation*, 10(1), 24-27.
- Brasseur, P. (2024). *L'assistance sexuelle aux personnes handicapées*. Presses Universitaires de France.
- Fricker, M. (2007). *Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing*. Oxford University Press (chap. 1 et 2).
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action*. Basic Books (Introduction).

5.7.3 Ressources en ligne

- Comité ONU des droits des personnes handicapées – [Observations finales sur la Suisse \(2022\)](#) – document officiel ONU en accès libre commentant la désinstitutionnalisation et l'autodétermination en Suisse.
- Assurance-invalidité suisse – [Contribution d'assistance : informations officielles](#) – présentation du dispositif de financement orienté personne.
- Pro Infirmis – [Dossier « Autodétermination »](#) – ressources pratiques et témoignages sur l'autodétermination dans le contexte suisse.

6 Séance 5 — Les modèles du handicap II

Droits humains, capacités et CIF

[Diapositives de la séance](#) [Version PDF du cours](#)

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, l'étudiant-e est capable de :

- Identifier les articles clés de la CDPH et leurs implications pour la pratique
- Distinguer l'égalité formelle de l'égalité transformative au sens de Degener
- Expliquer la distinction capacités / fonctionnements et son application au handicap avec le facteur de conversion
- Appliquer la liste des dix capacités de Nussbaum à l'évaluation d'un dispositif
- Formuler la critique d'Imrie adressée à la CIF

6.1 Introduction

Les modèles médical et social ont constitué les deux pôles d'un débat fondateur. Ils ne suffisent cependant pas à rendre compte des évolutions récentes — notamment l'émergence d'un droit international contraignant et le développement d'un cadre philosophique centré sur la liberté réelle des personnes. Cette séance présente les deux modèles complémentaires : le **modèle des droits humains** et le **modèle des capacités**. Elle revient également sur la CIF, dont la portée et les limites méritent un regard critique.

Ces deux modèles partagent un point de départ commun : l'insatisfaction devant le modèle social pur. Le modèle social a eu raison de pointer les barrières sociales comme cause principale du handicap. Mais il n'a pas répondu à la question normative : quelle société voulons-nous ? Quels standards justiciables pouvons-nous exiger des États ? C'est ce à quoi répondent, par des voies différentes, la CDPH et les capacités.

6.2 Le modèle des droits humains : la CDPH

6.2.1 Trois générations de droits

Avant d'entrer dans la CDPH, il est utile de situer son inscription dans l'histoire du droit international. Les droits humains se sont développés en trois générations :

Première génération — droits civils et politiques (liberté d'expression, droit à un procès équitable, interdiction de la torture) : Pacte international de 1966.

Deuxième génération — droits économiques, sociaux et culturels (droit au travail, à la santé, à l'éducation) : Pacte international de 1966.

Troisième génération — droits des groupes et droits à la solidarité (droit au développement, droits des peuples autochtones, droits des personnes handicapées). La **CDPH** (2006) s'inscrit dans cette troisième génération : elle reconnaît que certains groupes font face à des formes systémiques d'exclusion qui exigent une réponse spécifique, non seulement l'application des droits généraux.

6.2.2 La CDPH et ses articles clés

La **Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)**, adoptée en 2006 et ratifiée par la Suisse en 2014, constitue le document de référence du droit international en matière de handicap. Elle ne crée pas de droits nouveaux : elle applique les droits humains existants aux personnes handicapées, en reconnaissant que ces droits sont systématiquement entravés pour ce groupe.

! Articles clés de la CDPH

Art. 12 — Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité : les États garantissent aux personnes handicapées la pleine capacité juridique dans tous les domaines de la vie. Cela implique le remplacement de la tutelle par des **systèmes de soutien à la décision** — non plus une tierce personne qui décide à la place, mais un accompagnement qui soutient la personne dans sa propre prise de décision.

Art. 19 — Autonomie de vie et inclusion dans la société : les personnes handicapées ont le droit de choisir leur lieu de résidence, avec qui elles vivent, et d'avoir accès aux services d'assistance nécessaires. Aucune obligation de vivre en institution.

Art. 24 — Éducation : les États garantissent un système d'éducation inclusif à tous les niveaux, sans discrimination. Cela implique des aménagements raisonnables dans les établissements ordinaires — pas le placement séparatif comme réponse par défaut.

Art. 25 — Santé : les personnes handicapées ont le droit aux soins de santé sur la base de l'égalité avec les autres, y compris dans les domaines spécifiques à leur situation.

Art. 27 — Travail et emploi : les États protègent le droit des personnes handicapées au travail dans un milieu de travail ouvert, inclusif et accessible, en interdisant la discrimination

et en exigeant des aménagements raisonnables.

6.2.3 Le modèle des droits humains selon Degener

Theresia Degener (2016), membre du Comité de l'ONU pour les droits des personnes handicapées, formalise ce qu'elle appelle le **modèle des droits humains du handicap** en le situant dans une histoire en quatre étapes :

1. **Le modèle de la charité** : la personne handicapée est un objet de pitié et de générosité. Pas de droits — des dons.
2. **Le modèle médical** : la personne handicapée est un patient à soigner et normaliser.
3. **Le modèle de la réhabilitation** : la personne est un bénéficiaire à réinsérer, à condition de se conformer aux normes de productivité.
4. **Le modèle des droits humains** : la personne est un sujet de droits à part entière, qui exige des États des obligations positives et négatives.

Degener le distingue aussi du modèle social sur un point crucial : il ne s'arrête pas à la suppression des barrières sociales, il exige une **égalité transformative**. L'égalité formelle (traiter tout le monde pareil) ne suffit pas si elle ignore les inégalités structurelles préexistantes. L'égalité transformative demande de traiter les personnes différemment selon leurs besoins, pour atteindre une égalité réelle en termes de résultats et de dignité. C'est une distinction décisive pour la pratique : un formulaire identique pour tout le monde n'est pas neutre si certaines personnes ne peuvent pas le remplir sans aide.

6.3 L'approche par les capacités : Sen et Nussbaum

6.3.1 La question de la liberté réelle

Développée initialement en économie du développement par **Amartya Sen**, puis étendue en philosophie morale et politique par **Martha Nussbaum**, l'**approche par les capacités** offre un cadre original pour penser le handicap. Elle pose la question suivante : qu'est-ce que les personnes sont réellement capables de faire et d'être ?

La distinction centrale est entre **ressources** et **capacités** :

- Les **ressources** sont les moyens disponibles (revenu, équipements, prestations)
- Les **capacités** sont les libertés réelles — ce que la personne peut *effectivement* faire de ces ressources dans son contexte spécifique

Entre une ressource et une capacité, il faut des **facteurs de conversion** — ce qui transforme (ou bloque) la ressource en liberté réelle. Ces facteurs sont de trois ordres :

- **Individuels** : les caractéristiques physiques et psychologiques de la personne (une même formation ne produit pas les mêmes compétences selon les personnes)

- **Sociaux** : les normes culturelles, les relations de pouvoir, les représentations (être femme et handicapée multiplie les obstacles)
- **Environnementaux** : le contexte physique et institutionnel (une même allocation financière produit des capacités très différentes selon que la personne vit en ville ou en zone rurale)

Ce cadre déplace la question de l'intervention sociale : il ne s'agit plus de « donner des ressources » mais d'« assurer que les ressources se traduisent réellement en libertés ». La contribution d'assistance AI (séance 4) donne une ressource ; si la personne n'a pas les compétences de gestion nécessaires et que le soutien pour les développer fait défaut, la capacité effective reste limitée.

6.3.2 Les dix capacités centrales de Nussbaum

Nussbaum propose une liste de **dix capacités centrales** que toute société juste doit garantir à chaque personne. Pour les personnes handicapées, cette liste devient un outil d'évaluation des dispositifs : quelles capacités soutiennent-ils ? Lesquelles limitent-ils ?

Capabilité	Description	Exemple — handicap
1. La vie	Vivre jusqu'au terme d'une vie humaine normale	Accès aux soins de santé sans discrimination
2. La santé corporelle	Avoir une bonne santé, logement, nutrition	Accessibilité des soins spécialisés
3. L'intégrité corporelle	Se déplacer librement, être à l'abri de la violence	Protection contre les abus en institution
4. Sens, imagination, pensée	Utiliser ses sens, imaginer, raisonner	Accès à l'éducation, aux livres, à la culture
5. Les émotions	S'attacher, aimer, se soucier d'autrui	Maintien des liens familiaux en institution
6. La raison pratique	Former sa propre conception du bien	Soutien à la décision, non substitution
7. L'affiliation	Vivre avec et pour autrui, respecté·e socialement	Inclusion sociale, non-discrimination
8. Les autres espèces	Vivre en rapport avec la nature	Accessibilité des espaces naturels
9. Le jeu	Rire, jouer, jouir d'activités récréatives	Temps libre non structuré en institution
10. Contrôle de l'environnement	Participer aux choix politiques ; contrôler son environnement matériel	Droit de vote accessible, propriété

Appliquée à un dispositif genevois concret — un EPH, un service d'assistance à domicile — cette

liste révèle souvent des angles morts : les capacités 1-3 (vie, santé, intégrité) sont généralement bien couvertes, les capacités 6-7-10 (raison pratique, affiliation, contrôle) sont souvent limitées par les logiques institutionnelles.

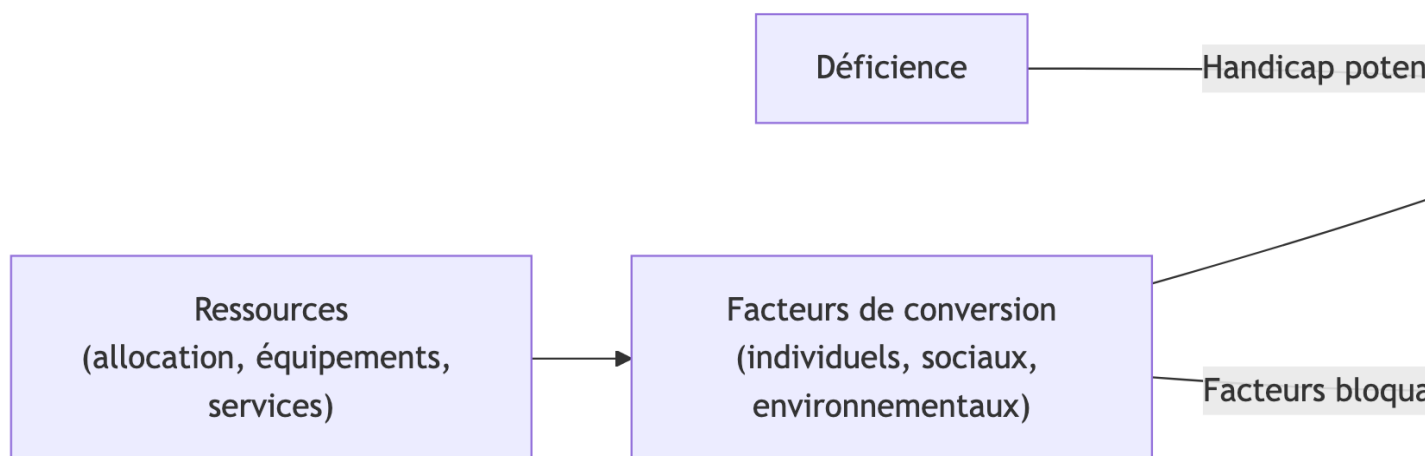
6.3.3 Mitra et le handicap potentiel vs effectif

Sophie Mitra (2006) applique ce cadre directement au handicap. Elle distingue :

- Le **handicap potentiel** : la déficience crée un risque de restriction des capacités — mais cette restriction n'est pas automatique.
- Le **handicap effectif** : la restriction de capacité réellement vécue — qui dépend des facteurs de conversion disponibles.

Cette distinction est cliniquement et politiquement importante. Elle permet de formuler l'objectif du travail social et des politiques sociales non pas comme « compenser la déficience » mais comme « minimiser le handicap effectif » — ce qui peut passer par l'environnement, les services, le soutien social, autant que par la médecine.

En Suisse, **Jean-Michel Bonvin** (UNIGE/HES-SO) a travaillé avec Nicolas Farvaque à l'application des capacités aux politiques sociales suisses. Ils montrent que les politiques d'activation — souvent présentées comme des vecteurs d'autonomie — peuvent en réalité *réduire* les capacités des personnes en les contraignant à des activités qui ne correspondent pas à leurs projets de vie (Bonvin & Farvaque, 2008). La liberté mesurée par les capacités n'est pas la liberté de travailler à n'importe quoi : c'est la liberté de mener la vie qu'on a *raison de valoriser*.



6.4 La CIF revisitée : critique d'Imrie

La CIF (OMS, 2001) a été présentée à la séance 1 comme un progrès par rapport à la classification de 1980, notamment parce qu'elle intègre l'environnement dans l'analyse du handicap. Mais le

modèle dit « biopsychosocial » de la CIF mérite un regard critique.

Rob Imrie (2004) argue que la CIF maintient une normativité médicale sous couvert d'un langage systémique. Les catégories de la CIF restent fondamentalement ancrées dans une évaluation du fonctionnement individuel par rapport à une norme : on mesure ce que la personne ne peut *pas* faire. L'environnement est intégré comme une variable contextuelle, mais il n'est pas reconnu comme le lieu principal de production du handicap. La CIF est plus sophistiquée que la CIDIH, mais elle ne rompt pas avec la logique médicale.

Pour le travail social, cela a des implications pratiques : les évaluations fondées sur la CIF mesurent des **limitations**, pas des **potentiels**. Elles tendent à focaliser l'intervention sur la compensation des manques plutôt que sur le soutien aux capacités. L'approche par les capacités propose un renversement de perspective : non pas « que ne peut-elle pas faire ? » mais « que peut-elle faire si les conditions sont favorables ? ».

i Vignette — Deux bénéficiaires, des capacités inégales

Ahmed et Marianne reçoivent tous deux la même allocation AI mensuelle (ressource identique).

Ahmed vit à Genève : il bénéficie du réseau de transports en commun adapté (Tactile Bus, ascenseurs), d'un réseau associatif actif, d'un service d'interprétariat en langue des signes, d'un centre de vie autonome qui l'accompagne. Ses capacités effectives sont larges.

Marianne vit dans une commune rurale du canton de Vaud : pas de transport adapté, le spécialiste le plus proche est à 40 km, aucun service d'assistance à domicile disponible le week-end, pas de réseau de pair-aidance. Ses capacités effectives sont très réduites.

À ressources égales, leurs capacités effectives sont radicalement différentes — en raison de facteurs de conversion environnementaux.

Question de travail : (1) Identifiez les facteurs de conversion manquants pour Marianne. (2) Que dit ce constat pour la politique sociale : doit-on augmenter les ressources, ou améliorer les facteurs de conversion ? (3) En quoi la critique d'Imrie s'applique-t-elle à cette situation : que mesurerait une évaluation CIF, et qu'omettrait-elle ?

6.5 Tensions pour la pratique professionnelle

⚠ Tension à tenir

L'approche par les capacités déplace la question de « de quoi a-t-il besoin ? » vers « que peut-il réellement faire, et qu'est-ce qui l'en empêche ? ». Ce déplacement est fécond mais exigeant : il demande au·à la professionnel·le de ne pas s'arrêter à la prestation délivrée, mais d'interroger si elle produit réellement une liberté nouvelle pour la personne. Cela suppose une connaissance fine de son environnement, de ses ressources relationnelles, et de ses propres aspirations — pas seulement de ses déficiences.

! À retenir

- La CDPH (2006) est le premier instrument de droit international contraignant centré sur les droits des personnes handicapées. Elle garantit notamment la pleine capacité juridique (art. 12), le droit à la vie dans la société (art. 19), et l'éducation inclusive (art. 24).
- Degener situe la CDPH au terme de quatre étapes : charité → médical → réhabilitation → droits humains. L'égalité transformative distingue les droits réels des droits formels.
- Les capabilités (Sen, Nussbaum) mesurent les libertés réelles, pas les ressources. Le facteur de conversion est le mécanisme qui transforme (ou bloque) la ressource en liberté.
- Mitra distingue le handicap potentiel (risque créé par la déficience) et le handicap effectif (restriction réellement vécue) — l'intervention sociale agit sur les facteurs de conversion.
- La CIF mesure des manques ; les capabilités mesurent des potentiels. Ce renversement a des implications directes pour l'évaluation en travail social.

6.6 Concepts-clés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
CDPH	Convention ONU sur les droits des personnes handicapées (2006/CH 2014)	Nations Unies, 2006	Base juridique contraignante pour toute intervention
Égalité transformative	Dépasser l'égalité formelle pour atteindre une égalité réelle	Degener, 2016	Adapter les outils et procédures selon les besoins
Capabilité	Liberté réelle de mener la vie qu'on a raison de valoriser	Sen ; Nussbaum	Déplacer l'évaluation des déficits vers les libertés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Facteur de conversion	Ce qui transforme (ou bloque) la ressource en capacité réelle	Sen ; Mitra, 2006	Identifier les obstacles environnementaux et sociaux
Handicap potentiel / effectif	Distinction entre risque de restriction et restriction réellement vécue	Mitra, 2006	L'objectif est de minimiser le handicap effectif
Normativité médicale de la CIF	La CIF mesure des manques par rapport à une norme	Imrie, 2004	Compléter les évaluations CIF par une évaluation des capacités
Soutien à la décision	Accompagnement pour que la personne décide elle-même (≠ tutelle)	Art. 12 CDPH	Posture à construire activement dans l'accompagnement

Questions de réflexion

1. L'article 12 CDPH exige que la tutelle soit remplacée par des systèmes de soutien à la décision. Comment imaginez-vous concrètement le travail du TS dans un dispositif de soutien à la décision pour une personne avec déficience intellectuelle sévère ?
2. La notion de « vie qu'on a raison de valoriser » (Sen) suppose que la personne peut définir elle-même ce qui compte pour elle. Quand une personne a passé vingt ans en institution et que sa carrière morale a été fortement façonnée par cette institution, dans quelle mesure peut-on parler de choix libre ? Que fait-on avec cette question dans la pratique ?
3. Bonvin et Farvaque montrent que les politiques d'activation peuvent réduire les capacités. Connaissez-vous des dispositifs suisses de réinsertion pour personnes handicapées qui produisent cet effet ? Comment les identifier ?
4. La liste des dix capacités de Nussbaum est-elle vraiment universelle ? Y a-t-il des capacités culturellement situées, ou des capacités absentes de la liste qui vous semblent

importantes pour les personnes que vous avez rencontrées ?

Activité pédagogique

Grille des capacités — Évaluer un dispositif genevois · Groupes de 3-4 · 30 min

6.6.1 Consignes

1. Chaque groupe reçoit une fiche descriptive d'un dispositif genevois (EPH, service d'assistance à domicile, programme d'emploi accompagné, atelier protégé).
2. À partir des 10 capacités centrales de Nussbaum, le groupe remplit un tableau en trois colonnes : (a) quelles capacités ce dispositif soutient activement, (b) quelles capacités il limite implicitement, (c) quelles capacités il ignore complètement.
3. Chaque groupe formule une recommandation : si vous pouviez modifier une seule chose dans ce dispositif pour améliorer les capacités des bénéficiaires, que modifieriez-vous ?
4. Restitution en plénière (2 min par groupe).

6.6.2 Débriefing

- Quels angles morts communs observe-t-on entre les dispositifs ? (Hypothèse : la raison pratique et le contrôle de l'environnement sont souvent les moins bien couverts)
- Un dispositif peut-il à la fois soutenir certaines capacités et en limiter d'autres ? Qu'est-ce que cela implique pour l'évaluation globale ?
- En quoi cette grille est-elle différente d'une évaluation CIF ? Qu'est-ce qu'elle voit que la CIF ne voit pas ?

6.6.3 Variante en ligne

En cas d'enseignement à distance ou hybride, l'activité peut être adaptée comme suit :

- **Nuage de mots** (Mentimeter ou Wooclap) : en plénière, demander à tou·te·s les étudiant·e·s de saisir la capacité qu'ils·elles jugent la plus souvent ignorée dans les dispositifs — le nuage visualise les convergences.
- **Tableau collaboratif** (Padlet) : chaque groupe crée une colonne pour son dispositif et y dépose ses observations sous forme de post-its ; les colonnes restent visibles pour tous lors de la restitution.
- La recommandation finale peut être formulée dans un fil de discussion synchrone ou un document partagé avant la mise en commun.

Pour aller plus loin

6.6.1 Lectures obligatoires

- Degener, T. (2016). Disability in a human rights context. *Laws*, 5(3), 35. doi:10.3390/laws5030035
- Mitra, S. (2006). The capability approach and disability. *Journal of Disability Policy Studies*, 16(4), 236-247.

6.6.2 Lectures complémentaires

- Nussbaum, M. C. (2006). *Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership*. Harvard University Press (chap. 3).
- Imrie, R. (2004). Demystifying disability : a review of the International Classification of Functioning, Disability and Health. *Sociology of Health & Illness*, 26(3), 287-305.
- Bonvin, J.-M. & Farvaque, N. (2008). *Amartya Sen. Une politique de la liberté*. Michalon (chap. 4 : « Capabilités et politiques sociales »).
- Nations Unies (2006). *Convention relative aux droits des personnes handicapées*. Texte intégral, disponible sur www.un.org/disabilities.

6.6.3 Ressources en ligne

- [Texte intégral de la CDPH — Nations Unies \(français\)](#) — Version officielle, avec protocole facultatif.
- [Degener \(2016\), « Disability in a Human Rights Context »](#) — accès libre (MDPI) — Article fondateur sur le modèle des droits humains du handicap.
- [Human Development & Capability Association — ressources introductives](#) — Textes introductifs sur l’approche par les capabilités de Sen et Nussbaum.

7 Séance 6 — Désinstitutionnalisation et habitat inclusif

Droits et réalités

[Diapositives de la séance](#) [Version PDF du cours](#)

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, l'étudiant-e est capable de :

- Distinguer « désinstitutionnalisation » (fermeture des murs) et « dés-institutionnalisation » (transformation des pratiques)
- Articuler le contenu de l'article 19 CDPH avec les réalités institutionnelles suisses
- Retracer les cinq principes du mouvement Independent Living et leur influence sur les politiques
- Identifier les tensions entre la position d'Inclusion Handicap (droits) et celle d'INSOS (réalisme institutionnel)
- Analyser la situation genevoise à la lumière des outils du module

7.1 Introduction

La désinstitutionnalisation est l'une des transformations les plus radicales que connaît le champ du handicap depuis quarante ans. Elle désigne un mouvement — à la fois politique, juridique et pratique — qui remet en cause l'organisation des soins et de l'accompagnement autour de grandes institutions résidentielles séparatives, au profit de formes de vie dans la communauté.

Ce mouvement n'est pas achevé. En Suisse, il est même à peine engagé au niveau national. Cette séance examine les fondements du droit, les origines du mouvement, les acteurs du débat et les réalités du terrain genevois — en tenant la tension entre l'idéal juridique et les contraintes du réel.

Avant tout, une distinction conceptuelle s'impose, que la littérature anglophone (*deinstitutionalization*) ne fait pas toujours clairement :

- **La désinstitutionnalisation** (avec accent sur le physique) désigne la fermeture ou la réduction des établissements résidentiels — le mouvement de sortie des murs.
- **La dés-institutionnalisation** (avec accent sur les pratiques) désigne la transformation des pratiques institutionnelles — sortir de la logique de l'institution totale même dans les structures qui subsistent, en favorisant l'autodétermination, le choix, la vie ordinaire.

Ces deux processus sont liés mais distincts. On peut fermer des murs sans transformer les pratiques — en recréant dans des appartements dispersés les mêmes logiques de contrôle et de planification. Et on peut transformer des pratiques sans fermer des murs — en faisant évoluer des institutions existantes vers plus d'autonomie et de choix. Pour les *Critical Disability Studies*, la désinstitutionnalisation n'est pas automatiquement positive si elle n'est pas accompagnée des ressources et du soutien nécessaires.

7.2 Article 19 CDPH : le droit de vivre dans la société

L'article 19 de la CDPH constitue la référence juridique centrale :

! Article 19 CDPH — Autonomie de vie et inclusion dans la société

Les États parties reconnaissent à toutes les personnes handicapées **le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes**, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance de ce droit et leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que :

- a) les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence et l'endroit où et avec qui elles vivent ;
- b) les personnes handicapées aient accès à toute une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer ;
- c) les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres.

Cet article est sans ambiguïté : aucune personne handicapée ne peut être contrainte à vivre en institution. L'État a l'obligation positive de créer les conditions — logement adapté, assistance à domicile, services de soutien — qui permettent à chacun de faire ce choix.

Le Comité de l'ONU, dans ses **observations finales** adressées à la Suisse en avril 2022 (plus de 80 recommandations), a identifié la sur-institutionnalisation comme l'un des manquements les plus graves. Il a relevé l'absence de stratégie nationale de désinstitutionnalisation et demandé à la Suisse de mettre fin aux placements non consentis.

7.3 Le mouvement Independent Living

7.3.1 Origines et principes

Le mouvement Independent Living (*Vie autonome* en français) est né aux États-Unis dans les années 1970, sous l'impulsion de personnes handicapées elles-mêmes. **Gerald DeJong** (1979) en formalise le **changement de paradigme** dans un article fondateur : il oppose la logique de la réadaptation (où le professionnel est l'expert qui décide) à la logique de la vie autonome (où la personne handicapée est le décideur principal).

Ed Roberts, fondateur du Center for Independent Living de Berkeley en 1972, en est la figure emblématique. Tétraplégique, il a mené une vie autonome et dirigé l'administration des services aux personnes handicapées de Californie. Il incarne que l'autonomie n'est pas une capacité fonctionnelle mais un **droit politique**.

Le mouvement Independent Living repose sur **cinq principes** :

1. **L'autodétermination** : la personne handicapée est l'expert-e de ses propres besoins et le décideur ultime sur sa vie.
2. **La pair-aidance** : les personnes handicapées sont les mieux placées pour soutenir d'autres personnes handicapées — le savoir expérientiel est une ressource professionnelle légitime.
3. **La responsabilisation individuelle** : avec les droits viennent les responsabilités ; la personne est responsable de ses choix et de leur gestion.
4. **La dé-médicalisation** : le handicap est une question politique et sociale, pas une question médicale. Les Centers for Independent Living sont gérés par et pour des personnes handicapées, sans direction médicale.
5. **Le changement systémique** : l'objectif n'est pas seulement d'aider des individus à vivre de manière autonome, mais de transformer les systèmes — le logement, les transports, l'emploi, la politique — pour qu'ils permettent cette vie.

En Europe, **Adolf Ratzka** (Suède) fonde l'**ENIL** (European Network on Independent Living) et milite pour la généralisation des paiements directs aux personnes handicapées, permettant à chacun d'employer ses propres assistant-e-s. Cette logique est directement à l'origine de la contribution d'assistance suisse (séance 4).

7.3.2 La désinstitutionnalisation dans le monde

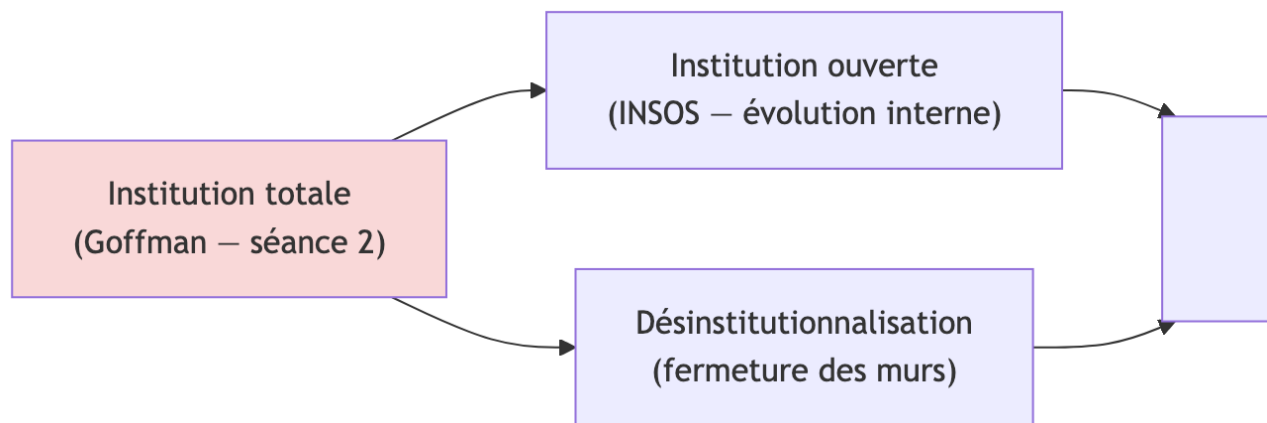
La désinstitutionnalisation a des histoires nationales très différentes :

- **Suède** : avant-garde mondiale, loi de 1985 fermant les grandes institutions, réseau de services individualisés développé depuis les années 1980.
- **Italie** : loi Basaglia (1978) fermant les hôpitaux psychiatriques — une révolution portée par un mouvement social fort, mais dont la mise en œuvre a été inégale.
- **Royaume-Uni** : politique de *care in the community* des années 1990, dont les effets

ont été mitigés : sans ressources suffisantes, la sortie de l'institution a parfois signifié l'abandon dans le community plutôt que l'intégration.

- **États-Unis** : Americans with Disabilities Act (ADA, 1990) et arrêt Olmstead de la Cour Suprême (1999) qui oblige les États à proposer des alternatives communautaires à l'institutionnalisation.

L'expérience britannique est un avertissement : **la désinstitutionnalisation sans ressources n'est pas une libération**. Elle peut produire de l'isolement, de la précarité et de l'abandon. C'est l'argument des *Critical Disability Studies* : l'art. 19 CDPH exige non seulement la sortie des institutions, mais la mise en place des services d'appui qui rendent la vie dans la communauté réellement possible.



7.4 Situation suisse : la sur-institutionnalisation

Malgré la ratification de la CDPH en 2014, la Suisse maintient un taux d'institutionnalisation des personnes handicapées parmi les plus élevés d'Europe occidentale. L'OFS recense environ **150 000 personnes** vivant en institution (homes, foyers, EPH, structures résidentielles pour personnes handicapées), contre une proportion bien plus faible dans des pays comme la Suède ou le Royaume-Uni.

Les raisons de cette situation sont multiples :

- La **structure fédéraliste** délègue aux cantons la compétence en matière d'institutions sociales, ce qui rend difficile une stratégie nationale coordonnée.
- Les **institutions représentent des acteurs puissants** — employeurs importants, gestionnaires de biens immobiliers considérables, acteurs politiques dans leurs cantons.
- Les **familles**, souvent épuisées par des années d'accompagnement sans soutien adéquat, voient parfois dans l'institution une réponse à un manque de services à domicile — pas un choix idéologique.
- Les **finances cantonales** : développer des services ambulatoires coûte, au moins à court terme, plus cher que de maintenir des institutions existantes — même si, à long terme, la

vie autonome soutenue est souvent moins coûteuse que l'hébergement institutionnel.

7.5 Les EPI genevois : entre poids institutionnel et aspiration inclusive

À Genève, les **Établissements publics pour l'intégration (EPI)** constituent l'opérateur public majeur du champ du handicap. Ils accompagnent environ 3 000 personnes, gèrent des structures résidentielles (les EPH — Établissements pour personnes handicapées), des ateliers protégés, des services d'intégration et des programmes de jour.

Dans les années récentes, les EPI ont développé des initiatives vers l'habitat inclusif : projets d'appartements accompagnés, coopérations avec l'IMAD (Institution genevoise de maintien à domicile) pour l'assistance à domicile, soutien à des colocations accompagnées (le projet « Appartements avec soutien »). Ces évolutions sont réelles — mais elles coexistent avec un modèle institutionnel résidentiel qui reste dominant.

Les **formes intermédiaires** qui se développent dans le canton illustrent le continuum entre institution et vie autonome :

- **Collocations encadrées** : plusieurs personnes partagent un appartement ordinaire avec un accompagnement hebdomadaire d'un éducateur référent.
- **Appartements avec soutien (SIL — Supported Independent Living)** : la personne vit seule, avec un soutien modulable selon ses besoins (de quelques heures par semaine à une présence quotidienne).
- **Foyers de transition** : hébergement temporaire visant la préparation à une vie plus autonome, avec formation aux compétences de la vie quotidienne.
- **Modèle IMAD-EPI** : coordination entre l'institution genevoise de maintien à domicile (pour le grand âge et les soins de santé) et les services du handicap (pour l'accompagnement social).

La tension entre les deux logiques est incarnée par deux acteurs nationaux aux positionnements contrastés :

- **INSOS** (fédération nationale des institutions sociales) défend le modèle des « institutions ouvertes » : des institutions qui évoluent, qui développent des services ambulatoires, qui réduisent leur résidentialisation sans pour autant disparaître. Position pragmatique.
- **Inclusion Handicap** (association faîtière des organisations de personnes handicapées) revendique la mise en œuvre intégrale de l'art. 19 CDPH et une stratégie nationale de désinstitutionnalisation avec un calendrier défini. Position de droits.

Ce débat n'est pas clos. Il est au cœur de l'initiative « Pour l'inclusion » (2026) et des négociations parlementaires actuelles.

i Vignette — Paul, 45 ans, trisomie

Paul a 45 ans. Il est porteur de trisomie 21 et vit en EPH depuis l'âge de 25 ans. Sa vie y est organisée : atelier de menuiserie le matin, activités de groupe l'après-midi, chambre individuelle, repas communs. L'équipe le connaît bien et l'apprécie. Le cadre est sécurisant. Depuis quelques mois, Paul répète à son éducateur référent qu'il voudrait « avoir un vrai appartement, comme son frère ». Il a visité un appartement accompagné proposé par une association et est enthousiaste. Il a rencontré un pair-aidant qui vit de manière autonome avec une déficience intellectuelle.

L'institution hésite. La responsable d'équipe dit : « Paul ne sait pas cuisiner. Il oublie de prendre ses médicaments. Il n'a pas de réseau en dehors de nous. En cas de crise, qui interviendra à 3h du matin ? » Paul dit : « Je peux apprendre à cuisiner. Et je veux essayer. »

Question de travail : (1) Identifiez les arguments de protection de l'équipe — lesquels sont légitimes ? Lesquels relèvent du paternalisme ? (2) Quels droits de Paul sont en jeu (mobiliser la CDPH) ? (3) Quels facteurs de conversion (séance 5) manquent à Paul pour que son projet devienne réalisable ? (4) Quelle serait une procédure d'évaluation individualisée respectueuse de ses droits ?

7.6 Tensions pour la pratique professionnelle

⚠ Tension à tenir

Le droit de Paul à vivre hors de l'institution est garanti par l'art. 19 CDPH. Ses limites fonctionnelles réelles méritent un accompagnement — pas une exclusion. La tension entre le droit et la protection ne se résout pas par la primauté automatique de l'un sur l'autre : elle demande une évaluation individualisée, menée *avec* Paul, qui distingue ce qu'il ne peut pas faire de ce qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'apprendre. Et qui distingue la protection légitime (un plan de crise réel) du paternalisme masqué (« il ne pourra jamais »).

! À retenir

- La désinstitutionnalisation désigne la sortie des murs ; la dés-institutionnalisation désigne la transformation des pratiques. Les deux processus sont nécessaires et ne vont pas de soi.
- Le mouvement Independent Living (DeJong, Roberts, Ratzka) a posé cinq principes fondateurs : autodétermination, pair-aidance, responsabilisation, dé-médicalisation, changement systémique.
- La Suisse compte 150 000 personnes en institution — taux parmi les plus élevés d'Europe. Le Comité de l'ONU a demandé une stratégie nationale de désinstitutionnalisation en 2022.

- Les EPI genevois développent des formes intermédiaires (collocations, SIL, appartements avec soutien), mais dans un cadre institutionnel encore dominant.
- La désinstitutionnalisation sans ressources suffisantes n'est pas une libération – l'expérience britannique est un avertissement.

7.7 Concepts-clés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Art. 19 CDPH	Droit de vivre dans la société avec des choix égaux	Nations Unies, 2006	Critère normatif pour évaluer tout dispositif résidentiel
Inde-pendent Living	Paradigme de la vie autonome dirigée par la personne (5 principes)	DeJong, 1979 ; Roberts	Positionner la personne comme décideur, pas comme bénéficiaire
Sur-institutionnalisation	Maintien des liens élevés de placement en institution malgré la CDPH	Comité ONU, 2022	Conscience du contexte structurel de la pratique
Habitat inclusif / SIL	Formes de logement dans la communauté avec services d'appui	Politiques cantonales	Connaître les ressources du territoire
INSOS	Fédération nationale des institutions sociales (logique d'évolution interne)	INSOS Suisse	Interlocuteur principal de la politique institutionnelle

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Inclusion Handicap	Association faîtière des personnes handicapées (logique de droits)	Inclusion Handicap	Porte-parole du droit à la vie dans la communauté
Dés-institutionnalisation	Transformation des pratiques institutionnelles (pas seulement fermeture des murs)	Critical Disability Studies	L'objectif n'est pas la fermeture mais la transformation

Questions de réflexion

1. La position d'INSOS (institutions ouvertes, transformation progressive) et celle d'Inclusion Handicap (stratégie nationale, application de l'art. 19) sont-elles vraiment incompatibles ? Peut-on imaginer une synthèse ? Quelles seraient ses conditions ?
2. L'expérience britannique de *care in the community* a produit, dans certains cas, de l'isolement et de l'abandon. Comment un·e travailleur·euse social·e peut-il·elle distinguer « vie dans la communauté » et « abandon dans la communauté » dans son travail quotidien ?
3. Paul veut un appartement « comme son frère ». Qu'est-ce que ce désir révèle sur les effets de la carrière morale institutionnelle (séance 2) ? Dans quelle mesure son désir est-il vraiment le sien, et dans quelle mesure a-t-il été façonné ou étouffé par vingt ans d'institution ?
4. À Genève, les EPI sont à la fois opérateur de l'institutionnalisation et porteur de projets de vie autonome. Peut-on être les deux à la fois ? Quelles tensions cela crée-t-il pour les professionnel·le·s qui y travaillent ?

Activité pédagogique

Débat structuré — Stratégie nationale de désinstitutionnalisation · Deux équipes + observateur·trice·s · 30 min

7.7.1 Consignes

1. Constitution des équipes (5 min) : l'équipe A défend la position d'Inclusion Handicap, l'équipe B défend la position d'INSOS. Les observateur·trice·s reçoivent une grille d'observation (arguments mobilisés, registres — droit / pragmatisme / coût / expérience vécue).
2. Temps de préparation (5 min) : chaque équipe identifie ses trois arguments principaux et anticipe les objections.
3. Débat (15 min) : format structuré — chaque équipe présente un argument, l'autre répond, puis rebond.
4. Débriefing (5 min) : les observateur·trice·s restituent ce qu'ils-elles ont observé.

7.7.2 Débriefing

- Quels arguments ont été les plus solides de chaque côté ? Lesquels ont été les plus difficiles à contester ?
- Les deux équipes ont-elles utilisé les personnes handicapées comme référence — leur voix, leurs témoignages ? Ou ont-elles argumenté sur leur dos ?
- Y a-t-il des points de tension **irréductibles** entre les deux positions, ou des zones d'accord possible ?

7.7.3 Variante en ligne

En cas d'enseignement à distance ou hybride, l'activité peut être adaptée comme suit :

- **Sondage de positionnement** (Mentimeter ou Wooclap) : avant le débat, chaque étudiant·e indique anonymement sa position de départ sur un curseur entre les deux pôles ; le résultat est affiché et commenté.
- **Débat en salles de réunion** (Zoom breakout rooms) : les équipes préparent leurs arguments en sous-groupes, puis se retrouvent en plénière pour le débat structuré.
- **Tableau de synthèse collaboratif** (Padlet) : les observateur·trice·s alimentent en temps réel un tableau en deux colonnes (arguments Inclusion Handicap / arguments INSOS), visible de tou·te·s pendant et après le débat.

Pour aller plus loin

7.7.1 Lectures obligatoires

- Comité de l'ONU (2022). *Observations finales concernant le rapport initial de la Suisse* (CRPD/C/CHE/CO/1). Nations Unies, Genève (sections sur l'art. 19, pp. 8-10).
- DeJong, G. (1979). Independent living : From social movement to analytic paradigm. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 60(10), 435-446.

7.7.2 Lectures complémentaires

- Inclusion Handicap (2023). *Rapport alternatif à l'ONU sur la mise en œuvre de la CDPH en Suisse*. Berne : Inclusion Handicap.
- INSOS Suisse (2022). *Vers des institutions ouvertes — Prise de position sur la désinstitutionnalisation*. Berne : INSOS.
- Mansell, J. & Ericsson, K. (dir.) (1996). *Deinstitutionalization and Community Living. Intellectual Disability Services in Britain, Scandinavia and the USA*. Chapman & Hall (Introduction).
- Basaglia, F. (2018 [1968]). *L'institution en négation. Rapport sur l'hôpital psychiatrique de Gorizia*. Seuil (Préface de la nouvelle édition).

7.7.3 Ressources en ligne

- [Observations finales du Comité de l'ONU sur la Suisse \(2022\) — texte intégral \(PDF\)](#) — Document de référence pour la situation suisse.
- [European Network on Independent Living \(ENIL\) — ressources et publications](#) — Réseau européen fondé par Adolf Ratzka ; documents de position sur l'art. 19 et la vie autonome.
- [Inclusion Handicap — rapports et prises de position \(accès libre\)](#) — Publications de l'association faîtière suisse des organisations de personnes handicapées.

8 Séance 7 — Autodétermination, pair-aidance et pouvoir d’agir

Co-construire l’accompagnement

[Diapositives de la séance](#) [Version PDF du cours](#)

Objectifs d’apprentissage

À l’issue de cette séance, l’étudiant-e est capable de :

- Définir l’autodétermination au sens de Wehmeyer et en identifier les nuances critiques
- Distinguer le soutien à la décision de la prise de décision à la place de l’autre
- Expliquer le DPA (développement du pouvoir d’agir) et ses implications pratiques
- Identifier les enjeux et les limites de la pair-aidance en travail social
- Articuler les trois niveaux conceptuels : autonomie, autodétermination, pouvoir d’agir

8.1 Introduction

L’autodétermination est aujourd’hui l’un des concepts les plus cités dans le champ du handicap. Elle est mobilisée dans les textes de loi, les référentiels professionnels, les projets d’établissement, les discours politiques. Mais sa fréquence d’usage risque de la vider de son sens : un mot-valise qui permet d’afficher des valeurs sans changer les pratiques.

Cette séance prend le temps de définir précisément ce qu’est l’autodétermination, de distinguer ce qu’elle exige réellement de ce qu’on lui fait parfois dire, et d’examiner ses limites. Elle introduit également deux concepts étroitement liés — le développement du pouvoir d’agir (DPA) et la pair-aidance — qui déplacent la question de la compétence individuelle à la relation et au collectif. Elle s’appuie notamment sur des travaux menés en Suisse romande, qui montrent comment les institutions peuvent simultanément proclamer l’autodétermination et en limiter

l'exercice par leurs routines quotidiennes.

8.2 Trois niveaux conceptuels : autonomie, autodétermination, pouvoir d'agir

Avant d'entrer dans les définitions, il faut distinguer trois niveaux que l'usage courant tend à confondre :

- **L'autonomie** désigne une capacité générale — la capacité d'un individu à fonctionner sans aide extérieure dans un domaine donné. C'est une notion fonctionnelle, qui peut être évaluée, quantifiée, comparée. On peut être autonome pour se déplacer et dépendant pour se nourrir.
- **L'autodétermination** désigne l'exercice effectif du choix et de la décision dans sa propre vie — être l'agent causal de sa propre existence. L'autodétermination ne suppose pas l'autonomie fonctionnelle : une personne qui ne peut pas se déplacer seule peut parfaitement décider où elle veut aller. La dépendance à l'assistance n'est pas incompatible avec l'autodétermination.
- **Le pouvoir d'agir** (empowerment) est un processus social — pas seulement individuel. Il s'agit de transformer les conditions qui limitent l'exercice de la puissance d'agir : les rapports de pouvoir, les structures institutionnelles, les normes culturelles. Le pouvoir d'agir ne se développe pas dans un individu isolé, mais dans un contexte relationnel et politique.

Cette distinction n'est pas seulement académique. Elle a des implications directes pour la pratique : une intervention qui vise uniquement l'autonomie fonctionnelle peut améliorer la compétence de la personne sans augmenter son autodétermination — si les choix réels restent entre les mains des professionnel·le·s.

8.3 L'autodétermination : être l'agent causal de sa vie

Michael Wehmeyer (Wehmeyer, 1999) définit l'autodétermination comme le fait d'agir comme l'**agent causal premier** de sa propre vie — faire des choix et prendre des décisions sans influence externe induite. Il identifie quatre attributs caractéristiques d'un comportement autodéterminé :

1. **L'agentivité comportementale** (*behavioral autonomy*) : agir en fonction de ses propres préférences, valeurs et capacités.
2. **Les comportements auto-régulés** (*self-regulated behaviors*) : être capable de planifier, d'évaluer ses propres actions et d'ajuster ses stratégies.
3. **Les perspectives psychologiques autonomes** (*psychologically empowered*) : croire que l'on est capable d'agir, que ses actions auront un effet — ce que la psychologie sociale appelle le sentiment d'efficacité personnelle (Bandura).
4. **La conscience de soi** (*self-realizing*) : se connaître suffisamment pour faire des choix cohérents avec ses valeurs, ses forces et ses limites.

Deux précisions s'imposent. D'abord, l'expression « sans influence externe indue » est essentielle : elle ne signifie pas « sans influence ». Toute personne est influencée par ses proches, sa culture, ses expériences. L'autodétermination ne requiert pas l'indépendance totale — elle requiert l'absence de contrôle ou de pression qui supprime le choix.

Ensuite, Wehmeyer a développé ce concept dans le contexte de la **déficiences intellectuelle** — un contexte où l'autodétermination a longtemps été niée au motif de l'incapacité présumée. Sa pertinence dans d'autres contextes du handicap est indéniable, mais les modalités de soutien varient considérablement selon les situations.

8.4 Soutien à la décision versus prise de décision

Cudré-Mauroux, Piérart et Vaucher (Cudré-Mauroux et al., 2020) apportent une nuance romande et critique décisive : l'autodétermination n'est pas un attribut individuel que la personne possède ou ne possède pas. Elle **se co-construit dans la relation** socio-éducative. Cette perspective déplace la responsabilité : ce n'est pas à la personne de « devenir » autodéterminée ; c'est au-la professionnel-le de créer les conditions qui rendent possible l'expression de l'autodétermination.

Leur étude menée dans trois institutions romandes révèle un **paradoxe institutionnel** : les institutions qui déclarent formellement promouvoir l'autodétermination peuvent simultanément la limiter par leurs routines quotidiennes — les horaires imposés, les décisions prises en réunion d'équipe sans la personne, les activités proposées mais pas choisies. L'écart entre le discours affiché et la pratique réelle peut être considérable.

La distinction entre les trois modalités de décision est fondamentale :

- **Prise de décision à la place** : le-la professionnel-le, fort-e de son expertise, décide ce qui est bon pour la personne. La personne est destinataire de la décision.
- **Prise de décision par procuration** : le-la professionnel-le décide en se demandant « qu'est-ce que la personne voudrait ? » — meilleure intention, mais toujours substitution.
- **Soutien à la décision** : le-la professionnel-le offre des options réelles, présente l'information de manière accessible, écoute et prend au sérieux les préférences exprimées, y compris celles qui lui semblent discutables, et partage la responsabilité du résultat.

Le soutien à la décision est exigeant. Il demande du temps, de la créativité (rendre l'information accessible à des personnes qui ne lisent pas, par exemple), et de la tolérance à l'incertitude — la personne peut faire un choix que le-la professionnel-le juge sous-optimal. Ce dernier point est souvent le plus difficile : *si je crois que ce n'est pas le bon choix, est-ce que je peux vraiment le soutenir ?*

En Suisse romande, des démarches concrètes ont été développées en réponse à ces questions. L'AFRAHM et l'INSOS ont publié des **guides d'autodétermination** destinés aux équipes éducatives, avec des outils pratiques : pictogrammes pour rendre les choix accessibles, grilles d'observation pour documenter les préférences, protocoles pour les décisions complexes. Le projet « soutien à la décision » développé dans plusieurs institutions valaisannes et genevoises

expérimente des approches où la personne est présente aux décisions qui la concernent — y compris les décisions institutionnelles.

8.5 Le développement du pouvoir d'agir (DPA)

Yann Le Bossé (Le Bossé, 2003) formule le **développement du pouvoir d'agir** (DPA) comme un cadre d'intervention centré sur l'objectif suivant : viser « *un plus grand contrôle sur ce qui est important pour soi* ». Le DPA ne suppose pas que la personne est passive ou impuissante ; il suppose que des contextes sociaux défavorables peuvent limiter l'exercice de la puissance d'agir qui existe en chacun.

Le DPA se distingue de l'empowerment à l'américaine par quatre orientations spécifiques :

1. **Une vision politique** (et pas seulement clinique) : les difficultés des personnes ne sont pas que des problèmes individuels — elles reflètent des rapports de pouvoir et des structures sociales inégales.
2. **Une orientation vers l'action** : l'intervention ne vise pas la compréhension seule, mais le changement concret.
3. **Une attention à l'environnement** : travailler sur les obstacles externes, pas seulement sur les ressources internes de la personne.
4. **Une démarche collaborative** : le-la professionnel-le n'est pas l'expert qui sait où la personne doit aller — il-elle accompagne la personne dans la définition de ce qu'elle veut.

Une mise en garde importante est formulée par **Isabelle Astier** (Astier, 2007) : l'autonomie peut devenir une **discipline imposée** — un devoir social de se prendre en main, qui redistribue la responsabilité de l'échec sur la personne elle-même. « *Ne pas être capable d'autonomie devient une défaillance personnelle* », écrit-elle. Le risque est de transformer un droit (le droit à l'autodétermination) en obligation (il faut être autonome, sinon c'est de ta faute). Cette inversion est particulièrement visible dans les politiques d'activation des personnes handicapées dans le marché du travail.

Astier pointe également l'existence de personnes qui ne veulent pas être autonomes, ou qui n'en ont pas les ressources immédiates. L'injonction à l'autonomie peut alors devenir une forme de violence supplémentaire, qui ignore les conditions matérielles et relationnelles dans lesquelles vit la personne (voir aussi séance 8 sur le financement orienté personne).

8.6 La pair-aidance : le savoir expérientiel reconnu

La **pair-aidance** désigne le soutien apporté par une personne ayant vécu une expérience similaire à celle de la personne accompagnée. Dans le champ du handicap, cela signifie concrètement qu'une personne en situation de handicap accompagne une autre dans son parcours.

Le principe de la pair-aidance repose sur la reconnaissance du **savoir expérientiel** comme une forme de connaissance légitime, complémentaire du savoir professionnel. La personne qui a

vécu la situation — l'annonce du diagnostic, la sortie d'institution, la recherche d'un-e assistant-e, la confrontation avec l'administration de l'AI — sait des choses que le-la professionnel-le ne peut pas savoir, même avec la meilleure formation. Ce n'est pas que le savoir professionnel soit inférieur : c'est qu'il est d'une autre nature.

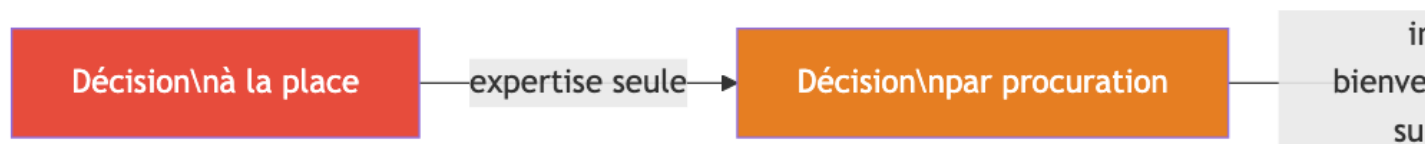
Il faut distinguer deux formes de pair-aidance :

- **La pair-aidance informelle** : des personnes se soutiennent mutuellement dans le cadre d'associations, de groupes de soutien, de réseaux en ligne. Elle n'est pas rémunérée et repose sur la solidarité.
- **La pair-aidance formelle** : des **pair-aidant-e-s professionnel-le-s** sont employé-e-s et rémunéré-e-s pour leur rôle d'accompagnement dans des institutions ou des services. Ils-elles ont généralement reçu une formation spécifique.

Cette formalisation soulève des questions qui n'ont pas de réponse simple. Où s'arrête l'expérience personnelle et où commence la compétence professionnelle ? Comment maintenir la spécificité du savoir expérientiel quand on lui impose un cadre institutionnel ? Comment éviter que la pair-aidance ne devienne une prestation précaire et sous-payée, justifiée par la seule expérience et qui dispense l'institution d'embaucher des professionnel-le-s qualifié-e-s ?

Il faut également nommer les **risques** spécifiques à la pair-aidance : l'épuisement émotionnel (réactiver en permanence sa propre expérience douloureuse au service des autres), le brouillage des rôles (entre l'ami-e et le-la professionnel-le), et l'instrumentalisation (utiliser l'expérience personnelle comme ressource bon marché sans investir dans un vrai statut professionnel).

8.7 Diagramme : du contrôle à la co-construction



i Vignette — Lucas et le choix de l'atelier

Lucas a 30 ans et une déficience intellectuelle légère. Il vit en appartement accompagné depuis trois ans — une transition organisée avec l'appui d'un éducateur référent, dans le cadre du projet de désinstitutionnalisation de l'établissement (voir séance 2). Il fréquente un atelier de jour cinq matinées par semaine.

Le moment est venu de choisir l'atelier pour la nouvelle année. Quatre options sont disponibles : cuisine, jardinage, menuiserie, arts plastiques. L'éducateur référent présente les options lors de l'entretien individuel mensuel. À chaque option présentée, Lucas dit

« c'est bien ». « C'est bien » à la cuisine. « C'est bien » au jardinage. « C'est bien » à tout. L'éducateur a l'habitude de lui proposer la cuisine — « il aime bien manger ». C'est ainsi que la décision se prend depuis deux ans.

Questions de travail : Est-ce du soutien à la décision ? Qu'est-ce que le comportement de Lucas révèle sur son apprentissage de la relation avec les professionnels ? Comment procéderiez-vous autrement — et quelles contraintes institutionnelles devriez-vous négocier pour y parvenir ?

8.8 Tensions pour la pratique professionnelle

⚠ Tension à tenir

L'autodétermination est un droit — pas une condition préalable à l'accompagnement. Une personne qui ne sait pas encore formuler ses préférences, ou qui a appris à dire « oui » pour éviter le conflit, a autant droit à un soutien à l'autodétermination qu'une personne qui exprime clairement ses désirs. La posture professionnelle consiste à créer les conditions de l'expression — pas à attendre qu'elle se produise spontanément.

La tentation inverse existe aussi : promouvoir l'autodétermination comme une fin en soi, au point de laisser la personne seule face à des décisions qui dépassent ses ressources actuelles. Le soutien à la décision n'est pas l'abandon.

! À retenir

- L'autodétermination est l'exercice effectif du choix — elle ne suppose pas l'indépendance fonctionnelle.
- Les quatre attributs de Wehmeyer (agentivité, autorégulation, pouvoir psychologique, conscience de soi) constituent un cadre d'analyse, pas un critère d'admission au droit à l'autodétermination.
- Le paradoxe romand de Cudré-Mauroux : les institutions peuvent proclamer l'autodétermination et la limiter simultanément par leurs routines.
- Le DPA (Le Bossé) situe l'obstacle dans les structures sociales, pas seulement dans les individus.
- La discipline de l'autonomie (Astier) : quand le droit devient obligation, la responsabilité de l'échec est reportée sur la personne.
- La pair-aidance reconnaît le savoir expérientiel comme légitime — mais sa formalisation comporte des risques d'instrumentalisation.

8.9 Concepts-clés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Agent causal	Personne qui initie et dirige ses propres actions	Wehmeyer, 1999	L'accompagnement vise à renforcer cette agentivité, pas à la remplacer
Soutien à la décision	Offrir des options réelles et prendre au sérieux les préférences	Cudré-Mauroux et al., 2020	Exige du temps, de l'accessibilité de l'info, et de la tolérance à l'incertitude
DPA	Développement du pouvoir d'agir — viser un plus grand contrôle sur ce qui compte	Le Bossé, 2003	Travailler sur les obstacles environnementaux, pas seulement les ressources individuelles
Discipline de l'autonomie	Inversion du droit à l'autonomie en obligation de se prendre en charge	Astier, 2009	Vigilance contre les injonctions qui reportent la responsabilité sur la personne
Savoir expérientiel	Connaissance produite par l'expérience vécue, reconnue comme légitime	Mouvement de la pair-aidance	Intégrer les pair-aidant·e·s comme ressources dans l'équipe, pas comme substituts
Pair-aidance formelle	Pair-aidant·e rémunéré·e et formé·e, distinct de l'amitié	INSOS ; AFRAHM	Définir un statut clair pour éviter l'épuisement et l'instrumentalisation

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Paradoxe institutionnel	Écart entre autodétermination proclamée et pratiques quotidiennes	Cudré-Mauroux et al., 2020	Analyser les routines institutionnelles comme indicateurs de la pratique réelle

Questions de réflexion

1. Lucas dit « c'est bien » à toutes les options. Peut-on parler d'un apprentissage de la complaisance — et si oui, qui l'a produit ? Quelles pratiques institutionnelles pourraient expliquer ce comportement ?
2. Astier parle de la « discipline de l'autonomie ». Connaissez-vous des situations dans votre stage ou votre expérience où l'injonction à l'autonomie a produit l'effet inverse de ce qui était recherché ?
3. Une institution décide de former ses équipes à l'autodétermination. Six mois après, les réunions de résidents existent, les pictogrammes sont disponibles — mais les décisions importantes continuent d'être prises par les professionnels en réunion d'équipe. Que manque-t-il ? Que proposeriez-vous ?
4. La pair-aidance reconnaît le savoir expérientiel comme légitime. Mais une personne ayant vécu une situation de handicap particulière peut-elle accompagner quelqu'un dont la situation est très différente ? Où sont les limites du savoir expérientiel comme ressource professionnelle ?

Activité pédagogique

Jeu de rôle — Décider pour / avec / par · Trios (A : Lucas, B : éducateur·trice, C : observateur·trice) · 30 min

8.9.1 Consignes

La même situation (Lucas choisit son atelier pour l'année) est jouée en trois versions successives.

1. **Version 1 — Décision à la place** : l'éducateur·trice décide pour Lucas (« tu vas à la cuisine, tu aimes bien manger »). Il·elle justifie par son expertise et sa connaissance de Lucas.

2. **Version 2 — Consultation formelle** : l'éducateur·trice présente les options et demande l'avis de Lucas, mais oriente visiblement vers la cuisine. Il·elle reprend la parole après chaque réponse de Lucas pour la commenter.
3. **Version 3 — Soutien à la décision** : l'éducateur·trice s'adapte au rythme de Lucas, propose de visiter les ateliers avant de décider, laisse le silence, reprend les préférences exprimées sans les réorienter, accepte une réponse qui n'est pas celle qu'il·elle attendait.

L'observateur·trice note : qui parle le plus ? Qui décide réellement ? Comment le silence est-il géré ? Quelle posture corporelle adopte l'éducateur·trice ?

8.9.2 Débriefing

- Qu'est-ce qui change dans chaque version du point de vue de Lucas ?
- Qu'est-ce qui est difficile pour l'éducateur·trice dans la version 3 — et pourquoi ?
- Quelles contraintes institutionnelles rendraient la version 3 difficile à maintenir au quotidien ?

8.9.3 Variante en ligne

En cas d'enseignement à distance ou hybride, l'activité peut être adaptée comme suit :

- **Jeu de rôle en salles de réunion** (Zoom breakout rooms) : les trios sont répartis en sous-groupes ; les trois versions peuvent être jouées en texte (chat) ou en audio/vidéo selon les préférences.
- **Nuage de mots** (Mentimeter ou Wooclap) : après chaque version, demander à tou·te·s d'écrire en un mot ce qu'ils·elles ont ressenti côté Lucas — les nuages successifs visualisent l'évolution.
- **Restitution collaborative** (Padlet) : chaque trio dépose ses observations sur les trois versions ; le tableau collectif permet une mise en commun structurée lors du débriefing en plénière.

Pour aller plus loin

8.9.1 Lectures obligatoires

- Cudré-Mauroux, A., Piérart, G. & Vaucher, C. (2020). L'autodétermination des personnes en situation de handicap : un construit relationnel et contextuel. *Alter*, 14(2), 79-94.
- Le Bossé, Y. (2003). De l'« habilitation » au « pouvoir d'agir » : vers une appréhension plus circonscrite de la notion d'empowerment. *Nouvelles pratiques sociales*, 16(2), 30-51.

8.9.2 Lectures complémentaires

- Wehmeyer, M. L. (1999). Self-determination, student involvement, and leadership development. In S. H. de Fur & J. R. Patton (Eds.), *Transition and School-Based Services* (pp. 37-58). PRO-ED.
- Astier, I. (2009). Les transformations de la relation d’aide dans les métiers du social. *Informations sociales*, 152, 52-58.
- INSOS Suisse (2020). *Soutien à l’autodétermination – Guide pratique pour les équipes éducatives*. Berne : INSOS.

8.9.3 Ressources en ligne

- [Le Bossé \(2003\), « De l’habilitation au pouvoir d’agir » – accès libre \(Érudit\)](#) – Article fondateur sur le DPA, disponible en accès ouvert.
- [INSOS Suisse – publications sur l’autodétermination \(accès libre\)](#) – Guides pratiques et fiches outils pour les équipes éducatives.
- [AFRAHM – ressources sur l’autodétermination et le soutien à la décision](#) – Publications de l’association francophone belge, applicable au contexte romand.

9 Séance 8 — Financement orienté personne

Émancipation ou logique de marché ?

[Diapositives de la séance](#) [Version PDF du cours](#)

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, l'étudiant-e est capable de :

- Retracer l'histoire du financement du handicap en Suisse (charité → assurance → marché)
- Distinguer le financement de l'objet et le financement du sujet
- Expliquer le fonctionnement de la contribution d'assistance AI suisse et ses effets pratiques
- Identifier l'ambivalence des paiements directs entre émancipation et logique de marché
- Mobiliser les résultats de Tabin et al. (2024) sur l'exclusion épistémique dans l'AI

9.1 Introduction

La question du financement n'est pas une question technique : c'est une question politique. La manière dont une société finance l'accompagnement des personnes handicapées révèle les valeurs qu'elle leur attribue, le rôle qu'elle accorde aux institutions et aux professionnel-le-s, et les libertés qu'elle reconnaît ou nie.

Ce basculement est au cœur de cette séance : le passage du financement de l'objet (subventionner l'institution) au financement du sujet (doter la personne). Ce changement est porteur d'une promesse émancipatrice — et d'ambivalences profondes. Pour le comprendre, il faut d'abord retracer la logique historique qui a conduit au modèle actuel.

9.2 Histoire du financement : de la charité à l'assurance au marché

Le financement du handicap n'a pas toujours eu la forme qu'il connaît aujourd'hui. Trois logiques se sont succédé — et, partiellement, superposées.

La logique de l'assistance (jusqu'au milieu du XXe siècle) : les personnes handicapées étaient prises en charge par la charité privée — Églises, associations philanthropiques, familles. Cette logique ne reconnaît pas de droit : elle distribue une grâce. La personne est un bénéficiaire passif de la générosité d'autrui. Elle n'a pas de levier pour exiger quoi que ce soit.

La logique de l'assurance (à partir des années 1960) : la création de l'assurance-invalidité (AI) en 1960 marque une transformation profonde. La personne handicapée devient un **assuré** — elle a des droits définis par la loi, qui peuvent être revendiqués. L'État prend en charge le financement, via des cotisations obligatoires. Mais la logique reste celle de la compensation d'une incapacité : c'est l'institution qui définit les besoins, distribue les prestations, contrôle les conditions.

La logique du marché (à partir des années 1990-2000) : la montée des politiques néolibérales et du nouveau management public transforme le rapport entre l'État, les institutions et les personnes. L'idée directrice est la suivante : si la personne dispose d'un budget personnel et peut choisir ses prestataires, la concurrence entre prestataires améliorera la qualité des services. Les paiements directs — dont la contribution d'assistance suisse est une expression — s'inscrivent dans cette logique.

Ces trois logiques coexistent dans le système actuel. L'AI conserve une forte logique assurantielle ; la contribution d'assistance introduit une logique de marché ; les institutions cantonales fonctionnent avec des restes de logique philanthropique dans leur culture.

9.3 Du financement de l'objet au financement du sujet

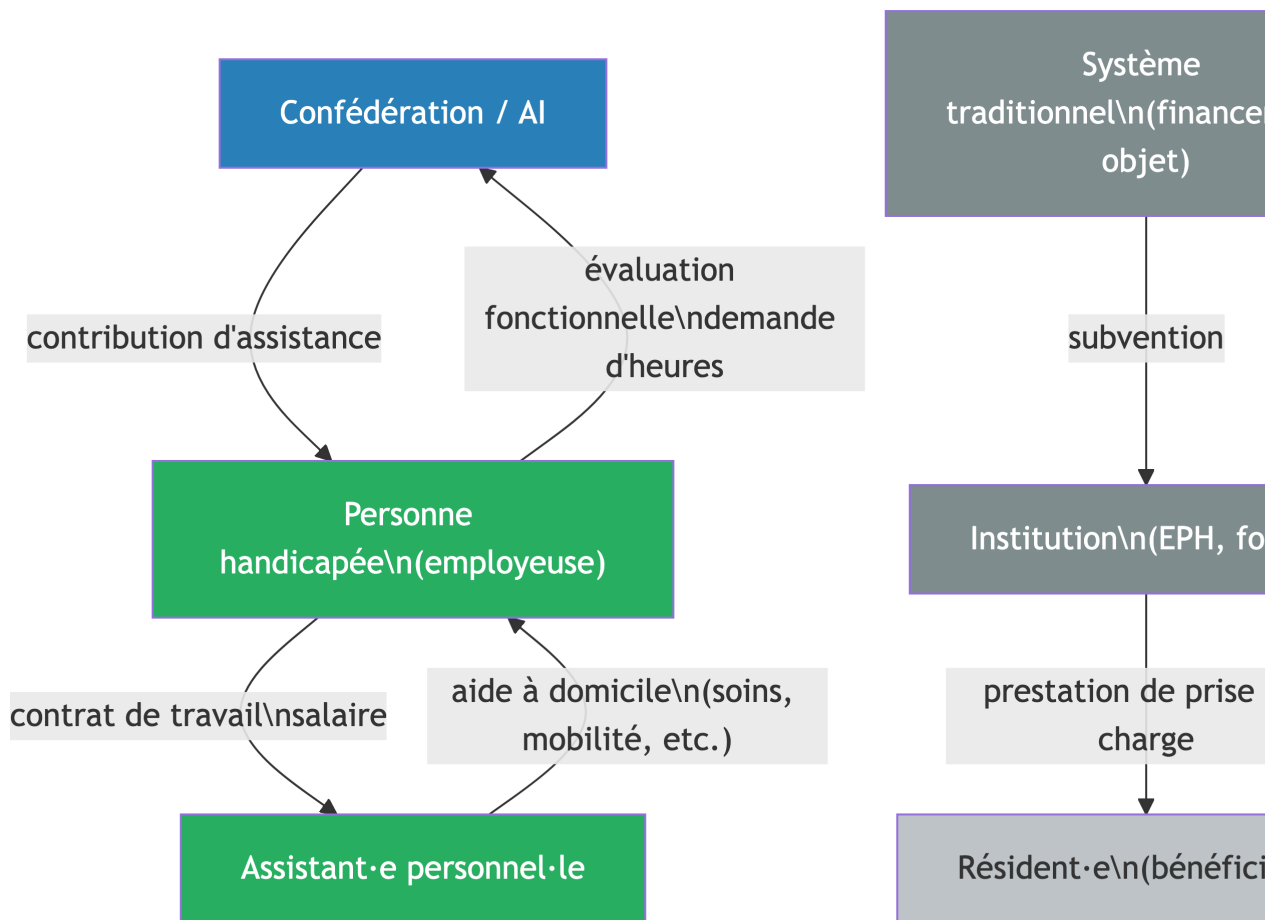
Dans le système helvétique traditionnel, les cantons et la Confédération subventionnent les **institutions** — les foyers, les EPH, les ateliers protégés. L'institution reçoit des fonds en échange de la prise en charge de résidents. La personne handicapée est au bout de la chaîne : elle bénéficie des services de l'institution, mais elle ne contrôle ni leur contenu ni leur organisation. Elle est l'objet du financement, non son sujet.

Le basculement conceptuel opéré par la **contribution d'assistance** de l'assurance-invalidité (AI), introduite en 2012 dans la LAI (art. 42quater), renverse cette logique. La personne handicapée reçoit une allocation et devient l'**employeuse** de ses propres assistant·e·s. Elle recrute, forme, dirige et, le cas échéant, congédie. Elle est au cœur du dispositif, pas à sa périphérie.

! Contribution d'assistance AI – Points clés (art. 42quater LAI)

- Introduite au 1er janvier 2012 dans la LAI
- Réservée aux bénéficiaires de l'AI vivant à domicile (exclut les personnes en institution)
- Condition : bénéficier d'une **allocation pour impotent** grave ou moyen ET avoir besoin d'une aide humaine régulière ET être domicilié-e en Suisse
- Taux horaire : **32.50 à 49.50 CHF/h** selon la qualification requise pour l'assistance
- La personne est l'**employeuse** de ses assistant·e·s – elle porte les obligations de droit du travail
- Le nombre d'heures est fixé par l'AI sur la base d'une évaluation fonctionnelle standardisée
- Après 65 ans : la contribution d'assistance est réduite – rupture de droits à l'âge légal de la retraite (voir séance 11)

9.4 Diagramme : flux du financement orienté personne



9.5 Les effets pratiques : émancipation et charge de gestion

La contribution d'assistance a permis à un nombre significatif de personnes de quitter une institution ou d'éviter d'y entrer. Elle a rendu possible des projets de vie — logement autonome, vie de couple, participation au marché du travail — qui n'auraient pas été imaginables autrement. En ce sens, elle est une **conquête du mouvement pour la vie autonome** (*Independent Living*).

Mais elle génère aussi une **charge de gestion** considérable. La personne doit : rédiger les contrats de travail, gérer les plannings, faire face aux absences et aux remplacements, déclarer les salaires, gérer les litiges, connaître les droits des employé·e·s. Ces tâches administratives ne demandent pas seulement du temps — elles demandent des compétences (droit du travail, comptabilité, ressources humaines) que beaucoup de personnes ne possèdent pas spontanément,

et pour lesquelles il n'existe pas toujours d'appui institutionnel.

Quand l'assistant·e abandonne son poste sans préavis — ce qui arrive fréquemment dans un marché du travail où ces postes sont peu valorisés — la personne doit recruter en urgence, souvent dans une situation de santé déjà sollicitée. La contribution d'assistance transfère l'autonomie et la responsabilité de gestion simultanément, sans garantir les ressources pour exercer les deux.

Cette tension est directement liée à la tension 1 du module (autonomie vs protection) et au risque de la « discipline de l'autonomie » évoqué par Astier (séance 7) : la liberté accordée peut, sans soutien adapté, devenir une forme de charge supplémentaire pour les personnes les plus vulnérables.

9.6 L'ambivalence des paiements directs : Pearson

Christopher Pearson (Pearson, 2000) a analysé l'introduction des paiements directs au Royaume-Uni. Il en décrit l'**ambivalence fondamentale** : les paiements directs sont à la fois une conquête politique du mouvement des droits (l'autonomie, le contrôle sur sa propre vie) et un vecteur d'une logique de marché dans le welfare.

Dans le premier registre, le paiement direct reconnaît la personne comme sujet compétent, capable de gérer ses ressources et ses employé·e·s. C'est une transformation radicale du rapport entre l'État et la personne handicapée. Dans le second registre, il transforme la personne en **consommatrice de services** sur un marché — avec tous les risques que cela implique : inégalité d'accès à l'information (tout le monde n'a pas les mêmes ressources pour naviguer dans un marché), vulnérabilité face aux défaillances du marché, risque de réduction du service public.

« *Le paiement direct* », écrit Pearson, « *est à la fois la revendication centrale du mouvement des droits des personnes handicapées et le mécanisme par lequel l'État se décharge de sa responsabilité.* » Cette formulation capture l'essentiel de l'ambivalence.

Cette ambivalence n'est pas une raison de rejeter le modèle — c'est une raison de le penser avec soin, en accompagnant les personnes non seulement dans la gestion administrative, mais dans l'exercice réel de leur autodétermination.

9.7 L'exclusion épistémique dans l'AI suisse : Tabin et al.

Tabin, Piecek, Probst et Perrin (Tabin et al., 2024) ont mené une recherche qualitative sur le vécu des assuré·e·s dans le système de l'AI suisse. Leur concept central est l'**exclusion épistémique** : dans les interactions entre assuré·e·s et administration de l'AI, la parole de la personne concernée n'est pas reconnue comme une source de savoir légitime sur sa propre situation.

Le mécanisme est structurel : les médecins du Service médical régional (SMR) donnent des avis qui priment sur les déclarations des assuré·e·s. Le principe de « *réadaptation prime la rente* » signifie que la personne doit prouver qu'elle est incapable de travailler avant d'obtenir une rente

— c'est une **inversion de la charge de la preuve** qui place la personne dans la position de celui ou celle qui doit démontrer son incapacité, contre un système qui présume la capacité.

Les verbatim recueillis sont éloquentes. S., 20 ans, dont l'AI a défini l'orientation professionnelle contre son projet artistique, dit : « *le choix il est où ? C'est j'accepte d'être pénalisée ou j'accepte de faire leur truc.* » Du côté de l'administration, un document du Conseil fédéral (2010) formule : « *ce n'est pas aux assurés de décider s'ils souhaitent se réinsérer ou non.* »

Cette asymétrie épistémique n'est pas toujours vécue comme une violence — parfois les personnes intériorisent le regard institutionnel sur elles-mêmes. « *Je suis invalide* » devient une identité, non une désignation administrative contestable. C'est l'un des effets les plus profonds et les plus difficiles à nommer de l'exclusion épistémique.

9.8 Le nouveau management public et le temps de la relation

Christopher Hood (Hood, 1991) a théorisé le **nouveau management public** (*New Public Management*, NPM) à partir de trois principes : la mesure des résultats (*outputs*), la gestion par objectifs, et la compétition entre prestataires. Appliqués au travail social, ces principes se traduisent par des plans d'accompagnement individualisés (PAI), des indicateurs de résultats, et la notion de « prestation » qui remplace celle de « relation ».

La rationalisation des services sociaux — indicateurs de performance, financement à la prestation, plans d'accompagnement standardisés — crée une tension avec la temporalité propre à la relation d'accompagnement. Le **temps administratif** (l'heure facturée, le plan trimestriel, l'indicateur de résultat) entre en contradiction avec le **temps de la confiance**, du rythme de la personne, de l'imprévu.

Ce point rejoint directement la **tension 3** du module : le temps comptable versus le temps de la relation (voir séance 4). Pour le travail social, cela signifie naviguer entre deux logiques dont aucune ne peut être simplement rejetée : la rationalisation est nécessaire à la justice (traiter les situations de manière comparable, rendre les ressources traçables) ; la relation est nécessaire à l'efficacité (ce qui change réellement les situations, c'est la qualité de l'accompagnement, pas la conformité aux indicateurs).

À Genève, le financement des institutions socio-éducatives est organisé par le biais de **conventions de prestations** entre les institutions et l'OAIS (Office de l'action, de l'intégration et de la cohésion sociale). Ces conventions définissent des « prestations » quantifiables — nombre d'heures d'accompagnement, nombre de résidents, types d'activités. Le débat sur la « prestation » comme unité de compte est vif : peut-on quantifier la relation sans la dénaturer ?

Vignette — Maria (suite)

Depuis la séance 4, Maria a obtenu sa contribution d'assistance et emploie deux assistant·e·s. Elle a quitté l'EPH depuis six mois, après trois ans dans l'établissement. Ce matin, l'une de ses assistantes l'a informée qu'elle partait dans deux semaines — pour raisons familiales,

sans préavis réel. Maria doit trouver un remplaçant rapidement. Elle a une consultation médicale importante dans trois jours. Elle n'a pas dormi. Elle appelle son travailleur social pour lui demander si l'AI peut financer une aide administrative de transition pour la soutenir dans le recrutement. La réponse est : « *ce n'est pas prévu dans les barèmes* ».

Maria raccroche. Elle dit à son amie : « *J'ai quitté l'institution pour être libre. Maintenant je suis libre d'être seule avec mes problèmes.* »

Question de travail : Que révèle cette situation sur les limites structurelles du modèle de financement orienté personne ? Quelles ressources le travailleur social peut-il mobiliser — formelles et informelles — dans cette situation ?

9.9 Tensions pour la pratique professionnelle

Tension à tenir

Le financement orienté personne transfère une liberté réelle et une responsabilité réelle simultanément. Le·la professionnel·le qui accompagne une personne bénéficiant d'une contribution d'assistance ne doit pas se retirer au motif que la personne « est autonome maintenant ». L'autonomie de gestion ne supprime pas le besoin d'accompagnement — elle en transforme le contenu : d'un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne à un accompagnement dans la gestion de l'emploi, la navigation administrative et le maintien du réseau de soutien.

À retenir

- Le financement du handicap a suivi trois logiques historiques : charité → assurance → marché. Ces logiques coexistent aujourd'hui.
- La contribution d'assistance (art. 42quater LAI, 2012) transforme la personne en employeuse de ses assistant·e·s — conquête réelle, mais aussi charge de gestion considérable.
- L'ambivalence de Pearson : les paiements directs sont simultanément une revendication du mouvement des droits et un vecteur de la logique de marché dans le welfare.
- L'exclusion épistémique (Tabin et al.) : la parole de l'assuré·e n'est pas reconnue comme savoir légitime face au régime de vérité médicale de l'AI.
- Le nouveau management public (Hood) introduit des outils de gestion (PAI, indicateurs) qui peuvent être utiles pour la justice et destructeurs pour la relation.

9.10 Concepts-clés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Financement de l'objet	Subventionnement de l'institution	Système traditionnel	La personne n'est pas actrice des décisions sur ses soins
Financement du sujet	Allocation directe à la personne pour employer ses assistant·e·s	Contribution d'assistance AI, 2012	Exige un accompagnement à la gestion, pas seulement à l'assistance
Contribution d'assistance	Prestation AI (art. 42quater) pour employer ses assistant·e·s à domicile	LAI, 2012	Conditions strictes, charge administrative réelle, rupture à 65 ans
Ambivalence des paiements directs	Entre conquête du mouvement des droits et logique de marché du welfare	Pearson, 2000	Ne pas idéaliser le modèle — identifier ses limites structurelles
Exclusion épistémique	Non-reconnaissance de la parole de l'assuré·e comme savoir légitime	Tabin et al., 2024	Documenter et porter la parole des personnes dans les interactions avec l'AI
Nouveau management public	Gestion par objectifs, mesure des résultats, compétition entre prestataires	Hood, 1991	Utiliser les outils gestionnaires sans se laisser réduire à eux

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Réadaptation prime la rente	Principe AI : l'assuré·e doit prouver l'incapacité avant d'obtenir une rente	Tabin et al., 2024	Inversion de la charge de la preuve — vigilance dans l'accompagnement AI

Questions de réflexion

1. Maria dit : « *J'ai quitté l'institution pour être libre. Maintenant je suis libre d'être seule avec mes problèmes.* » Comment analysez-vous cette phrase à la lumière des concepts de Pearson et d'Astier (séance 7) ?
2. L'exclusion épistémique dans l'AI : avez-vous observé, dans votre stage ou votre expérience, des situations où la parole d'une personne n'était pas reconnue comme légitime face à une expertise institutionnelle ? Quelles étaient les conséquences pour la personne ?
3. Le nouveau management public introduit des « plans d'accompagnement individualisés ». En quoi ces outils peuvent-ils être à la fois utiles (pour la justice, la traçabilité) et problématiques (pour la relation) ? Comment un·e professionnel·le peut-il·elle travailler avec ces outils sans leur déléguer le sens de l'accompagnement ?
4. À Genève, les institutions socio-éducatives sont financées par des conventions de prestations. Qu'est-ce que cela change concrètement dans la relation entre le·la travailleur·se social·e et la personne accompagnée ?

Activité pédagogique

Analyse de discours — Deux logiques dans un règlement · Binômes · 30 min

9.10.1 Consignes

1. Chaque binôme reçoit deux extraits de textes réglementaires sur les prestations d'assistance à Genève. L'un valorise l'autonomie et le libre choix de la personne (logique émancipatrice) ; l'autre encadre et standardise les conditions d'octroi (logique gestionnaire).
2. Pour chaque texte, identifiez : (a) le vocabulaire de l'émancipation, (b) le vocabulaire du contrôle, (c) ce que le texte dit du rôle de la personne (sujet actif ou bénéficiaire passif).
3. Repérez les tensions internes à chacun des textes : y a-t-il des phrases qui relèvent des deux logiques à la fois ?

4. Restitution en plénière : peut-on être dans les deux logiques simultanément ? Que faire de cette tension dans la pratique quotidienne ?

9.10.2 Débriefing

- Dans quelle logique vous situez-vous instinctivement — émancipatrice ou gestionnaire ? D'où vient ce positionnement ?
- Comment un projet d'établissement peut-il afficher les deux logiques sans les articuler — et quels effets cela produit-il sur les équipes et les personnes accompagnées ?
- Quel rôle peut jouer le·la travailleur·se social·e pour défendre l'intérêt de la personne dans les interactions avec l'AI ?

9.10.3 Variante en ligne

Pour adapter cette activité à distance ou en format hybride :

- Remplacer les extraits papier par des documents partagés (Google Docs ou PDF interactif) distribués à chaque binôme via un canal de cours.
- Utiliser **Padlet** (padlet.com) pour la restitution collective : chaque binôme dépose ses observations sur un mur commun, organisé en colonnes « vocabulaire émancipateur » / « vocabulaire de contrôle » / « tensions internes ».
- La plénière peut se tenir en visioconférence en parcourant le Padlet ensemble, ou via **Wooclap** (wooclap.com) pour un vote rapide sur la question « peut-on être dans les deux logiques à la fois ? » avant la discussion.

Pour aller plus loin

9.10.1 Lectures obligatoires

- Tabin, J.-P., Piecek, M., Probst, I. & Perrin, C. (2024). L'exclusion épistémique dans l'assurance-invalidité suisse. *Revue suisse de travail social*, 33, 12-31.
- Office fédéral des assurances sociales (2012). *La contribution d'assistance — Guide pratique*. OFAS, Berne.

9.10.2 Lectures complémentaires

- Pearson, C. (2000). Cash and control : The impact of direct payments on the independence of disabled people. *Disability & Society*, 15(5), 747-764.
- Ville, I. (2015). Les enjeux de la personnalisation des dispositifs de compensation du handicap. *Alter*, 9(3), 153-165.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons ? *Public Administration*, 69(1), 3-19.

9.10.3 Ressources en ligne

- Office fédéral des assurances sociales — Contribution d'assistance (information officielle, fiche synthétique) : ofas.admin.ch
- Inclusion Handicap — Dossier sur l'assurance-invalidité et les droits des personnes : inclusion-handicap.ch
- Pro Infirmis — Portail d'information sur la vie autonome et les prestations en Suisse romande : proinfirmis.ch

Troisième partie

Partie III – Champs de pratique

10 Séance 9 — L'école inclusive

Entre proclamation et réalité

[Diapositives de la séance](#) [Version PDF du cours](#)

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, l'étudiant·e est capable de :

- Restituer le cadre légal suisse et genevois de l'école inclusive
- Distinguer intégration et inclusion — et expliquer pourquoi cette distinction est fondamentale
- Analyser le concept d'inclusion managériale (Ebersold) et ses effets sur les élèves et les familles
- Cartographier les acteurs d'une situation de scolarisation inclusive
- Identifier les enjeux des transitions école-vie adulte et leur dimension intersectionnelle

10.1 Introduction

L'école inclusive est l'un des domaines où l'écart entre le droit proclamé et la réalité vécue est le plus visible. Le principe est fort : chaque enfant, quelles que soient ses caractéristiques, a le droit d'être scolarisé dans une école ordinaire, avec les soutiens nécessaires. La réalité est plus nuancée : des ressources insuffisantes, des professionnel·le·s peu formé·e·s, des familles qui portent une charge considérable, et des enfants qui vivent une inclusion de façade.

Cette séance examine le cadre légal, les tensions de mise en œuvre, la dimension intersectionnelle de l'orientation scolaire, et les transitions — moment particulièrement vulnérable — entre l'école et la vie adulte.

10.2 La distinction fondamentale : intégration vs inclusion

Avant d'entrer dans le cadre légal, il faut clarifier une distinction conceptuelle que l'usage courant tend à effacer.

L'intégration signifie : *l'élève s'adapte au système*. On place un enfant en situation de handicap dans une classe ordinaire et on lui fournit des soutiens pour qu'il-elle puisse suivre le programme tel qu'il est conçu. L'enfant est intégré parce qu'il-elle fait un effort d'adaptation. Le système reste fondamentalement inchangé.

L'inclusion signifie : *le système s'adapte à l'élève*. L'école est pensée d'emblée pour accueillir la diversité — dans son architecture, ses méthodes pédagogiques, ses ressources humaines, sa culture. L'enfant n'a pas à s'adapter à une norme qui l'exclut : le système reconnaît sa différence comme une donnée normale.

Ce n'est pas la même chose. Un enfant peut être « intégré » dans une classe ordinaire sans y être réellement inclus — présent physiquement, mais sans les conditions pour y apprendre et y participer. Cette confusion entre présence physique et inclusion réelle est l'une des limites majeures des politiques actuelles.

La CDPH, dans son article 24, exige l'inclusion — pas l'intégration. Mais dans les faits, les systèmes scolaires continuent souvent de pratiquer l'intégration en la nommant inclusion. Le Comité de l'ONU a d'ailleurs précisé, dans son *Observation générale n° 4* (2016), que l'intégration n'est pas une étape vers l'inclusion : ce sont deux logiques différentes.

10.3 Le cadre légal suisse : de l'accord intercantonal à la LIP genevoise

La Suisse a connu une transformation juridique majeure avec l'**accord intercantonal sur la pédagogie spécialisée**, adopté par la Conférence des directeurs de l'instruction publique (CDIP) en 2007 et entré en vigueur progressivement depuis 2011. Cet accord pose deux principes fondamentaux :

1. La **priorité aux solutions intégratives** : avant d'envisager un placement en structure spécialisée, on doit examiner si une scolarisation dans l'école ordinaire avec soutien est possible.
2. La **détermination du besoin individuel** : chaque enfant fait l'objet d'une évaluation spécialisée qui identifie ses besoins et les mesures appropriées.

Mais l'accord introduit également une **clause de subsidiarité** importante : si l'intégration n'est pas réalisable — si elle ne correspond pas au bien-être et aux besoins de développement de l'enfant — un placement dans une structure spécialisée reste possible. Cette clause est interprétée de manière très variable selon les cantons : certains l'utilisent comme une vraie condition restrictive ; d'autres comme une porte de sortie rapide.

À Genève, ces principes ont été traduits dans la **Loi sur l'instruction publique (LIP)** et dans la

politique d'« École inclusive ». Le canton a développé des dispositifs spécialisés (OASIS, ECPS), un réseau d'assistant·e·s pédagogiques (APE), et des dispositifs de co-enseignement. En chiffres : environ **12 % des élèves** bénéficient d'un soutien spécialisé. Les structures sont variées : classes intégrées (COES), écoles spécialisées (SGIPA, CEAD), enseignement spécialisé itinérant.

! Article 24 CDPH — Droit à l'éducation inclusive

Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, ils font en sorte que le **système éducatif soit inclusif à tous les niveaux** et que les personnes handicapées reçoivent tout au long de leur vie **l'éducation générale, le soutien nécessaire, les aménagements raisonnables et les mesures de soutien individualisé** appropriés.

Le Comité de l'ONU, dans ses observations finales de 2022, a épinglé la Suisse sur le maintien de **structures d'enseignement séparatives** (écoles spéciales) qui ne correspondent pas à l'exigence de l'art. 24 CDPH. La Suisse a été invitée à définir un plan de transformation vers un système pleinement inclusif. La réponse suisse est prudente : les structures spécialisées ont, selon les autorités, une légitimité propre pour certains profils. Ce débat est loin d'être clos.

10.4 L'inclusion managériale : quand le système se décharge

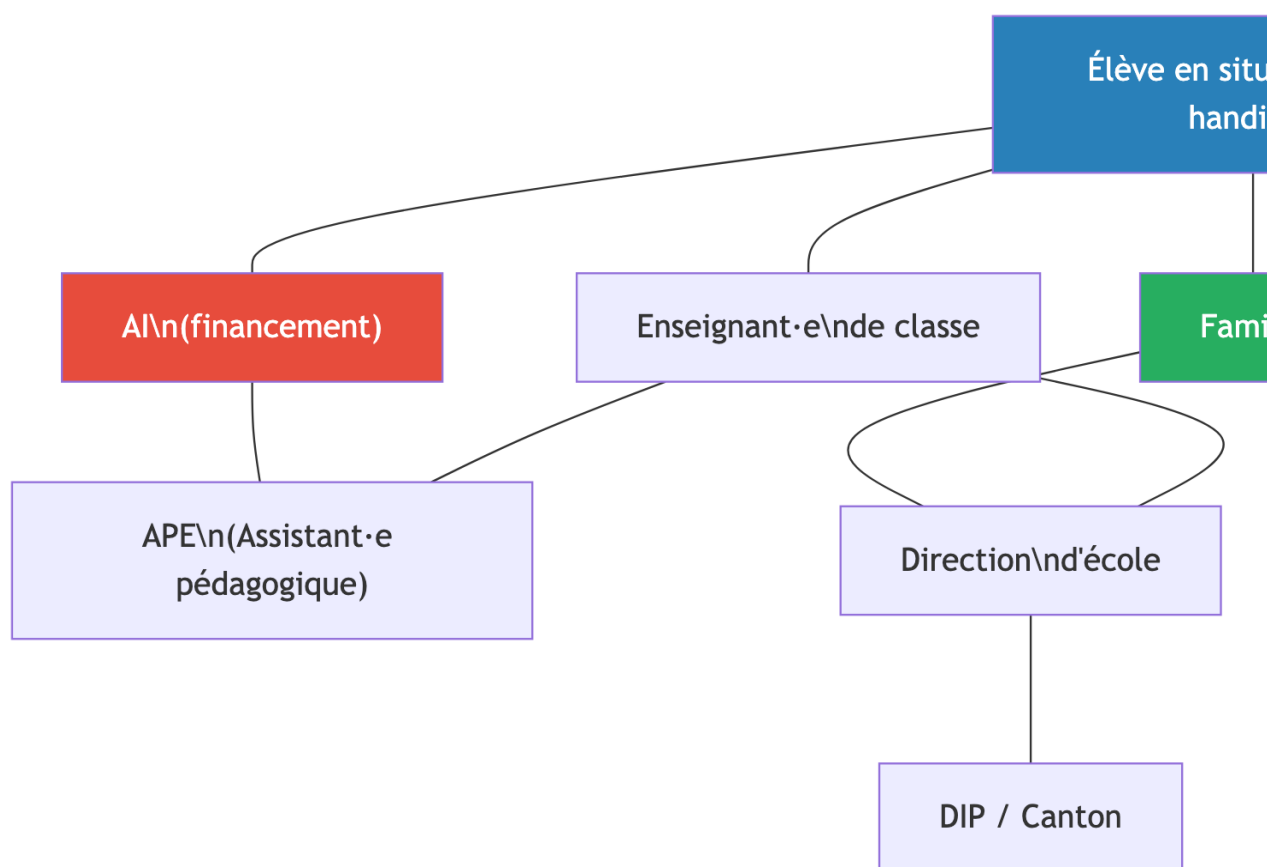
Serge Ebersold (Ebersold, 2005) introduit le concept d'**inclusion managériale** pour désigner un processus paradoxal : l'inclusion est proclamée comme valeur, mais les conditions de sa réalisation sont transférées à l'individu (l'élève, la famille) plutôt que prises en charge par le système.

« *L'inclusion managériale* », écrit Ebersold, « *consiste à désigner l'élève comme un individu à normaliser, dont les difficultés sont le produit d'une inadaptation personnelle au système scolaire, et dont l'intégration dépend de sa capacité à se conformer aux attentes productives de l'école.* » L'élève est invité à « s'adapter » à l'école ordinaire — non l'inverse. La famille doit se battre pour obtenir les ressources. L'enseignant·e est censé·e s'adapter sans formation ni soutien.

Ce processus produit une forme paradoxale d'**exclusion par l'inclusion** : l'enfant est physiquement présent dans la classe ordinaire, mais il n'y a pas les conditions pour qu'il·elle y apprenne et s'y développe. L'inclusion de façade peut être plus stigmatisante qu'un placement séparatif bien soutenu, car elle expose l'enfant à l'échec visible devant ses pairs.

Pour Ebersold, l'inclusion réelle exige une transformation du système — pas seulement de l'individu. Cela signifie : formation des enseignant·e·s, ressources en classe, architecture scolaire accessible, et culture institutionnelle qui reconnaît la diversité comme une richesse et non comme une charge.

10.5 Diagramme : cartographie des acteurs de la scolarisation inclusive



10.6 Le décalage droit / moyens à Genève

Genève se distingue par la richesse de ses dispositifs légaux et la clarté de ses principes. Mais sur le terrain, les professionnel·le·s et les familles rapportent des décalages persistants. Le réseau des APE est insuffisant : les dotations en heures sont souvent inférieures aux besoins réels. La formation des enseignant·e·s à la pédagogie inclusive reste lacunaire. Les délais pour obtenir une évaluation spécialisée (OASIS) peuvent atteindre plusieurs mois pendant lesquels l'enfant est sans soutien adapté.

Le résultat est une **tension structurelle entre la proclamation du droit et les ressources nécessaires à son effectivité**. Cette tension retombe sur les familles — qui doivent plaider, insister, négocier — et sur les enseignant·e·s — qui doivent adapter leur enseignement sans moyens supplémentaires. Elle risque de creuser les inégalités : les familles dotées de ressources

culturelles et sociales savent naviguer dans le système ; les autres non.

10.7 La dimension intersectionnelle : qui est orienté où ?

Ce point est souvent absent des discussions sur l'école inclusive, mais il est politiquement décisif. Les recherches menées en France et en Suisse alémanique documentent une **surreprésentation des enfants issus de milieux populaires et de familles migrantes dans les structures séparatives** (classes spéciales, écoles spécialisées). Cette surreprésentation n'est pas entièrement expliquée par des différences dans les besoins éducatifs — elle reflète aussi des inégalités dans la capacité à mobiliser les ressources du système.

Les familles qui connaissent leurs droits, qui parlent la langue de l'administration, qui ont du temps et des ressources pour accompagner leur enfant obtiennent davantage — des évaluations plus complètes, des soutiens plus adaptés, des placements moins séparatifs. Les familles qui ne disposent pas de ces ressources subissent davantage les décisions du système.

Ce constat est inconfortable pour les professionnel·le·s de l'inclusion : il signifie que les valeurs inclusives peuvent coexister avec des pratiques qui reproduisent les inégalités sociales. La vigilance intersectionnelle — attentive au croisement du handicap avec la classe sociale, l'origine nationale, le genre — est une compétence professionnelle, pas seulement un principe politique.

10.8 Les transitions : moments de vulnérabilité

L'inclusion scolaire ne s'arrête pas à la sortie de l'école. La **transition** entre la scolarité et la vie adulte — emploi, formation professionnelle, logement, vie sociale — est un moment de vulnérabilité particulière. Les dispositifs scolaires, si perfectibles qu'ils soient, ont des structures et des acteurs identifiés. La sortie de l'école confronte la personne à un paysage institutionnel fragmenté, moins coordonné.

Cette discontinuité entre les systèmes (école → AI → marché du travail) produit des **trous** dans l'accompagnement. Les informations sur les besoins de l'élève ne se transmettent pas automatiquement d'une institution à l'autre. Les référents changent. Les critères d'éligibilité aux prestations changent. La personne peut se retrouver sans filet pendant des mois.

Le rôle du·de la travailleur·se social·e scolaire — médiation entre famille, école, AI, et structures spécialisées — est central dans cette transition, mais aussi source de tensions. Les enseignant·e·s peuvent vivre le·la TS scolaire comme un acteur extérieur qui impose des contraintes ; les familles peuvent le·la percevoir comme un représentant du système. Trouver une position tierce, entre l'élève, l'institution et l'administration, est le défi quotidien de ce rôle.

 Vignette – Amira, 12 ans, TSA

Amira a 12 ans. Elle est scolarisée en classe ordinaire depuis trois ans. Son diagnostic de trouble du spectre autistique (TSA) a été posé il y a deux ans, à la suite de plusieurs années de difficultés non expliquées. Elle bénéficie d'un APE pour 6 heures par semaine – l'évaluation OASIS avait recommandé 12 heures.

Son enseignante est dépassée : elle ne sait pas comment adapter les consignes, gérer les moments de surcharge sensorielle, ni expliquer à la classe ce qui se passe sans stigmatiser Amira. Elle n'a reçu aucune formation spécifique. Les parents demandent une augmentation du temps d'APE et une supervision pédagogique pour l'enseignante. L'administration répond que les ressources sont épuisées et que le prochain point de situation aura lieu dans six mois.

Amira refuse d'aller à l'école depuis deux semaines. Elle dit : « *Je ne comprends rien et tout le monde le voit.* »

La famille d'Amira est migrante, non francophone. La mère a pris plusieurs jours de congé non payé pour accompagner les démarches. La réponse de l'administration lui a été communiquée dans un courrier administratif dense qu'elle n'a pas entièrement compris.

Question de travail : Qui porte la charge de la situation d'Amira ? Quels acteurs ont des responsabilités qui ne sont pas exercées ? Que peut faire le-la travailleur·se social·e scolaire – et quelles sont ses limites réelles ?

10.9 Tensions pour la pratique professionnelle

 Tension à tenir

Le travailleur ou la travailleuse sociale intervenant dans le champ scolaire est souvent pris·e entre l'élève, la famille, l'école et l'administration. Son rôle n'est pas de résoudre le manque de ressources – ce n'est pas en son pouvoir. Son rôle est d'accompagner les acteurs dans la compréhension de la situation, de porter la voix de l'enfant dans les espaces de décision, et d'identifier les marges de manœuvre réelles dans un système contraint.

Mais ce rôle lui-même est soumis à tension : défendre l'intérêt de l'enfant peut mettre le-la TS en porte-à-faux avec l'institution qui l'emploie. La loyauté institutionnelle ne peut pas primer sur l'intérêt de l'enfant – mais la rupture avec l'institution prive le-la TS de sa position d'acteur dans le système.

 À retenir

- Intégration ≠ inclusion : l'une adapte la personne au système, l'autre adapte le système à la personne. La CDPH exige la seconde.
- L'accord intercantonal (CDIP, 2007/2011) pose la priorité intégrative avec une clause de subsidiarité variable selon les cantons.

- L'inclusion managériale (Ebersold) transfère la charge de l'inclusion sur l'individu et la famille plutôt que sur le système.
- À Genève, environ 12 % des élèves ont un soutien spécialisé — mais les ressources disponibles sont systématiquement insuffisantes par rapport aux évaluations.
- La dimension intersectionnelle : les enfants des familles migrantes et populaires sont davantage orientés vers des structures séparatives.
- Les transitions école → vie adulte produisent des discontinuités institutionnelles que le TS doit anticiper et accompagner.

10.10 Concepts-clés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Intégration	L'élève s'adapte au système existant	Politique pré-CDPH	Risque d'exclusion de façade — présence sans conditions d'apprentissage
Inclusion	Le système s'adapte à la diversité des élèves	CDPH art. 24; CDIP 2007	Transformation structurelle — formation, ressources, culture institutionnelle
Accord intercantonal (2007/2011)	Priorité aux solutions intégratives en pédagogie spécialisée	CDIP, 2007	Clause de subsidiarité interprétée variablement selon les cantons
École inclusive	Scolarisation de tous les élèves dans l'école ordinaire avec soutiens	LIP Genève; art. 24 CDPH	Objectif légal, réalité partiellement atteinte
Inclusion managériale	Inclusion proclamée qui transfère la charge à l'individu et à la famille	Ebersold, 2005	Identifier qui porte réellement la charge dans chaque situation

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
APE	Assistant·e pédagogique en emploi – soutien en classe	Système genevois	Ressource essentielle, souvent sous-dotée par rapport aux besoins
Transition école → vie adulte	Discontinuité institutionnelle à la sortie de la scolarité	Politique des transitions	Anticiper, documenter, accompagner le passage entre systèmes
Intersectionnalité scolaire	Croisement du handicap avec la classe sociale et l'origine dans les orientations	Recherches Fr./CH-D	Vigilance sur les biais dans les décisions d'orientation

Questions de réflexion

1. Amira est physiquement présente dans la classe ordinaire mais refuse d'y aller. Est-ce de l'inclusion ou de l'intégration ? Qu'aurait-il fallu changer – et à quel niveau du système – pour que l'inclusion soit réelle ?
2. La famille d'Amira est migrante et non francophone. Comment l'inégalité d'accès à l'information joue-t-elle dans les processus d'orientation scolaire ? Que peut faire le·la TS pour rééquilibrer cette asymétrie ?
3. Ebersold décrit le risque que l'inclusion devienne une injonction à se conformer à la norme scolaire productive. Avez-vous observé, dans votre stage ou votre expérience, des situations où cette « inclusion normalisatrice » opérait ? Comment la distinguer d'une inclusion réellement émancipatrice ?
4. Les transitions école → vie adulte produisent des discontinuités institutionnelles. Si vous étiez le·la travailleur·se social·e référent·e d'Amira à l'approche de ses 16 ans, quelles étapes de préparation planifieriez-vous – et avec quels acteurs ?

Activité pédagogique

Cartographie des acteurs – La situation d'Amira · Groupes de 3 · 35 min (20 min travail en groupe, 15 min restitution)

10.10.1 Consignes

1. À partir de la vignette d'Amira, chaque groupe cartographie l'ensemble des acteurs impliqués dans sa scolarisation (Amira elle-même, famille, enseignante, APE, direction d'école, OASIS, SMP, éducateur·trice spécialisé·e, TS scolaire, DIP, AI).
2. Pour chaque acteur, précisez : (a) quel est son rôle formel ? (b) quelle est sa marge de manœuvre réelle dans la situation actuelle ? (c) qui porte la charge principale ?
3. Identifiez les acteurs **absents** — qui devrait être là mais ne l'est pas ?
4. Représentez graphiquement les relations entre acteurs : qui parle à qui ? Qui a du pouvoir sur qui ?

10.10.2 Débriefing

- Comment réduire l'asymétrie de charge qui pèse sur la famille d'Amira ?
- Quel acteur pourrait jouer le rôle de **pivot** — quelqu'un qui maintient la coordination entre tous les autres ?
- Qu'est-ce que la situation révèle sur les limites structurelles du système genevois d'école inclusive ?

10.10.3 Variante en ligne

Pour adapter cette activité à distance ou en format hybride :

- Utiliser **Miro** (miro.com) ou **Mural** pour la cartographie des acteurs : chaque groupe dispose d'un tableau blanc collaboratif pour placer les acteurs et tracer les relations entre eux.
- La phase de restitution peut s'appuyer sur **Wooclap** (wooclap.com) : un sondage rapide (« Qui porte la charge principale ? ») permet de visualiser les divergences entre groupes avant la discussion plénière.
- Pour le travail de préparation individuelle, **Padlet** (padlet.com) permet à chaque étudiant·e de déposer en amont sa liste d'acteurs, que le groupe consolide ensuite lors de la session synchrone.

Pour aller plus loin

10.10.1 Lectures obligatoires

- Ebersold, S. (2005). *L'invention du handicap. La normalisation de l'infirm(e)* (2e éd.). CTNE-RHI (chap. 7 : « L'inclusion managériale »).
- Conférence des directeurs de l'instruction publique (2007). *Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée*. CDIP, Berne.

10.10.2 Lectures complémentaires

- Comité de l'ONU (2016). *Observation générale n° 4 sur le droit à l'éducation inclusive*, CRPD/C/GC/4.
- Comité de l'ONU (2022). Observations finales – Suisse, CRPD/C/CHE/CO/1 (§§ 42-45 sur l'éducation).
- Plaisance, É. (2009). *Autrement capables. École inclusive et situations de handicap*. Autrement (chap. 3).

10.10.3 Ressources en ligne

- Comité de l'ONU sur les droits des personnes handicapées – Observation générale n° 4 (2016) sur le droit à l'éducation inclusive (texte intégral en français) : ohchr.org
- Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) – page sur la pédagogie spécialisée et l'accord intercantonal : edk.ch
- Département de l'instruction publique de Genève – présentation du dispositif « École inclusive » et des ressources spécialisées (APE, OASIS, COES) : ge.ch

11 Séance 10 — Vie affective, sexuelle et intimité

L'angle mort de la pratique

[Diapositives de la séance](#) [Version PDF du cours](#)

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, l'étudiant-e est capable de :

- Situer la vie affective et sexuelle dans le champ de l'autodétermination et des droits
- Retracer l'histoire de l'asexualisation institutionnelle des personnes handicapées
- Appliquer le schéma en quatre phases du care de Tronto à une situation concrète
- Expliquer le concept de compassionate stigma et ses effets dans la relation d'aide
- Analyser l'assistance sexuelle comme analyseur des tensions du champ

11.1 Introduction

Parmi tous les sujets que le travail social aborde, la vie affective et sexuelle des personnes handicapées reste l'un des plus difficiles à traiter en formation. Ce n'est pas un hasard : ce domaine concentre toutes les tensions du module — autodétermination, dignité, protection, savoir expérientiel, normes professionnelles. Il est aussi le domaine où les bonnes intentions produisent le plus facilement des effets de disqualification.

Cette séance ne vise pas à résoudre ces tensions. Elle vise à les nommer, à les analyser avec rigueur, et à fournir les outils pour les tenir de manière réflexive dans la pratique. Elle part d'un constat historique — les institutions ont activement nié la sexualité des personnes handicapées — pour examiner comment ce passé se prolonge dans des pratiques contemporaines moins visibles.

11.2 L'histoire : asexualisation et contrôle institutionnel

La négation de la vie sexuelle des personnes handicapées n'est pas accidentelle. Elle a été institutionnellement organisée. Dans les grands établissements du XIXe et XXe siècles, la séparation stricte entre hommes et femmes n'était pas qu'une norme morale générale : c'était une politique explicite pour empêcher les relations et, surtout, la reproduction.

Cette politique a eu des formes extrêmes : des **stérilisations forcées** de personnes sous tutelle ont été pratiquées dans plusieurs pays européens, parfois jusqu'à une période récente. En Suisse, la stérilisation sans consentement de personnes sous tutelle était légalement possible jusqu'à la révision du Code civil en **2013** — une date récente qui dit quelque chose de la lenteur du changement.

Le droit à la vie privée et à l'intimité est pourtant garanti par l'article 22 de la CDPH. Mais sa mise en œuvre reste faible dans la plupart des institutions. Les règlements intérieurs sont souvent muets ou restrictifs. Les professionnel-le-s n'ont généralement pas reçu de formation à ce sujet. Les personnes concernées apprennent rapidement que ce n'est pas un sujet dont on parle — et s'auto-censurent.

Cette **invisibilité n'est pas neutre** : elle signifie que la vie affective et sexuelle des personnes handicapées est régie par les normes implicites des institutions et des professionnel-le-s, non par les droits des personnes concernées.

Il faut aussi distinguer deux dimensions souvent confondues :

- **La vie sexuelle** : les désirs, les pratiques, les relations physiques — domaine habituellement tabou en institution.
- **La vie affective** : les relations, l'amitié, l'amour, l'attachement — domaine souvent traité comme un « problème à gérer » lorsqu'il concerne des résident-e-s entre eux-elles, plutôt que comme un droit à soutenir.

Les institutions qui interdisent formellement les relations entre résident-e-s, ou qui les surveillent et les encadrent de manière invasive, violent ce droit — même quand l'intention affichée est la protection.

11.3 L'intimité comme droit : ancrage juridique

Le droit à la vie affective et sexuelle n'est pas explicitement nommé dans la CDPH. Il en est pourtant une dimension constitutive, dérivée de :

- L'**article 19** (droit à la vie dans la société, incluant la vie privée et le choix du lieu de résidence)
- L'**article 22** (respect de la vie privée et familiale — « *les États parties protègent la vie privée des personnes handicapées* »)
- L'**article 23** (respect du domicile et de la famille — droit de se marier et de fonder une famille)

Dans une interprétation extensive de ces articles, la vie affective et sexuelle relève de l'autodétermination — du droit de chacun à conduire sa vie selon ses propres valeurs (voir séance 7). La personne handicapée est sujet de désir, sujet affectif, sujet sexuel — pas seulement corps à soigner.

11.4 L'éthique du care : Tronto et les quatre phases

Joan Tronto (Tronto, 1993) propose un cadre d'analyse du care en quatre phases, auxquelles elle associe quatre valeurs morales :

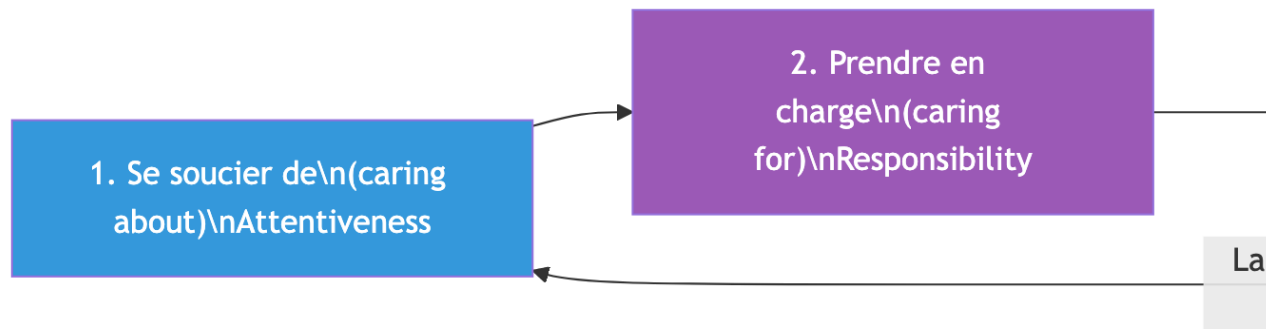
1. **Se soucier de** (*caring about*) : reconnaître qu'il existe un besoin, y prêter attention. Valeur : **attentiveness** — l'attention vigilante, la disponibilité à percevoir le besoin de l'autre.
2. **Prendre en charge** (*caring for*) : assumer la responsabilité de répondre au besoin. Valeur : **responsibility** — la responsabilité active, pas seulement déclarative.
3. **Donner le soin** (*care-giving*) : effectuer le travail concret de soin. Valeur : **competence** — la compétence technique et relationnelle pour répondre effectivement au besoin.
4. **Recevoir le soin** (*care-receiving*) : observer et prendre en compte la réponse de la personne soignée. Valeur : **responsiveness** — la réceptivité à la réponse de l'autre.

La **quatrième phase** est régulièrement négligée dans la pratique. On se soucie, on prend en charge, on agit — mais on n'écoute pas suffisamment ce que la personne dit de ce soin, comment elle le vit, si cela correspond à ce dont elle avait besoin. Cette omission est particulièrement grave dans le domaine de la vie affective : si on ne demande pas à la personne comment elle vit sa situation affective, on ne peut même pas « se soucier de » ce besoin.

Eva Feder Kittay (Kittay, 1999) développe une éthique de la dépendance qui conteste l'illusion libérale de l'individu autonome. Toute personne dépend des autres à certains moments de sa vie — enfance, maladie, vieillesse. La dépendance n'est pas une exception ou une pathologie ; c'est une **condition humaine partagée**. Kittay introduit la figure des « **dérivés** » (*derived persons*) : les aidant·e·s dont la vie est structurée par le besoin d'autrui — souvent des femmes, souvent peu valorisées. Le care est une pratique centrale de la vie sociale — pas une activité marginale.

Appliqué à la vie affective en institution : si on reconnaît la dépendance comme une condition normale, et non comme une exception honteuse, alors le soin de la vie affective — aider quelqu'un à vivre ses relations, à exprimer ses désirs — fait partie du travail de care à part entière.

11.5 Diagramme : le cycle du care de Tronto



11.6 Le compassionate stigma

Pierre Brasseur (Brasseur, 2024) forge le concept de **compassionate stigma** pour désigner un mécanisme spécifique dans la relation d'aide : la bienveillance protectrice peut, à force de sollicitude, maintenir la personne en objet de soin plutôt qu'en sujet désirant. Ce n'est pas le stigmate classique du rejet ou du mépris — c'est un stigmate produit par l'**excès de bienveillance**.

Le mécanisme opère en trois temps :

1. **La bienveillance crée une asymétrie de pouvoir** : celui ou celle qui protège a, par définition, plus de pouvoir que celui ou celle qui est protégé·e. Cette asymétrie est acceptée et même valorisée — « *je veux son bien* ».
2. **La protection justifie la tutelle** : si l'autre est vulnérable et que je veux le protéger, il est normal que je décide pour lui·elle — des soins, du rythme, de l'espace, et progressivement des relations, des désirs.
3. **L'intimité est la dernière sphère à être reconnue comme espace de droits** : on reconnaîtra avant le droit à choisir son atelier (séance 7) ou son lieu de résidence (séance 8) que le droit à une vie sexuelle et affective. L'intimité résiste le plus longtemps à la reconnaissance de la personne comme sujet.

Ce concept renoue avec la critique de Goffman (1963) sur le stigmate — mais il l'applique à la relation d'aide bienveillante, non à la discrimination hostile. La leçon est inconfortable : les pratiques les mieux intentionnées peuvent produire des effets de disqualification. « *C'est au nom de son bien que je ne lui reconnais pas de vie intérieure* » est la formulation la plus précise du mécanisme.

11.7 L'assistance sexuelle comme analyste

L'assistance sexuelle désigne un accompagnement d'ordre sexuel proposé à des personnes handicapées par des personnes formées à cette pratique. En Suisse, elle est **légale mais non réglementée**. Des organisations existent : Sehsucht (Suisse alémanique), APPA (Suisse romande). En Europe, elle est encadrée aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne ; non reconnue dans d'autres pays.

Ce sujet fonctionne comme un **analyste** du champ — c'est-à-dire qu'il révèle, par sa radicalité, des dynamiques que les situations ordinaires laissent dans l'ombre. L'assistance sexuelle pousse à l'extrême les trois tensions du module :

- **Autonomie vs protection** : reconnaître le besoin d'assistance sexuelle, c'est reconnaître à la personne le droit à une vie sexuelle — et donc le droit à ce risque. Refuser, c'est protéger en niant.
- **Expertise vs savoir expérientiel** : la personne concernée est la seule à savoir si ce besoin existe et comment il s'exprime. L'expertise professionnelle ne peut pas se substituer à ce savoir.
- **Gestion vs accompagnement** : comment une institution « gère » ce sujet dit quelque chose de sa conception de la personne handicapée — sujet ou objet de soin.

Des débats restent ouverts dans le champ : faut-il une loi encadrant l'assistance sexuelle ? Quels critères de qualité pour les accompagnant-e-s ? Quel rôle pour le-la TS — facilitateur, orienteur, ou neutre ? Brasseur (Brasseur, 2024) montre que la façon dont une institution traite (ou évite) le sujet de la vie sexuelle de ses résident-e-s est un **indicateur direct de la place qu'elle accorde à leur humanité complète**.

i Vignette — Jean-Luc, 52 ans

Jean-Luc a 52 ans. Il est tétraplégique depuis un accident de moto il y a cinq ans. Avant l'accident, il avait une vie sexuelle active et une relation de longue date. Depuis l'accident, sa partenaire est partie. Il vit en appartement accompagné avec une contribution d'assistance depuis deux ans (voir séance 8).

Lors d'un entretien de suivi avec son travailleur social, il confie : *« Je n'ai pas eu de vie sexuelle depuis l'accident. J'aimerais recourir à l'assistance sexuelle. Mais je ne sais pas comment en parler à l'institution. Je ne sais même pas si c'est légal. »*

Le TS est mal à l'aise. Il dit qu'il va « voir ce qu'il peut faire ». Il n'en parle pas en supervision. Il évite le sujet à l'entretien suivant. Jean-Luc ne l'aborde plus — il a compris le signal.

Trois mois plus tard, lors d'une réunion d'équipe, un-e collègue évoque « l'agitation » de Jean-Luc ces dernières semaines et propose d'augmenter ses sorties pour « canaliser l'énergie ».

Question de travail : Quelle(s) phase(s) du care de Tronto sont absentes dans cette situation ? Qu'est-ce que le compassionate stigma peut expliquer dans le comportement

du TS ? Que révèle la réunion d'équipe sur la manière dont l'institution traite le besoin de Jean-Luc ?

11.8 Tensions pour la pratique professionnelle

Tension à tenir

L'inconfort du·de la professionnel·le face à la sexualité de la personne accompagnée est compréhensible. Il ne justifie pas l'évitement. Ne pas aborder un sujet parce qu'il met le·la professionnel·le mal à l'aise, c'est laisser la personne seule avec un besoin qu'elle a osé formuler.

La réflexivité ici consiste à distinguer trois niveaux :

1. **Mon inconfort personnel** — ce que ce sujet active en moi, ma propre histoire, mes représentations.
2. **Le besoin de la personne** — ce qu'elle a formulé, ce qu'elle n'a pas osé dire.
3. **Ce que mon rôle exige** — pas de résoudre le problème à sa place, mais de ne pas le faire disparaître par mon silence.

À retenir

- L'asexualisation des personnes handicapées a été institutionnellement organisée — stérilisations forcées, ségrégation, surveillance des relations. Ce passé n'est pas loin.
- La CDPH (art. 22, 23) garantit le droit à la vie privée et familiale — peu mis en œuvre dans les institutions.
- Le cycle du care de Tronto (4 phases) : la 4ème — recevoir le soin — est la plus négligée, notamment dans le domaine affectif.
- Kittay : la dépendance est une condition humaine normale. Le soin de la vie affective fait partie du travail de care.
- Le compassionate stigma (Brasseur) : la bienveillance protectrice peut nier la subjectivité de la personne — c'est le stigmat le plus difficile à identifier car sincère.
- L'assistance sexuelle en Suisse : légale, non réglementée. Elle fonctionne comme analyseur des tensions du champ.

11.9 Concepts-clés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Éthique du care	Cadre moral centré sur les relations de soin et de dépendance	Tronto, 1993 ; Kittay, 1999	Penser le soin comme relation bilatérale, pas comme service unilatéral
4 phases du care	Se soucier de / prendre en charge / donner le soin / recevoir le soin	Tronto, 1993	La 4ème phase — écouter la réponse de la personne — est souvent omise
Attentive-ness	Attention vigilante — percevoir un besoin même non formulé	Tronto, 1993	Créer des conditions où la personne peut formuler ses besoins affectifs
Dépendance / interdépendance	La dépendance comme condition humaine partagée, non comme exception	Kittay, 1999	Ne pas traiter la dépendance affective comme une régression
Compassionate stigma	Disqualification de la subjectivité produite par excès de bienveillance	Brasseur, 2024	Test : est-ce que j'agis parce que la personne me l'a demandé, ou pour son bien ?
Asexualisation	Négation historique et institutionnelle de la sexualité des personnes handicapées	Histoire des institutions	Les pratiques actuelles s'inscrivent dans ce continuum — même involontairement

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Assistance sexuelle	Accompagne- ment sexuel professionnel — analyseur des tensions du champ	Brasseur, 2024	Légale en Suisse, non réglementée — le TS doit pouvoir informer

Questions de réflexion

1. Jean-Luc n’aborde plus le sujet après avoir compris le signal du TS. Comment analysez-vous ce silence — du point de vue du compassionate stigma et de la tension autonomie/protection ?
2. La réunion d’équipe propose d’augmenter les sorties de Jean-Luc pour « canaliser l’énergie ». Comment cela illustre-t-il la phase 1 du care (se soucier de) sans phase 4 (recevoir le soin) ?
3. L’assistance sexuelle est légale en Suisse mais non réglementée. Si Jean-Luc vous demandait de l’informer sur ce sujet, que feriez-vous ? Quelles ressources mobiliseriez-vous ? Où seriez-vous au cœur de votre rôle, et où seriez-vous en dehors ?
4. Kittay dit que la dépendance est une condition humaine normale. Comment cette affirmation change-t-elle la manière dont vous percevez Jean-Luc — et plus généralement les personnes que vous accompagnez ?

Activité pédagogique

Analyse en 4 phases du care — La situation de Jean-Luc · Groupes de 3 · 30 min (20 min analyse, 10 min restitution)

11.9.1 Consignes

1. **Phase 1 — Se soucier de** : qui, dans la situation, se soucie du besoin de Jean-Luc ? Que signifie « se soucier » de la vie sexuelle de quelqu’un — qu’est-ce que cela demande comme disponibilité et comme courage ?
2. **Phase 2 — Prendre en charge** : qui prend la responsabilité de répondre ? Le TS ? L’institution ? Quels obstacles s’y opposent ?
3. **Phase 3 — Donner le soin** : quelle réponse concrète est apportée dans la situation ? Y en a-t-il une — et est-elle adéquate ?
4. **Phase 4 — Recevoir le soin** : qu’est-ce que Jean-Luc dit, exprime, ressent face à la réponse reçue ? Comment lit-on son silence ? Que rate-t-on si on s’arrête à la phase 3 ?

11.9.2 Débriefing

- Le terme « se soucier de la vie affective » vous paraît-il naturel dans la pratique du TS ? Pourquoi — ou pourquoi pas ?
- Comment l'inconfort du professionnel devient-il une forme d'invisibilisation du besoin de la personne ?
- Comment une équipe pourrait-elle créer des conditions pour que ce type de besoin soit exprimable — sans rendre la vie privée des résident·e·s publique ?

11.9.3 Variante en ligne

Pour adapter cette activité à distance ou en format hybride :

- Distribuer la vignette de Jean-Luc via le cours en ligne et demander à chaque étudiant·e de noter, avant la session, une réponse à une phase du care (attribution tournante par groupe).
- Utiliser **Mentimeter** (mentimeter.com) en ouverture de session : un nuage de mots sur la question « Quel mot vous vient quand vous entendez “se soucier de la vie sexuelle d'un·e résident·e” ? » permet d'engager la réflexivité avant l'analyse.
- La restitution des groupes peut se faire via **Padlet** (padlet.com) organisé en 4 colonnes (une par phase), avec dépôt anonyme possible pour les observations les plus personnelles.

Pour aller plus loin

11.9.1 Lectures obligatoires

- Brasseur, P. (2024). *L'assistance sexuelle aux personnes handicapées*. Presses Universitaires de France (Introduction et chap. 1).
- Tronto, J. C. (1993). *Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care*. Routledge (chap. 4).

11.9.2 Lectures complémentaires

- Kittay, E. F. (1999). *Love's Labor. Essays on Women, Equality, and Dependency*. Routledge (chap. 1).
- Giami, A. (2015). Entre handicap et sexualité : un espace professionnel à construire. *Alter*, 9(1), 1-15.
- Schaafsma, D., Kok, G., Stoffelen, J. M. T. & Curfs, L. M. G. (2015). Identifying effective methods for teaching sex education to individuals with intellectual disabilities. *Journal of Sex Research*, 52(3), 327-340.

11.9.3 Ressources en ligne

- APPA — Association pour la promotion de l'assistance personnelle et affective (Suisse romande) : présentation de l'assistance sexuelle et contacts : appa-ch.com
- Pro Infirmis — dossier « Vie affective et sexuelle » avec ressources pour les professionnel·le·s et les personnes concernées : proinfirmis.ch
- Comité de l'ONU sur les droits des personnes handicapées — article 22 et 23 CDPH commentés (respect de la vie privée et droit à la famille) : ohchr.org

12 Séance 11 — Vieillissement, perte d'autonomie et intersections

Quand le corps change dans des institutions qui ne changent pas

[Diapositives de la séance](#) [Version PDF du cours](#)

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, l'étudiant-e est capable de :

- Analyser l'intersection entre handicap et vieillissement dans les institutions socio-éducatives
- Mobiliser les concepts de misfit (Garland-Thomson) et d'interdépendance (Kittay) pour analyser une situation
- Identifier les tensions entre les logiques institutionnelles et les besoins liés au vieillissement
- Distinguer le vieillissement en institution et la perte d'autonomie acquise à l'âge adulte avancé
- Comprendre la discontinuité juridique entre le droit du handicap (AI) et le droit de la vieillesse (AVS)

12.1 Introduction

Le vieillissement des personnes handicapées est un phénomène relativement récent, à double titre. D'abord, parce que l'espérance de vie des personnes avec des handicaps sévères a augmenté de manière significative au cours des dernières décennies, grâce aux progrès médicaux. Ensuite, parce que les institutions socio-éducatives — conçues pour des personnes en âge de travailler, orientées vers l'activité et l'intégration — n'ont pas été pensées pour accompagner le vieillissement et la fin de vie.

Cette séance aborde une intersection souvent négligée : les personnes qui vieillissent dans

des dispositifs prévus pour autre chose, avec des besoins qui évoluent dans des structures qui n'évoluent pas au même rythme. Elle examine également une figure différente : les personnes qui acquièrent un handicap tard dans la vie, après une trajectoire biographique construite sans handicap.

12.2 La double peine du vieillissement avec handicap

Avant d'entrer dans les analyses théoriques, il faut nommer une réalité souvent ignorée : les personnes handicapées font face à une **double vulnérabilité** dans le vieillissement.

Première peine : le vieillissement précoce. Certains handicaps entraînent un vieillissement biologique accéléré. C'est particulièrement documenté pour la **trisomie 21** : les personnes atteintes vieillissent précocement, avec un risque de maladie d'Alzheimer significativement plus élevé et plus précoce (parfois dès 40 ans). Leur trajectoire institutionnelle — pensée pour une vie adulte active — devient inadaptée bien avant les autres. Leur double vulnérabilité (handicap + vieillissement précoce) n'est couverte par aucune catégorie institutionnelle prévue à cet effet.

Deuxième peine : vieillir dans des structures inadaptées. Les institutions socio-éducatives n'ont pas les ressources humaines (personnel formé aux soins gériatriques et palliatifs), ni les ressources matérielles (chambres individuelles, équipements médicaux), ni la culture professionnelle (orientation vers le ralentissement et la fin de vie plutôt que vers l'activité et l'intégration) pour accompagner le vieillissement. Pourtant, les résidents vieillissants restent dans ces structures faute d'alternatives adaptées.

12.3 Le misfit : l'inadéquation corps-environnement

Rosemarie Garland-Thomson (Garland-Thomson, 2011) propose le concept de **misfit** pour désigner l'inadéquation entre un corps et l'environnement dans lequel il évolue. « *Un misfit se produit quand les capacités du corps ne correspondent pas aux demandes de l'environnement* », écrit-elle.

Ce concept est plus dynamique que le simple « handicap » : il insiste sur le fait que cette inadéquation n'est pas un état stable. Un corps change avec le temps — il vieillit, se fatigue, développe de nouvelles vulnérabilités. Un environnement peut rester fixe. La même personne peut être en situation de *fit* (adéquation) dans un environnement à 40 ans, et en situation de *misfit* dans le même environnement à 65 ans, sans que ses capacités aient diminué de manière catastrophique — simplement parce que l'environnement exige trop.

Garland-Thomson tire de ce concept une observation politique importante : la vieillesse **universalise l'expérience du handicap**. Avec l'âge, même les corps considérés comme « capables » et normatifs deviennent des *misfits* dans un monde conçu pour la jeunesse et la productivité. Le vieillissement n'est pas une exception à l'ordre normal des choses — c'est le destin universel du corps humain. La prétendue normalité des corps valides n'est que temporaire.

Appliqué au vieillissement en institution socio-éducative : une personne qui vivait en EPH depuis des années dans un relatif équilibre entre ses capacités et l'environnement institutionnel peut, avec le vieillissement, entrer progressivement en inadéquation avec cet environnement. L'atelier protégé, la vie en groupe, le rythme institutionnel — qui lui convenaient à 40 ans — peuvent ne plus lui convenir à 65 ans. La réponse institutionnelle est souvent de « motiver » la personne à s'adapter — c'est-à-dire de pointer vers le corps (le misfit) plutôt que vers l'environnement (la source de l'inadéquation).

12.4 Diagramme : intersection handicap, âge et institution



12.5 Dépendance et interdépendance : Kittay revisitée

Eva Feder Kittay (Kittay, 1999) a construit son éthique de la dépendance autour d'une critique de l'illusion de l'individu autonome. Cette critique prend une résonance particulière dans le contexte du vieillissement.

Dans la séance 10, nous avons rencontré Kittay à propos du care et de l'intimité. Ici, son apport porte sur la **condition humaine de dépendance** : toute société repose sur des pratiques de soin que certains membres prodiguent à d'autres. Le vieillissement rend cette dépendance visible — mais elle existait déjà.

Kittay introduit également la figure des « **dérivés** » (*derived persons*) : les aidant-e-s dont la vie est structurée par le besoin d'autrui. Les professionnel-le-s des institutions socio-éducatives sont, d'une certaine manière, des dérivés institutionnalisés — leur travail, leur temps, leur identité professionnelle sont organisés autour du besoin des personnes qu'ils-elles accompagnent. Reconnaître cette réalité, c'est reconnaître que les aidant-e-s ont eux-mêmes des besoins, des vulnérabilités, des limites — et que leur épuisement est un problème systémique, pas un défaut individuel.

La valorisation de l'**indépendance** comme idéal social tend à rendre la dépendance honteuse, à la cacher, à la minorer. Kittay propose de la reconnaître comme une **dimension centrale de l'existence humaine**, et d'organiser la société en conséquence — avec des ressources, du temps, de la reconnaissance pour les pratiques de soin.

Pour le travail social avec des personnes vieillissantes en situation de handicap, cela signifie : ne pas traiter le besoin croissant de soin comme un échec ou une régression, mais comme une phase normale de l'existence qui mérite des réponses adaptées — en termes de soins, d'accompagnement, et de **reconnaissance de la personne dans sa globalité**.

12.6 Le vieillissement en institution socio-éducative : Ischer et al.

Ischer, Guerdat, Hugentobler et Veyre (Ischer et al., 2024) ont mené une recherche qualitative sur le vieillissement des personnes avec handicap dans les institutions socio-éducatives suisses. Leurs résultats révèlent des **tensions structurelles** entre les missions des établissements et les besoins des résident-e-s vieillissant-e-s.

La mission traditionnelle des EPH est orientée vers l'**intégration**, la **participation** et le **travail protégé** : il s'agit de permettre aux personnes d'avoir une vie active et de participer à la vie sociale. Ces valeurs sont constitutives de l'identité institutionnelle. Mais quand les résident-e-s vieillissent, leurs besoins évoluent vers davantage de **soins**, de **ralentissement**, d'**accompagnement en fin de vie**. Ces besoins sont mal couverts par des institutions dont le personnel est formé au socio-éducatif, pas aux soins gériatriques ou palliatifs.

Ischer et al. identifient plusieurs tensions concrètes :

- **Tension de formation** : les éducateur-trice-s ne sont pas formé-e-s pour les soins

palliatifs, la gestion de la douleur ou l'accompagnement en fin de vie. Face à un·e résident·e mourant·e, les équipes sont souvent désemparées.

- **Tension de sens** : dans la culture institutionnelle orientée vers l'intégration et le progrès, accompagner un·e résident·e qui ralentit et se retire est moins « valorisant » qu'accompagner quelqu'un qui progresse. Les équipes peuvent vivre cette étape comme un échec professionnel.
- **Tension de mission** : l'institution peut-elle être à la fois un lieu d'intégration et de travail, et un lieu de soins et de fin de vie ? Ces deux missions exigent des ressources, des compétences et des cultures différentes.
- **Tension de place** : quand la personne a besoin de soins médicaux intensifs, doit-elle quitter l'EPH pour un EMS (établissement médico-social) ? Ce transfert est souvent vécu comme une **rupture traumatizante** — quitter un lieu de vie connu depuis des décennies, des relations établies, une identité construite dans cet environnement.

Une constatation particulièrement préoccupante de la recherche : les **projets de vie** des résidents vieillissants ne traitent généralement pas les questions du vieillissement et de la fin de vie. Ces sujets restent non dits, même quand la personne approche de la fin de sa vie. La surprotection augmente avec l'âge — retour du modèle médical — sans que la personne soit consultée sur ce qu'elle veut pour ses dernières années.

12.7 La discontinuité juridique : AI → AVS à 65 ans

Une dimension structurelle est souvent ignorée dans les discussions sur le vieillissement et le handicap : la **rupture des droits à 65 ans**. Le passage de l'assurance-invalidité (AI) à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) n'est pas une simple transition administrative — c'est un changement de régime juridique qui peut entraîner une **perte de droits acquis**.

La **contribution d'assistance** (voir séance 8), par exemple, est réduite après 65 ans. Une personne qui bénéficiait d'un certain nombre d'heures d'assistance pour vivre à domicile peut se voir réduire ce soutien au moment précis où ses besoins augmentent du fait du vieillissement. Cette logique — réduire l'aide au moment où elle est le plus nécessaire — est le produit d'une discontinuité entre deux régimes d'assurance qui n'ont pas été pensés ensemble.

Cette discontinuité produit des situations hybrides : des personnes qui ne correspondent pleinement ni au champ du vieillissement (EMS, AVS) ni au champ du handicap (EPH, AI). Les deux systèmes ont tendance à se renvoyer mutuellement ces situations, produisant des zones grises institutionnelles où la personne est mal accompagnée ou ne l'est pas du tout.

12.8 La perte d'autonomie acquise

Le module a principalement traité du handicap dit « congénital » ou survenu tôt dans la vie. Mais le vieillissement ouvre une autre figure : la **perte d'autonomie acquise** à l'âge adulte avancé — une personne de 75 ans qui subit un AVC, une fracture de la hanche, une démence

progressive.

Ces personnes n'ont pas le même rapport au handicap que celles qui ont grandi avec : elles ont une **identité**, une **histoire**, des **habitudes**, une image d'elles-mêmes construites sans handicap. La perte d'autonomie est vécue comme un **deuil** — de l'identité d'avant, des capacités perdues, des relations reconfigurées. Ce deuil a ses propres étapes et ses propres temporalités, qui ne coïncident pas nécessairement avec le temps administratif des dispositifs.

La logique d'autodétermination (séance 7) reste pleinement applicable — mais les modalités de soutien doivent intégrer ce deuil identitaire. Une personne qui vient de perdre sa capacité à marcher n'a pas seulement besoin d'un fauteuil roulant ; elle a besoin d'un espace pour reconstruire une image d'elle-même qui intègre cette perte et continue d'être désirable à ses propres yeux.

i Vignette — Renée, 68 ans

Renée a 68 ans. Elle a une déficience intellectuelle légère et vit en EPH depuis l'âge de 28 ans — quarante ans dans le même établissement. Elle a travaillé pendant trente ans à l'atelier de couture de l'établissement, où elle était respectée pour son habileté.

Depuis quelques mois, elle dort davantage, participe moins aux activités, refuse certains ateliers, passe plus de temps dans sa chambre. L'équipe s'inquiète et tente de la « motiver » : on lui dit que c'est important de garder le rythme, que l'activité est bonne pour elle.

Son médecin dit que c'est « normal pour son âge ». Personne ne lui a demandé ce qu'elle veut pour les prochaines années, ni comment elle vit cette période de sa vie. Elle n'a pas de famille proche. Son référent éducatif a changé trois fois en six ans.

Renée dit, lors d'un entretien informel avec une aide-soignante : *« Je suis fatiguée. Je voudrais qu'on me laisse tranquille. Mais je ne veux pas non plus qu'on m'oublie. »*

Question de travail : Comment le concept de misfit s'applique-t-il à la situation de Renée ? Que révèle la réponse de l'équipe (« motiver ») sur la culture institutionnelle ? Que signifie « *qu'on me laisse tranquille mais qu'on ne m'oublie pas* » — et comment une équipe pourrait-elle répondre à ces deux demandes simultanément ?

12.9 Tensions pour la pratique professionnelle

⚠ Tension à tenir

Vouloir « maintenir l'activité » d'une personne vieillissante peut être une forme de respect (conserver ses habitudes, son rôle social, son sentiment d'utilité) ou une forme de violence (lui imposer un rythme qui n'est plus le sien, nier son droit au ralentissement).

La différence se joue dans **qui décide** : la personne ou l'institution. Renée a-t-elle été consultée sur ce qu'elle veut pour ses prochaines années ? Si non, l'équipe n'accompagne pas — elle gère. Et gérer au nom du bien de la personne sans lui demander ce qu'elle veut,

c'est le compassionate stigma (séance 10) appliqué au vieillissement.

! À retenir

- La double peine du vieillissement avec handicap : vieillissement précoce pour certains + structures inadaptées pour tous.
- Le misfit (Garland-Thomson) : l'inadéquation est entre le corps et l'environnement — pas dans le corps seul. La vieillesse universalise cette expérience.
- Kittay : la dépendance croissante liée au vieillissement n'est pas une régression — c'est une phase normale qui mérite des réponses adaptées.
- Ischer et al. : quatre tensions structurelles dans les EPH — formation, sens, mission, place. Les projets de vie ne traitent pas la fin de vie.
- La discontinuité AI/AVS à 65 ans produit une réduction de droits au moment où les besoins augmentent.
- La perte d'autonomie acquise exige un accompagnement du deuil identitaire, pas seulement de la compensation fonctionnelle.

12.10 Concepts-clés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Misfit	Inadéquation entre un corps qui change et un environnement qui reste fixe	Garland-Thomson, 2011	Modifier l'environnement plutôt que « motiver » la personne à s'adapter
Interdépendance	La dépendance comme condition humaine normale, non comme exception	Kittay, 1999	Reconnaître les besoins des aidant·e·s autant que ceux des aidé·e·s

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Vieillissement précoce	Vieillissement accéléré lié à certains handicaps (ex : trisomie 21)	Recherche biomédicale	Anticiper les besoins bien avant 65 ans — les structures actuelles ne le font pas
Vieillissement en institution	Tension entre missions des EPH et besoins liés au vieillissement	Ischer et al., 2024	Former les équipes, inclure fin de vie dans les projets de vie
Perte d'autonomie acquise	Handicap survenant à l'âge adulte avancé — trajectoire biographique différente	Champ du vieillissement	Accompagner le deuil identitaire, pas seulement la compensation fonctionnelle
Discontinuité AI/AVS	Rupture de droits à 65 ans — réduction possible de la contribution d'assistance	LAI/LAVS	Anticiper avec la personne et l'accompagner dans la transition
Transfert EMS/EPH	Rupture institutionnelle vécue lors du passage d'un établissement à l'autre	Ischer et al., 2024	Préparer et accompagner le transfert — ne pas le laisser se faire par défaut

Questions de réflexion

1. Renée dit : « *Je voudrais qu'on me laisse tranquille. Mais je ne veux pas non plus qu'on m'oublie.* » Comment ces deux demandes peuvent-elles coexister ? Qu'impliquent-elles

pour la posture de l'accompagnant-e ?

2. Garland-Thomson dit que la vieillesse universalise l'expérience du handicap. Que change cette affirmation dans votre façon de percevoir les personnes âgées que vous connaissez — ou que vous accompagnez ? Peut-elle modifier la façon dont la société traite le vieillissement ?
3. À 65 ans, la contribution d'assistance d'une personne est réduite alors que ses besoins augmentent. Quel rôle le-la TS peut-il-elle jouer dans l'anticipation et la gestion de cette transition ? Quelles ressources peut-il-elle mobiliser ?
4. Les projets de vie des résidents vieillissants ne traitent pas la fin de vie (Ischer et al.). Comment aborderiez-vous ce sujet avec Renée — et avec quels outils, quelles ressources, dans quel cadre institutionnel ?

Activité pédagogique

Étude de cas croisée — Renée et René · Groupes de 4 (2 × 2 sous-groupes) · 40 min

12.10.1 Consignes

Sous-groupe A analyse la trajectoire de Renée (68 ans, vieillissement en EPH depuis 40 ans, déficience intellectuelle légère).

Sous-groupe B analyse la trajectoire de René, 80 ans : AVC à 75 ans, hémiplégie gauche, anciennement directeur d'entreprise. Demande une contribution d'assistance pour rester à domicile. Refuse catégoriquement d'aller en EMS : « *Je gérerai mes affaires jusqu'au bout.* »

Pour chacune des deux trajectoires, répondez à ces questions :

1. Quels dispositifs sont mobilisés ou mobilisables (AI, AVS, contribution d'assistance, EMS, EPH, etc.) ?
2. Quels professionnel-le-s interviennent — et lesquels manquent ?
3. Quelles tensions de posture émergent pour le-la TS ?
4. Comment les concepts de misfit et d'interdépendance (Kittay) s'appliquent-ils ?

Mise en commun (20 min) : - Quelles différences structurelles entre les deux trajectoires ? - Qu'est-ce que la trajectoire de l'un-e permet de voir différemment dans la trajectoire de l'autre ?

12.10.2 Débriefing

- Comment votre propre rapport au vieillissement et à la dépendance influence-t-il la façon dont vous analysez ces deux situations ?
- Que dit la divergence des réactions institutionnelles entre Renée et René sur les inégalités dans le vieillissement ?

12.10.3 Variante en ligne

En format distanciel ou hybride, cette activité peut être adaptée comme suit :

- **Nuage de mots** (Mentimeter ou Wooclap) : en ouverture, demander aux étudiant·e·s d'associer un mot à « vieillissement » et un mot à « dépendance » — afficher les résultats collectifs pour amorcer la discussion.
- **Travail en sous-groupes virtuels** : les sous-groupes A et B travaillent en salles de réunion séparées (Zoom, Teams) pendant 20 min, puis se retrouvent en plénière.
- **Padlet collaboratif** : chaque sous-groupe documente son analyse sur une colonne partagée (dispositifs, professionnel·le·s, tensions, concepts) — permet une mise en commun visuelle et une trace écrite de l'activité.

Pour aller plus loin

12.10.1 Lectures obligatoires

- Ischer, P., Guerdat, M., Hugentobler, V. & Veyre, A. (2024). Le vieillissement des personnes avec handicap dans les institutions socio-éducatives. *Revue suisse de travail social*, 34, 45-62.
- Garland-Thomson, R. (2011). Misfits : A feminist materialist disability concept. *Hypatia*, 26(3), 591-609.

12.10.2 Lectures complémentaires

- Kittay, E. F. (1999). *Love's Labor. Essays on Women, Equality, and Dependency*. Routledge (chap. 2 : « Dependency and Equality »).
- Ville, I. & Ravaud, J.-F. (2007). *L'invalidité dans le monde du travail. Une approche sociologique du handicap*. Presses de l'EHESP (chap. 8 : « Vieillir avec un handicap »).
- Office fédéral des assurances sociales (2023). *La transition AI-AVS : droits et dispositifs à 65 ans*. OFAS, Berne.

12.10.3 Ressources en ligne

- Office fédéral des assurances sociales — [Assurance-vieillesse et survivants \(AVS\)](#) : présentation officielle des droits et prestations, y compris la transition AI/AVS à 65 ans.
- INSOS Suisse — [Vieillissement et handicap](#) : brochure de l'association faîtière des institutions sociales sur les enjeux du vieillissement des personnes en situation de handicap.
- Garland-Thomson, R. (2011). « Misfits : A Feminist Materialist Disability Concept » — [accès via JSTOR](#) (accès libre dans de nombreuses institutions).

13 Séance 12 — Synthèse : tenir les tensions, pratiquer la réflexivité

Retour sur le parcours et restitution des dossiers

[Diapositives de la séance](#) [Version PDF du cours](#)

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de cette séance, l'étudiant-e est capable de :

- Restituer les trois tensions de posture et leur articulation aux modèles théoriques du module
- Évaluer l'évolution de sa propre posture depuis la séance 4 (situation de Maria)
- Situer les débats actuels suisses dans les trois échelles d'analyse (international / national / local)
- Articuler réflexivité professionnelle (Schön), éthique du care (Tronto) et posture déontologique
- Présenter oralement son dossier d'analyse de situation et en discuter collectivement

13.1 Introduction

Cette dernière séance a une fonction double. Elle est d'abord un moment de **synthèse** — un retour sur le parcours, une mise en perspective des acquis, une invitation à la réflexivité sur ce que douze séances ont modifié dans la manière de penser et d'agir. Elle est ensuite un moment d'**évaluation** — la restitution orale des dossiers d'analyse de situation, qui donne à voir le travail intellectuel accompli.

Mais cette séance a aussi une fonction symbolique : elle est la conclusion d'un module qui n'a pas eu pour ambition de fournir des recettes, mais de complexifier les questions. La complexité n'est pas un obstacle à l'action — c'est la condition d'une action réflexive. Un-e professionnel-le qui agit sans complexifier est efficace à court terme et dangereux à long terme.

13.2 La réflexivité comme compétence professionnelle

Donald Schön (Schön, 1983) a théorisé la réflexivité comme une compétence centrale du praticien professionnel, à travers sa notion de **praticien réflexif** (*reflective practitioner*). Il distingue deux formes de réflexivité :

1. **La réflexion-en-action** (*reflection-in-action*) : penser en faisant, ajuster sa pratique en temps réel, percevoir les signaux d'une situation qui ne correspond pas au schéma prévu. C'est la compétence du professionnel expérimenté qui sent qu'il faut changer de cap sans nécessairement pouvoir l'expliquer immédiatement.
2. **La réflexion-sur-l'action** (*reflection-on-action*) : revenir après coup sur ce qui s'est passé, l'analyser, identifier ce qui a fonctionné, ce qui a échoué et pourquoi. C'est le travail de la supervision, du journal de pratique, des formations continues.

Ces deux formes de réflexivité sont complémentaires. La réflexion-sur-l'action enrichit la réflexion-en-action : en analysant après coup ce qu'on a fait, on construit des schèmes d'action plus nuancés pour la prochaine fois. Le **journal de pratique** — outil régulièrement proposé dans les formations en travail social — est précisément un dispositif pour formaliser cette réflexion-sur-l'action.

Dans le champ du handicap, la réflexivité est d'autant plus nécessaire que les situations sont complexes et les valeurs en tension. Une équipe qui ne réfléchit pas sur sa pratique risque de reproduire des schèmes de protection paternaliste (compassionate stigma) sans jamais les percevoir comme tels.

13.3 La posture éthique : trois orientations

Les professionnel-le-s du travail social naviguent entre trois orientations éthiques qui ne se réduisent pas l'une à l'autre :

1. **L'éthique déontologique** (Kant et les codes professionnels) : *qu'est-ce qui est juste selon les règles* ? Chaque profession définit des obligations — confidentialité, non-malfaisance, respect de l'autonomie. Ces règles offrent un cadre stable et prévisible. Mais elles peuvent être insuffisantes dans les situations complexes où plusieurs règles entrent en conflit.
2. **L'éthique téléologique** (conséquentialiste) : *quels résultats vise-t-on* ? L'action juste est celle qui produit les meilleurs résultats pour la personne et pour la société. Cette orientation est particulièrement présente dans le nouveau management public — les indicateurs de résultat, les plans d'accompagnement orientés vers des objectifs mesurables. Son limite : elle peut justifier des moyens discutables par des fins présentées comme bonnes.
3. **L'éthique des vertus** (Aristote, MacIntyre, Noddings) : *qui est-ce que je veux être comme professionnel-le* ? Cette orientation met l'accent sur le caractère moral du professionnel — son honnêteté, sa fiabilité, sa sollicitude (*care*). Elle est particulièrement pertinente dans

les situations de soin de longue durée, où c'est la qualité de la relation qui compte, pas seulement la conformité aux règles ou l'atteinte des objectifs.

Le handicap complexifie les trois orientations. Sur le plan déontologique : les codes professionnels ont parfois du mal à traiter les situations où l'autonomie de la personne et sa protection sont en conflit. Sur le plan téléologique : comment mesurer les résultats d'un accompagnement qui respecte l'autodétermination mais ne produit pas les « progrès » attendus ? Sur le plan des vertus : que fait-on quand notre sollicitude sincère produit du compassionate stigma ?

13.4 Retour sur les trois tensions de posture

Trois tensions ont structuré l'ensemble du module. Il est temps de les nommer clairement, de voir comment elles s'articulent aux concepts du module, et de mesurer ce qu'elles impliquent pour la pratique.

13.4.1 Tension 1 : Autonomie vs protection

Cette tension est irréductible. Une société qui ne protège jamais ses membres les plus vulnérables est inhumaine. Une société qui protège au point de nier l'autodétermination est oppressive. Le travail social navigue entre ces deux risques — le laisser-faire et le paternalisme.

La **dignité du risque** (Perske, 1972) n'est pas une invitation à l'imprudence — c'est une exigence éthique qui reconnaît que l'expérience du risque fait partie de l'humanité. Refuser à une personne le droit de prendre un risque, c'est lui refuser une part de son humanité. Le test réflexif : *est-ce que je protège parce que la personne est en danger réel, ou parce que son choix m'inquiète ?*

Cette tension traverse tout le module : l'autodétermination de Lucas (séance 7), la charge de gestion de Maria (séance 8), l'inclusion d'Amira (séance 9), la vie sexuelle de Jean-Luc (séance 10), le ralentissement de Renée (séance 11).

13.4.2 Tension 2 : Expertise professionnelle vs savoir expérientiel

Le-la professionnel-le sait — par sa formation, son expérience, son réseau. La personne concernée sait aussi — par son expérience vécue, son histoire, son corps. Ces deux savoirs ne sont pas du même type, et aucun ne peut se substituer à l'autre.

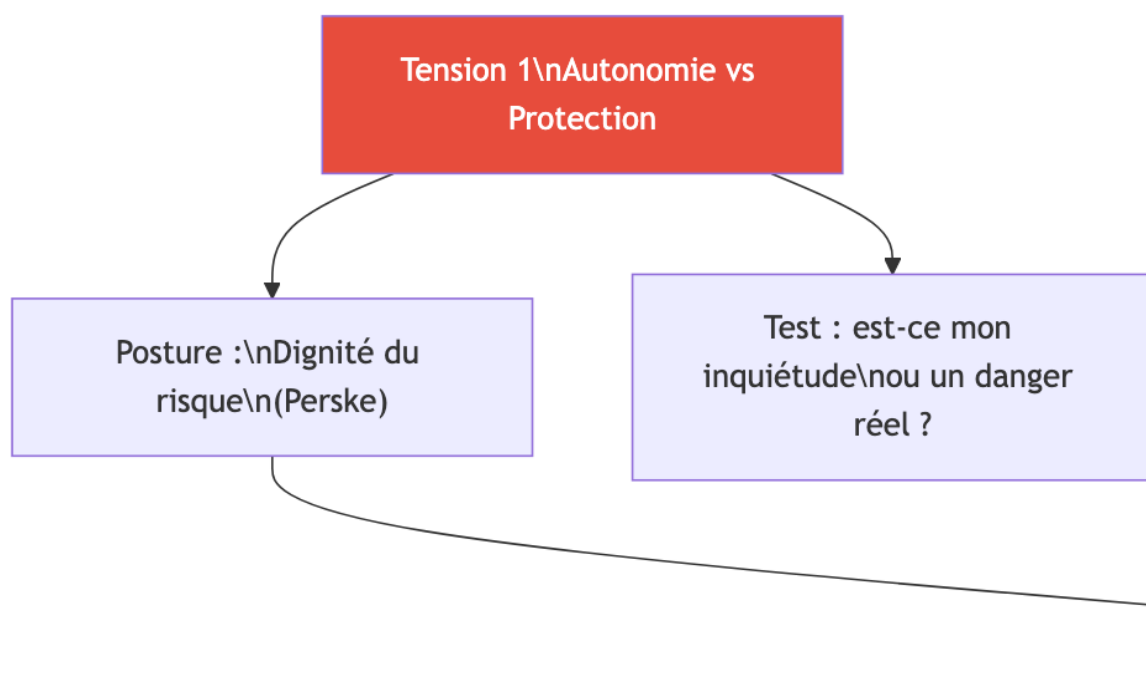
L'exclusion épistémique (Tabin et al., 2024) décrit ce qui se passe quand le savoir professionnel écrase le savoir expérientiel. La pair-aidance (séance 7) reconnaît la légitimité du savoir expérientiel. La posture réflexive consiste à **créer des espaces** où la parole de la personne concernée est réellement entendue comme une source de connaissance légitime — non comme une donnée à intégrer dans le diagnostic du professionnel.

13.4.3 Tension 3 : Logique gestionnaire vs relation d'accompagnement

Les dispositifs gestionnaires — plans standardisés, financement à la prestation, indicateurs de résultat — ne sont pas le problème. Le problème est quand ils deviennent la finalité plutôt que le cadre. La relation d'accompagnement a sa propre temporalité, sa propre logique, ses propres exigences — qui ne coïncident pas toujours avec les tableaux de bord.

La posture réflexive consiste à utiliser les outils gestionnaires sans se laisser réduire à eux — à savoir pourquoi on remplit ce plan et ce que la personne y gagne réellement.

13.5 Diagramme : tensions × postures (matrice synthétique)



13.6 Retour sur Maria : six mois après

i Vignette — Maria, six mois plus tard

Il y a six mois, Maria a quitté l'EPH. Elle emploie désormais deux assistant·e·s via la contribution d'assistance. Il y a trois semaines, une crise de dysrèflexie autonome l'a conduite aux urgences, puis hospitalisée pendant dix jours. À sa sortie, elle a refusé de retourner à l'EPH. Elle a recruté un troisième assistant pour couvrir les nuits.

Son travailleur social l'accompagne par téléphone, à distance, deux fois par semaine. Elle dit : « *C'était dur. Je referais le même choix.* »
L'équipe de l'EPH dit : « *On vous avait dit que c'était risqué.* »
Maria dit : « *Oui. C'était mon risque à prendre.* »

À la séance 4, les étudiant·e·s ont répondu à la question : *quelle posture adopteriez-vous face à Maria ?* Ces réponses ont été conservées. Il est temps de les relire.

Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de penser la situation ? Pas nécessairement votre réponse — peut-être votre justification, peut-être la manière dont vous tenez l'incertitude, peut-être les concepts que vous mobilisez pour analyser la situation.

« *C'était mon risque à prendre* » — cette phrase de Maria illustre la dignité du risque (Perske), l'autodétermination (Wehmeyer), le soutien à la décision (Cudré-Mauroux), et, de façon plus implicite, la critique de la discipline de l'autonomie (Astier) : Maria a pris ce risque en pleine connaissance de cause, pas sous injonction.

C'est ici que se mesure le plus concrètement ce qu'un module peut faire : non pas vous donner les bonnes réponses, mais vous permettre de **tenir les questions difficiles avec plus de rigueur**.

13.7 Les défis à venir pour les travailleur·se·s sociaux·ales

Le travail social avec les personnes handicapées est en pleine reconfiguration. Ce module en a décrit les dynamiques : la désinstitutionnalisation, l'autodétermination, le financement orienté personne, l'école inclusive, le vieillissement. Ces transformations ne suppriment pas le rôle du travailleur social — elles le déplacent.

Trois défis structurels se dégagent pour les professionnel·le·s de demain :

Défi 1 : La désinstitutionnalisation effective — pas seulement proclamée. Sortir des institutions ne suffit pas si les personnes se retrouvent seules à gérer leur vie sans soutien adapté. La désinstitutionnalisation réelle exige des structures de soutien communautaires robustes, du temps pour l'accompagnement, et une culture professionnelle qui reconnaît que l'autonomie n'est pas l'isolement.

Défi 2 : La reconnaissance du savoir expérientiel comme ressource professionnelle à part entière. Cela implique d'intégrer les pair-aidant·e·s dans les équipes avec un statut clair, de créer des espaces où la parole des personnes concernées informe réellement les décisions institutionnelles, et de résister à la tentation de « professionnaliser » le savoir expérientiel au point de l'assimiler au savoir clinique.

Défi 3 : La résistance à la managérialisation sans perdre les ressources institutionnelles. Les outils de gestion (PAI, indicateurs, conventions de prestations) peuvent améliorer la justice et la traçabilité — mais ils ne doivent pas devenir la finalité. Résister à la managérialisation, c'est maintenir le sens de l'accompagnement face à la pression des indicateurs.

13.8 Trois échelles, un même défi

Le champ du handicap se joue simultanément à trois échelles qui s'alimentent mutuellement.

À l'échelle **internationale**, la CDPH reste un horizon normatif que peu d'États atteignent pleinement. La Suisse, épinglée en 2022 par le Comité de l'ONU sur plus de 80 points, est dans une position de pays riche qui proclame les droits sans toujours les mettre en œuvre. L'**initiative « Pour l'inclusion »** et le contre-projet indirect du Conseil fédéral (message du 25 février 2026) sont un moment politique où ce débat devient public et potentiellement constitutionnel. Le contre-projet propose une loi-cadre sur l'inclusion, une révision de la LAI et un élargissement des droits à toutes les personnes handicapées — ce qui représente une transformation significative si le parlement et le peuple le soutiennent.

À l'échelle **nationale**, les tensions entre désinstitutionnalisation et réalisme institutionnel, entre financement orienté personne et charge administrative, entre école inclusive et manque de ressources, sont des débats en cours. Ils ne se résolvent pas en séminaire — mais comprendre leurs enjeux permet d'y prendre position de manière éclairée.

À l'échelle **locale genevoise**, l'évolution du modèle EPI/EPH vers plus d'habitat inclusif est réelle mais lente. Les professionnel·le·s formé·e·s à la HETS sont ceux et celles qui seront dans ces institutions dans cinq ans, dans dix ans. Ce qu'ils-elles y feront dépend en partie de ce qu'ils-elles auront appris ici.

13.9 Le care éthique comme valeur centrale

Joan Tronto (Tronto, 2013), dans ses travaux ultérieurs, propose de faire du care non pas une compétence secondaire (un *soft skill* ajouté à des compétences techniques), mais la **valeur centrale** des professions du social et, plus largement, de la démocratie. « *Une démocratie qui ne se soucie pas du care* », écrit-elle, « *est une démocratie qui abandonne ses membres les plus vulnérables.* »

Dans les professions du travail social, cette idée a des implications concrètes :

- Le care n'est pas l'affaire des femmes ou des « doux » — c'est une compétence professionnelle exigeante, intellectuellement et relationnellement.
- La sollicitude (attentiveness) est une disposition professionnelle à cultiver — pas un sentiment personnel qu'on a ou qu'on n'a pas.
- Résister au compassionate stigma (Brasseur, 2024), c'est une forme de care éthique : se soucier assez de l'autre pour ne pas le réduire à sa vulnérabilité.

Nel Noddings (2003) et **Virginia Held** (2006) prolongent cette réflexion en proposant une **éthique du care** qui reconnaît la particularité de chaque relation de soin — contre l'abstraction des éthiques universalistes. Pour le travail social, cela signifie : traiter chaque situation dans sa singularité, sans se réfugier derrière les règles générales pour éviter la complexité.

13.10 Tensions pour la pratique professionnelle

Tension à tenir

La réflexivité professionnelle n'est pas un état qu'on atteint — c'est une pratique qu'on maintient. Elle peut s'émousser avec l'habitude, l'épuisement, la pression institutionnelle. Les espaces de supervision, de formation continue, de discussion avec les pairs sont des ressources pour maintenir cette pratique vivante.

Les utiliser n'est pas un luxe : c'est une obligation professionnelle et éthique. Un-e professionnel-le qui ne se questionne plus est un-e professionnel-le dont les certitudes font des dommages invisibles.

À retenir

- La réflexivité (Schön) se pratique en action (réflexion-en-action) et après l'action (réflexion-sur-l'action). Le journal de pratique est un outil pour la seconde.
- Trois orientations éthiques : déontologique (règles), téléologique (résultats), vertus (qui je veux être). Les trois sont nécessaires — aucune ne suffit seule.
- Les trois tensions (autonomie/protection ; expertise/savoir expérientiel ; gestion/relation) traversent tout le champ et ne se résolvent pas — elles se tiennent.
- Les trois défis à venir : désinstitutionnalisation effective, reconnaissance du savoir expérientiel, résistance à la managérialisation.
- L'initiative « Pour l'inclusion » (CF, 25.02.2026) : un moment politique qui peut transformer le cadre légal suisse.
- Le care éthique (Tronto, Noddings, Held) : le care comme valeur centrale, pas comme soft skill.

13.11 Concepts-clés

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Posture réflexive	Interroger en permanence les effets de sa propre intervention	Schön, 1983	Journal de pratique, supervision — outils pour maintenir la réflexivité
Réflexion-en-action	Ajuster sa pratique en temps réel, dans l'action	Schön, 1983	Compétence du professionnel expérimenté — se cultive dans la durée

Concept	Définition	Auteur·e·s / source	Implication pour la pratique
Tenir les tensions	Maintenir simultanément des exigences contradictoires sans les effacer	Fil conducteur du module	Résister à la tentation des solutions simples
Compassionate stigma	Disqualification implicite par excès de bienveillance	Brasseur, 2024	Test : est-ce que j'agis parce que la personne me l'a demandé ?
Dignité du risque	Droit à l'expérience et à l'erreur — constitutif de l'humanité	Perske, 1972	Distinguer danger réel / inconfort professionnel
Exclusion épistémique	La parole de la personne non reconnue comme savoir légitime	Tabin et al., 2024	Créer des espaces où la parole de la personne informe réellement
Care éthique	Le care comme valeur centrale, non comme soft skill	Tronto, Noddings, Held	Revendiquer le care comme compétence professionnelle à part entière
Initiative « Pour l'inclusion »	Contre-projet CF (25.02.2026) : loi-cadre, révision LAI, élargissement des droits	CF, 2026	Contexte politique actuel — comprendre les enjeux pour y prendre position

Questions de réflexion

1. Maria dit : « *C'était mon risque à prendre.* » Comparez cette phrase avec la réponse que vous aviez donnée à la séance 4. Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de tenir cette question — non pas la réponse, mais la qualité de l'incertitude que vous tolérez ?
2. Le compassionate stigma est décrit comme la forme de violence institutionnelle la plus difficile à identifier parce qu'elle est sincère. Avez-vous, dans votre stage ou votre expérience, reconnu ce mécanisme à l'œuvre — chez d'autres, ou chez vous-même ? Comment l'avez-vous nommé, à l'époque ou maintenant ?
3. Schön distingue réflexion-en-action et réflexion-sur-l'action. Pensez à une situation professionnelle (stage, bénévolat, expérience personnelle) où ces deux formes de réflexivité ont été en jeu. Qu'avez-vous appris de l'une que l'autre ne vous avait pas donné ?
4. Les trois défis du travail social de demain (désinstitutionnalisation effective, reconnaissance du savoir expérientiel, résistance à la managérialisation) — lequel vous semble le plus urgent dans le contexte genevois actuel ? Pourquoi ?

Activité pédagogique

Restitution orale des dossiers d'analyse de situation · Individuel puis discussion collective
· 12 min présentation + 5 min discussion

13.11.1 Consignes

1. Chaque étudiant·e présente en 10-12 minutes son dossier d'analyse de situation : présentation de la situation (sans identifier les personnes), cadres théoriques mobilisés, tensions identifiées, positionnement réflexif.
2. La discussion collective (5 min) porte sur **un point précis** : un angle non exploré, une tension non nommée, un concept du module qui aurait pu enrichir l'analyse.
3. **En fin de séance** : relecture collective des réponses de la séance 4 (Maria). Chacun·e dit en une phrase ce qui a changé dans sa manière de tenir la question. L'enseignant·e ou facilitateur·trice collecte ces phrases — elles constituent la trace collective de l'apprentissage du module.

13.11.2 Débriefing

- Quel concept du module vous a le plus déstabilisé — et pourquoi est-ce un signe d'apprentissage ?
- Qu'est-ce que vous ferez différemment dans votre pratique future — de manière concrète, pas abstraite ?
- Quelle question reste ouverte pour vous — une question que ce module a soulevée sans la résoudre ?

13.11.3 Variante en ligne

En format distanciel ou hybride, cette activité peut être adaptée comme suit :

- **Nuage de mots** (Mentimeter ou Wooclap) : en ouverture, poser la question « Quel concept du module retenez-vous ? » — le nuage collectif sert de point de départ pour la synthèse.
- **Présentations asynchrones** : les étudiant·e·s déposent une courte vidéo (10-12 min) avant la séance ; la session synchrone est consacrée uniquement aux discussions collectives.
- **Padlet collaboratif** : à la fin de la séance, chacun·e dépose sur un Padlet partagé « une phrase sur ce qui a changé » depuis la séance 4 — constitue une trace collective visible de l'évolution du groupe.

Pour aller plus loin

13.11.1 Lectures obligatoires

- Tronto, J. C. (2013). *Caring Democracy. Markets, Equality, and Justice*. New York University Press (Conclusion : « Democracy as Care »).
- Inclusion Handicap (2026). *Prise de position sur l'initiative « Pour l'inclusion » et le contre-projet indirect du Conseil fédéral*. Berne : Inclusion Handicap.

13.11.2 Lectures complémentaires

- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action*. Basic Books (chap. 1).
- Brasseur, P. (2024). *L'assistance sexuelle aux personnes handicapées*. Presses Universitaires de France (Conclusion).
- Noddings, N. (2003). *Caring : A Feminine Approach to Ethics and Moral Education* (2e éd.). University of California Press (Introduction).
- Held, V. (2006). *The Ethics of Care. Personal, Political, and Global*. Oxford University Press (chap. 1).

13.11.3 Ressources en ligne

- Inclusion Handicap — [Initiative « Pour l'inclusion » : dossier et prise de position](#) : documents officiels, état des travaux parlementaires et position de l'organisation faîtière.
- Comité ONU des droits des personnes handicapées — [Observations finales sur la Suisse \(2022\)](#) : rapport complet des recommandations adressées à la Suisse au titre de la CDPH.
- Schön, D. A. — [Présentation du concept de praticien réflexif](#) (en anglais) : synthèse accessible des concepts de réflexion-en-action et réflexion-sur-l'action.

14 Références bibliographiques

Références

- Astier, I. (2007). *Les nouvelles règles du social*. Presses Universitaires de France.
- Bonvin, J.-M., & Farvaque, N. (2008). Travail et formation à l'épreuve des capacités. In *Formation Emploi* (Vol. 98, p. 9-23).
- Brasseur, P. (2024). *Sociologie de l'assistance sexuelle : former et transformer la sexualité*. Presses Universitaires de France.
- Cudré-Mauroux, A., Piérart, G., & Vaucher, C. (2020). *Co-construire l'autodétermination au quotidien*. Éditions ies.
- Ebersold, S. (2005). *L'invention du handicap : la normalisation de l'infirm*e. Éditions du CTNERHI.
- Garland-Thomson, R. (2011). Misfits : A Feminist Materialist Disability Concept. *Hypatia*, 26(3), 591-609. <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2011.01206.x>
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3-19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Ischer, P., Guerdat, P., Hugentobler, V., & Veyre, A. (2024). Vieillesse des personnes avec handicap dans les institutions socio-éducatives. *Revue suisse de travail social*, 32, 202-220. <https://doi.org/10.33058/szsa.2024.2344>
- Kittay, E. F. (1999). *Love's Labor : Essays on Women, Equality, and Dependency*. Routledge.
- Le Bossé, Y. (2003). De l'« habilitation » au « pouvoir d'agir » : vers une appréhension plus circonscrite de la notion d'empowerment. *Nouvelles pratiques sociales*, 16(2), 30-51.
- Morris, J. (1991). *Pride Against Prejudice : Transforming Attitudes to Disability*. The Women's Press.
- Pearson, C. (2000). Money Talks? Competing Discourses in the Implementation of Direct Payments. *Critical Social Policy*, 20(4), 459-477. <https://doi.org/10.1177/026101830002000402>
- Perske, R. (1972). The Dignity of Risk and the Mentally Retarded. *Mental Retardation*, 10(1), 24-27.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner : How Professionals Think in Action*. Basic Books.
- Stiker, H.-J. (2013). *Corps infirmes et sociétés : essais d'anthropologie historique* (3^e éd.). Dunod.
- Tabin, J.-P., Piecek, M., Probst, I., & Perrin, C. (2024). L'exclusion épistémique dans l'assurance-invalidité suisse. *Revue suisse de travail social*, 32, 46-68. <https://doi.org/10.33058/szsa.2024.2416>
- Tronto, J. C. (1993). *Moral Boundaries : A Political Argument for an Ethic of Care*. Routledge.
- Tronto, J. C. (2013). *Caring Democracy : Markets, Equality, and Justice*. New York University Press.
- Ville, I., Fillion, E., & Ravaud, J.-F. (2014). *Introduction à la sociologie du handicap : histoire, politiques et expérience*. De Boeck Supérieur.

14 *Références bibliographiques*

- Wehmeyer, M. L. (1999). Self-determination and the education of students with mental retardation. In *Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities* (Vol. 27, p. 302-314).